

Buku Ajar

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Erni Hernawati • Nurbaiti • Astin Nur Hanifah
Selpyani Sinulingga • Septiwiarsi • Ossie Happina Sari
Brivian Florentis Yustanta • Dhea Novita



BUKU AJAR

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PRAKTIK

KEBIDANAN

Penulis:

Bd. Erni Hernawati, SST., M.Keb., MM., Ph.D.

Nurbaiti, SKM., M.Kes.

Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Selpyani Sinulingga, SST., M.Kes.

Septiwiarsi, SST., M.Kes.

Ossie Happina Sari, S.Si.T., M. Kes.

Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes.

Dhea Novita, M.Tr.Keb.

BUKU AJAR KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis: Bd. Erni Hernawati, SST., M.Keb., MM., Ph.D.

Nurbaiti, SKM., M.Kes.

Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Selpyani Sinulingga, SST., M.Kes.

Septiwiarsi, SST., M.Kes.

Ossie Happina Sari, S.Si.T., M. Kes.

Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes.

Dhea Novita, M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-46-3

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan ini berhasil disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan mendalam dalam praktik kebidanan akan keterampilan komunikasi yang efektif dan empati. Mengingat peran komunikasi sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik antara bidan dengan pasien maupun kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, buku ini mengupas berbagai metode, teknik, media komunikasi, serta tantangan komunikasi dalam berbagai situasi klinis maupun sosial yang khusus dihadapi oleh tenaga bidan.

Dalam penyusunannya, buku ini diawali dengan konsep komunikasi efektif menggunakan metode SBAR dan TBaK yang menjadi dasar kolaborasi interprofesional. Selanjutnya, pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang unsur-unsur komunikasi efektif, teknik-teknik penerapannya, serta perbedaan penggunaan media komunikasi tradisional dan modern dalam praktik kebidanan. Aspek psikologi komunikasi yang mencakup penghargaan, penghormatan, dan empati juga dijelaskan untuk membantu bidan dalam memberikan pelayanan yang manusiawi dan berkualitas kepada klien dan keluarganya.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini menjadi pedoman yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, tenaga pengajar, dan praktisi kebidanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui komunikasi yang efektif. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi-edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN METODE SBAR DAN TBAK	1
A. Konsep dan Penerapan Metode SBAR	3
B. Teknik Komunikasi dengan Pendekatan TbaK	6
C. Integrasi SBAR dan TBAK dalam Praktik Kolaboratif.....	10
D. Latihan	13
E. Rangkuman Materi.....	14
F. Glosarium	15
G. Daftar Pustaka	17
BAB 2 KONSEP KOMUNIKASI EFEKTIF	19
A. Pengertian Komunikasi Efektif	22
B. Unsur-Unsur Komunikasi Efektif	22
C. Jenis dan Macam Komunikasi Efektif	23
D. Hukum Komunikasi Eektif.....	24
E. Teknik Komunikasi Efektif.....	24
F. Syarat-syarat Komunikasi Efektif.....	25
G. Latihan Soal	26
H. Rangkuman Materi	28
I. Glosarium	29
J. Daftar Pustaka	29
BAB 3 MEDIA KOMUNIKASI (TRADISIONAL VS MODERN)	31
A. Media Komunikasi Tradisional	33
B. Media Komunikasi Modern.....	35
C. Pemilihan Media Komunikasi yang Efektif.....	37
D. Latihan Soal	39
E. Rangkuman Materi	42
F. Glosarium	43
G. Daftar Pustaka	45

BAB 4 PSIKOLOGI KOMUNIKASI: MENGHARGAI DAN MENGHORMATI DALAM KOMUNIKASI, EMPATI DALAM KOMUNIKASI	47
A. Menghargai dan Menghormati dalam Komunikasi	49
B. Empati dalam Komunikasi	50
C. Latihan Soal	52
D. Rangkuman Materi	55
E. Glosarium	56
F. Daftar Pustaka	58
 BAB 5 INDIKATOR KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI	59
A. Pengertian dan Urgensi Indikator Keterampilan Komunikasi	61
B. Indikator Komunikasi Verbal	62
C. Indikator Komunikasi Nonverbal	64
D. Indikator Keterampilan Mendengarkan Aktif	66
E. Indikator Empati dan Pendekatan Emosional	68
F. Latihan Soal	70
G. Rangkuman Materi	73
H. Glosarium	74
I. Daftar Pustaka	76
 BAB 6 EVALUASI KOMUNIKASI: JENIS EVALUASI DALAM KOMUNIKASI, TEKNIK DAN METODE EVALUASI, PROSES EVALUASI	77
A. Jenis Evaluasi dalam Komunikasi	79
B. Teknik dan Metode Evaluasi	81
C. Proses Evaluasi	83
D. Latihan Soal	85
E. Rangkuman Materi	87
F. Glosarium	89
G. Daftar Pustaka	91
 BAB 7 TANTANGAN KOMUNIKASI DALAM KEADAAN SPESIFIK (BERDUKA DAN KEHILANGAN, ABUSE, KEADAAN KLINIS AKUT, KELOMPOK MINORITAS)	93
A. Definisi Hambatan Komunikasi	95
B. Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi	95
C. Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi	96
D. Cara Mengatasi Tantangan Komunikasi	98
E. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Berduka dan Kehilangan	100

F. Tantangan Komunikasi dalam keadaan Abuse	101
G. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Klinis Akut.....	102
H. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Kelompok Minoritas	103
I. Rangkuman Materi	104
J. Latihan Soal	106
K. Rangkuman Materi	109
L. Glosarium	109
M. Daftar Pustaka	110

BAB 8 SOSIAL MEDIA DAN KERAHASIAAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN .111

A. Media Sosial dalam Praktik Kebidanan: Peluang dan Risiko	113
B. Prinsip Kerahasiaan Informasi Pasien.....	114
C. Strategi Menjaga Kerahasiaan dalam Era Digital	116
D. Latihan Soal	118
E. Rangkuman Materi	121
F. Glosarium	123
G. Daftar Pustaka	125

PROFIL PENULIS127

BAB 1

KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN METODE SBAR DAN TBAK

Tujuan Instruksional :

- Memahami dan menerapkan metode komunikasi SBAR dalam pelaporan klinis.
- Menguasai teknik komunikasi efektif dengan pendekatan TBAK saat memberikan pelayanan antenatal dan postnatal.
- Mengintegrasikan kedua metode dalam praktik kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Capaian Pembelajaran:

- Menjelaskan konsep dan manfaat metode SBAR dalam konteks pelayanan kesehatan.
- Menjelaskan prinsip dasar dan penerapan teknik komunikasi TBAK.
- Mampu mengintegrasikan SBAR dan TBAK dalam pelaporan, edukasi, dan dokumentasi pelayanan.
- Mampu melakukan simulasi komunikasi profesional berbasis SBAR dan TBAK dalam studi kasus nyata.

Pendahuluan:

Komunikasi efektif merupakan fondasi utama dalam praktik pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Dalam lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tekanan, tenaga kesehatan dituntut tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga keterampilan komunikasi yang handal. Kesalahan komunikasi antarprofesi terbukti menjadi salah satu penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan komunikasi yang terstruktur dan empatik sangat dibutuhkan dalam interaksi klinis sehari-hari.

Dua metode komunikasi yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas koordinasi layanan kesehatan adalah SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dan TBAK (Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi). SBAR menyediakan kerangka komunikasi yang terstruktur untuk menyampaikan informasi penting dengan cara yang ringkas, jelas, dan logis, khususnya dalam kondisi klinis yang menuntut keputusan cepat dan tepat. Di sisi lain, TBAK merupakan pendekatan

komunikasi interpersonal yang menitikberatkan pada keterbukaan, saling percaya, serta pemahaman terhadap sudut pandang pasien melalui kegiatan bertanya dan mendengarkan secara aktif.

Integrasi kedua pendekatan ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang kolaboratif, baik antar tenaga kesehatan maupun antara tenaga kesehatan dengan pasien. Ketika SBAR dan TBaK digunakan secara konsisten, maka proses pelaporan, rujukan, edukasi, serta dokumentasi klinis akan menjadi lebih efektif, mengurangi potensi miskomunikasi, dan meningkatkan keselamatan serta kepuasan pasien.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep dan penerapan metode SBAR serta teknik komunikasi TBaK yang dapat digunakan dalam berbagai situasi klinis. Pembahasan akan dilengkapi dengan contoh, simulasi, dan strategi pengintegrasian keduanya dalam praktik kolaboratif di lapangan.

Secara khusus, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa atau tenaga kesehatan diharapkan mampu:

- Memahami pentingnya komunikasi terstruktur dan empatik dalam pelayanan klinis.
- Menerapkan metode SBAR dalam pelaporan dan rujukan antarprofesi secara tepat.
- Menggunakan pendekatan TBaK dalam memberikan edukasi, konseling, dan interaksi dengan pasien.
- Mengintegrasikan SBAR dan TBaK dalam proses komunikasi tim untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Sub Bab ini akan dibagi menjadi tiga topik utama:

- A. Topik I: Konsep dan Penerapan Metode SBAR
- B. Topik II: Teknik Komunikasi dengan Pendekatan TBaK
- C. Topik III: Integrasi SBAR dan TBaK dalam Praktik Kolaboratif

Melalui pemahaman terhadap isi bab ini, diharapkan tenaga kesehatan mampu bertransformasi menjadi komunikator yang efektif, yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga mampu membangun relasi yang kuat dalam tim dan dengan pasien. Hal ini pada akhirnya akan mendorong tercapainya pelayanan kesehatan yang responsif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

A. Konsep dan Penerapan Metode SBAR

1. Pengertian SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*)

Metode komunikasi SBAR merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi pasien secara sistematis, sehingga dapat menunjang peningkatan keselamatan pasien (JCI, 2010). Pada tahun 2007, WHO merekomendasikan agar seluruh negara anggotanya mengadopsi metode komunikasi standar yang strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, khususnya saat pergantian shift atau serah terima (*handover*). Salah satu metode efektif yang dapat digunakan yaitu SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), sebuah sistem komunikasi yang mudah diingat dan digunakan dalam menyampaikan informasi terkait pasien yang berada dalam kondisi kritis atau membutuhkan penanganan segera.

Metode SBAR terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu:

S (Situation): memberikan gambaran awal mengenai identitas pasien, kondisi saat ini, dan hasil diagnosis medis yang relevan.

B (Background): menjelaskan latar belakang atau riwayat kesehatan pasien yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.

A (Assessment): menyampaikan analisis atau penilaian terhadap kondisi pasien berdasarkan data yang ada.

R (Recommendation): mengusulkan tindakan, saran, atau rencana perawatan lanjutan yang perlu segera dilakukan.

Metode ini dirancang untuk memperkuat komunikasi dalam situasi yang berisiko tinggi, terutama antara tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Konsep SBAR pertama kali dikembangkan oleh pakar keselamatan pasien dari California dan diperkenalkan ke dunia kesehatan sebagai pendekatan komunikasi yang sistematis dan terstruktur (The Joint Commission International, 2010 dalam Oxyandi & Endayni, 2020).

Menurut penelitian Christina dan Susilo (2021), bahwa metode SBAR dapat membantu tenaga kesehatan dalam menyusun dan menyampaikan informasi penting dengan cara yang terorganisir, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan komunikasi yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Selain itu, Safitri et al. (2022) menekankan bahwa komunikasi yang efektif melalui metode SBAR dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi kesalahan yang terjadi selama tindakan medis. Penggunaan metode SBAR telah

diimplementasikan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan terbukti meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan.

2. Tujuan penggunaan SBAR dalam praktik klinik

a. Meningkatkan Keselamatan Pasien

Metode komunikasi SBAR dirancang untuk mengurangi kesalahan komunikasi yang dapat membahayakan pasien. Dengan struktur yang jelas, SBAR membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi penting secara sistematis, sehingga meningkatkan keselamatan pasien.

b. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarprofesi

SBAR memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan format yang terstandarisasi, informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas dan efisien, mengurangi potensi miskomunikasi.

c. Meningkatkan Kepuasan Kerja Tenaga Kesehatan

Penggunaan SBAR dalam serah terima pasien membantu perawat merasa lebih percaya diri dan puas dalam menjalankan tugasnya. Struktur komunikasi yang jelas memudahkan perawat dalam menyampaikan informasi, sehingga meningkatkan kepuasan kerja.

d. Memberikan Kerangka Kerja yang Jelas dalam Serah Terima Pasien

SBAR menyediakan panduan yang terstruktur untuk serah terima pasien, memastikan bahwa semua informasi penting disampaikan secara lengkap dan sistematis. Hal ini membantu dalam mengurangi informasi yang terlewat dan meningkatkan kualitas perawatan.

e. Mengurangi Risiko Kejadian Tidak Diinginkan

Dengan komunikasi yang lebih terstruktur dan jelas, SBAR membantu mengurangi risiko kejadian tidak diinginkan yang disebabkan oleh kesalahan komunikasi, seperti pemberian obat yang salah atau tindakan medis yang tidak sesuai.

3. Contoh format SBAR dalam pelaporan dan rujukan

FORMULIR SBAR (Situation, Background, Assesment, Recommendation)			
S	Situation	Nama Pasien : _____ Umur : _____ DPJP : _____ Diagnosis masuk : _____ Keluhan saat ini : _____	Ruangan : _____ Nomor MR : _____ Tanggal masuk : _____
B	Background	Riw. Penyakit Dahulu : _____ Alergi : _____ Terapi dari DPJP : _____	
A	Assesment	Kesadaran : _____ TD : _____ Nadi : _____ Nafas : _____ Suhu : _____	
R	Recommendation	Tindakan (Asuhan Keperawatan) yang sudah dilakukan : _____ Instruksi/Order Dokter : _____ _____ _____	
Tanggal/Jam : _____		Yang melapor : _____	Yang menerima laporan : _____ Saksi : _____

Gambar 1.1: Contoh format SBAR dalam pelaporan dan rujukan

Tabel 1.1: Format SBAR

S – Situation (Situasi)	Identitas Pasien: Nama: Ny. S Umur: 32 tahun Nomor RM: 001256 Ruangan: Kebidanan / Ruang Bersalin Situasi saat ini: Pasien mengalami peningkatan tekanan darah 160/100 mmHg disertai sakit kepala dan pandangan kabur sejak 2 jam yang lalu.
B – Background (Latar Belakang)	Riwayat Kehamilan / Medis: G2P1A0, kehamilan 36 minggu Riwayat hipertensi dalam kehamilan sebelumnya Tidak ada alergi obat Terapi saat ini : metildopa 3x sehari.

	Tindakan yang telah dilakukan: • Pemeriksaan tekanan darah berkala • Observasi tanda-tanda preeklamsia • Pasien diposisikan berbaring lateral kiri • Edukasi pasien dan keluarga dilakukan
A – Assessment (Penilaian)	Tekanan darah meningkat, pasien menunjukkan gejala preeklamsia ringan. Keadaan umum baik, kesadaran compos mentis, belum ada kontraksi, denyut jantung janin normal.
R – Recommendation (Rekomendasi)	• Mohon evaluasi lebih lanjut oleh dokter spesialis kandungan • Pertimbangan pemberian anti-hipertensi tambahan • Rujuk ke rumah sakit rujukan bila tekanan darah tidak menurun dalam 1 jam • Rekomendasi observasi ketat di ruangan kebidanan

Format SBAR ini bisa digunakan secara tertulis maupun lisan saat *shift handover*, laporan pasien gawat, atau proses rujukan. Dalam praktik profesional, form SBAR dapat dikembangkan dalam bentuk digital (misalnya sistem EMR) atau manual, sesuai kebutuhan fasilitas layanan kesehatan.

B. Teknik Komunikasi dengan Pendekatan TbaK

1. Pengertian TBAK (Terbuka, Bertanya, Aktif mendengarkan, Klarifikasi)

Pendekatan TBAK merupakan teknik komunikasi interpersonal yang terdiri dari empat komponen utama:

- Terbuka:** Bersikap reseptif terhadap pendapat, keluhan, atau informasi dari pasien tanpa prasangka, yang penting dalam membangun kepercayaan dan rasa aman.
- Bertanya:** Mengajukan pertanyaan terbuka maupun tertutup secara tepat untuk menggali informasi secara menyeluruh.
- Aktif Mendengarkan:** Memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, disertai respons verbal maupun non-verbal yang menunjukkan ketertarikan dan empati.
- Klarifikasi:** Mengonfirmasi ulang informasi yang disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman, serta memastikan bahwa pesan yang diterima benar dan sesuai konteks.

Pendekatan ini efektif diterapkan dalam konteks pelayanan kesehatan, di mana komunikasi yang empatik dan akurat sangat mempengaruhi kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Sikap terbuka dan mendengarkan secara aktif membantu tenaga kesehatan dalam memahami kondisi emosional dan fisik pasien, yang sering kali dipengaruhi oleh perubahan hormon, stres, dan kecemasan. Penerapan TBAK tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dan pasien, tetapi juga berdampak pada kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien.

Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dengan pendekatan TBAK, diperlukan latihan dan simulasi secara berkala, baik dalam bentuk role play maupun studi kasus. Pelatihan komunikasi menggunakan pendekatan TBAK bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas tenaga kesehatan terhadap kebutuhan pasien, memperkuat keterampilan komunikasi interpersonal, serta mengurangi potensi konflik atau miskomunikasi selama proses perawatan.

2. Penerapan TBAK dalam pelayanan antenatal dan postnatal

Pendekatan TBAK (Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi) merupakan strategi komunikasi interpersonal yang sangat penting diterapkan oleh tenaga kesehatan, terutama bidan dan perawat, dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil (antenatal) dan ibu pascamelahirkan (postnatal). Pendekatan ini tidak hanya membantu membangun hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien serta memastikan informasi yang diberikan akurat dan lengkap.

Penerapan TBAK dalam Pelayanan Antenatal

Terbuka: Bidan menyambut ibu hamil dengan sikap ramah dan terbuka, serta menunjukkan ketertarikan terhadap kondisi pasien tanpa menghakimi.

Contoh: "Silakan Bu, saya siap mendengarkan. Apa saja yang Ibu rasakan selama minggu ini?"

Bertanya: Menggali informasi lebih dalam terkait keluhan atau perubahan yang dirasakan pasien selama kehamilan.

Contoh: "Apakah Ibu mengalami mual yang berlebihan atau nyeri saat buang air kecil?"

Aktif Mendengarkan: Mendengarkan keluhan pasien dengan kontak mata, anggukan, dan tidak memotong pembicaraan.

Contoh: Bidan mencatat keluhan pasien sambil sesekali mengangguk dan memberikan tanggapan empatik seperti "Saya paham, Bu, pasti cukup mengganggu ya."

Klarifikasi: Mengonfirmasi kembali apa yang sudah disampaikan pasien untuk menghindari kesalahan diagnosis atau interpretasi.

Contoh: "Jadi Ibu merasa nyeri di bagian bawah perut sejak tiga hari yang lalu, betul ya?"

Penerapan TBaK dalam Pelayanan Postnatal

Terbuka: Memberikan ruang kepada ibu untuk bercerita tentang pengalaman persalinan dan kondisi bayi.

Contoh: "Bagaimana perasaan Ibu setelah proses persalinan kemarin? Boleh diceritakan?"

Bertanya: Menanyakan aspek penting pascamelahirkan, seperti menyusui, luka jahitan, dan kondisi psikologis.

Contoh: "Bagaimana proses menyusui? Apakah ada rasa nyeri atau kesulitan?"

Aktif Mendengarkan: Menyimak secara saksama setiap cerita pasien dan menunjukkan perhatian.

Contoh: Tidak tergesa-gesa saat mendengarkan, serta memberikan umpan balik yang menunjukkan empati.

Klarifikasi: Memastikan pemahaman tentang kondisi ibu dan bayi agar tindakan medis atau edukasi lanjutan tepat sasaran.

Contoh: "Ibu menyebutkan bahwa bayi tidak sering buang air kecil, apakah itu terjadi sejak pulang dari rumah sakit?"

Manfaat Penerapan TBaK:

1. Meningkatkan kepercayaan ibu terhadap tenaga kesehatan.
2. Mencegah kesalahpahaman dalam diagnosis dan penanganan.
3. Memberikan edukasi yang lebih tepat sasaran dan dapat dipahami pasien.
4. Memperkuat kualitas pelayanan maternal dan neonatal.

3. Simulasi dan latihan penerapan TbaK

Simulasi penerapan metode TBaK (Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi) bertujuan untuk melatih tenaga kesehatan, terutama bidan dan perawat, agar dapat membangun komunikasi interpersonal yang efektif dan empatik dengan pasien. Latihan ini penting untuk:

- a. Mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik.
- b. Meningkatkan kepekaan terhadap ekspresi verbal dan nonverbal pasien.
- c. Mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan akurasi informasi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Bentuk Simulasi:

- a. Role Play (Bermain Peran)

Tenaga kesehatan dilatih dengan memainkan peran sebagai bidan/perawat dan pasien (ibu hamil atau pascamelahirkan) untuk mensimulasikan interaksi nyata dalam pelayanan.

Contoh Skenario Antenatal Care:

- Situasi: Ibu hamil usia kehamilan 28 minggu datang dengan keluhan sulit tidur dan merasa cemas.
- Instruksi untuk Bidan:
 - Sambut pasien dengan sikap terbuka.
 - Ajukan pertanyaan terbuka mengenai keluhan dan perasaannya.
 - Gunakan komunikasi nonverbal yang mendukung (kontak mata, nada suara lembut).
- Dengarkan secara aktif dan klarifikasi keluhan untuk menentukan tindakan lanjutan.

Dialog Singkat Role Play:

Bidan: "Selamat siang, Bu. Saya senang Ibu bisa datang hari ini. Apa yang Ibu rasakan belakangan ini?"

Pasien: "Saya susah tidur, Bu. Rasanya gelisah terus."

Bidan: "Saya paham, Bu. Sejak kapan keluhan ini muncul? Apa yang biasanya Ibu pikirkan saat mau tidur?"

(Bidan mencatat dan menanggapi dengan empati, lalu mengklarifikasi kembali untuk menyusun rencana edukasi)

b. Debriefing dan Umpan Balik

Setelah simulasi, fasilitator memberikan umpan balik tentang:

- Ketepatan penggunaan teknik TBaK.
- Kekuatan komunikasi yang dilakukan.
- Area yang perlu ditingkatkan (misalnya: pertanyaan terlalu tertutup, atau kurang klarifikasi).

c. Diskusi Reflektif

Peserta latihan diajak untuk:

- Menceritakan bagaimana perasaan mereka saat berperan.
- Menilai dampak pendekatan komunikasi terhadap kualitas interaksi.
- Menyusun strategi perbaikan dari pengalaman simulasi.

Evaluasi Keterampilan TBaK

Penggunaan lembar observasi atau checklist dapat membantu mengevaluasi keberhasilan penerapan TBaK saat simulasi. Kriteria yang dinilai:

- Apakah tenaga kesehatan menyapa dengan terbuka?
- Apakah mengajukan pertanyaan eksploratif?
- Apakah menunjukkan sikap aktif mendengarkan?

- Apakah melakukan klarifikasi dengan benar?

C. Integrasi SBAR dan TBaK dalam Praktik Kolaboratif

1. Menggabungkan SBAR dalam pelaporan antarprofesi

SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) berperan penting dalam pelaporan antarprofesi karena mampu:

- Menstandarisasi komunikasi agar lebih singkat, padat, dan jelas.
 - Mengurangi risiko miskomunikasi, terutama dalam kondisi kritis.
 - Memfasilitasi pengambilan keputusan cepat berbasis informasi yang tepat.
- Contoh Aplikasi: Seorang perawat melaporkan kondisi pasien pasca operasi kepada dokter:

S (Situation): "Pasien atas nama Ny. R, usia 54 tahun, post operasi histerektomi 6 jam lalu."

B (Background): "Pasien memiliki riwayat hipertensi dan saat ini sedang dalam pemantauan pascaoperasi."

A (Assessment): "Tekanan darah pasien menurun menjadi 90/60 mmHg, nadi 110 kali/menit, kulit dingin."

R (Recommendation): "Mohon evaluasi segera dan kemungkinan pemberian cairan tambahan atau tindakan lanjutan."

Dengan SBAR, komunikasi menjadi terfokus dan efisien, sangat penting dalam konteks shift malam, rujukan, atau kondisi emergensi

2. Menggunakan TBaK saat edukasi dan konseling kepada pasien

TBaK (Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi) sangat berguna dalam meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien/keluarga. Penerapannya mencakup:

- Membangun hubungan yang terbuka dan tidak menghakimi.
- Menggali kebutuhan dan persepsi pasien secara aktif.
- Mendengarkan secara penuh sebelum memberikan edukasi.
- Memastikan pasien memahami informasi melalui klarifikasi.

Contoh Penerapan:

Saat konseling laktasi

Tenaga kesehatan: "Ibu, boleh saya tahu bagaimana pengalaman Ibu menyusui sampai saat ini?"

(Terbuka dan bertanya)

"Baik, jadi Ibu merasa kesulitan karena bayi tidak mau menyusu lama ya? Saya dengarkan, dan kita akan cari solusi bersama."

(Aktif mendengarkan)

"Jadi, Ibu maksudkan bayi hanya menyusui sebentar lalu tertidur, benar begitu?"
(Klarifikasi)

Dengan pendekatan ini, komunikasi tidak hanya informatif, tetapi juga suportif dan mendorong partisipasi aktif pasien dalam pengambilan keputusan.

3. Praktik dokumentasi dan pelaporan kolaboratif

Dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang kompleks dan dinamis, komunikasi efektif antarprofesi menjadi kunci utama dalam memberikan perawatan yang aman dan berkualitas. Integrasi metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan pendekatan komunikasi interpersonal TBaK (Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi) terbukti mampu memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan, baik antara dokter, perawat, bidan, maupun tenaga pendukung lainnya.

Keterpaduan antara SBAR dan TBaK tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal antarprofesi. SBAR menyediakan kerangka komunikasi yang terstruktur dan sistematis, sementara TBaK menghidupkan komunikasi tersebut dengan pendekatan yang empatik, terbuka, dan responsif terhadap dinamika emosional serta kebutuhan psikologis masing-masing pihak.

Contoh Integrasi dalam Praktik:

Seorang bidan yang ingin melaporkan kondisi pasien kepada dokter kandungan dapat mengintegrasikan pendekatan SBAR dan teknik TBaK untuk memastikan komunikasi berlangsung secara efektif, empatik, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Berikut contoh langkah-langkah integratif dalam praktik kebidanan:

1. **Terbuka (T)** – Bidan memulai percakapan dengan sikap terbuka, sopan, dan membangun suasana komunikasi yang profesional namun nyaman.
Contoh: *"Selamat pagi, Dok. Mohon izin melaporkan kondisi ibu hamil atas nama Ny. R. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk berdiskusi sebentar?"*
2. **Situation (S)** – Bidan menyampaikan kondisi pasien secara singkat, jelas, dan langsung pada inti permasalahan.
"Pasien Ny. R, usia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, mengalami kontraksi setiap 5 menit, disertai perdarahan pervaginam sedang selama 30 menit terakhir."
3. **Background (B)** – Memberikan informasi latar belakang medis dan riwayat kehamilan yang relevan.

- | *"Pasien memiliki riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan sejak pagi tadi."*
4. **Bertanya (B)** – Bidan mengajukan pertanyaan terbuka yang menunjukkan kesiapan untuk mendiskusikan keputusan klinis Bersama dokter.
 | *"Apakah perlu segera dilakukan rujukan ke fasilitas rujukan tingkat lanjut atau kita observasi dulu di sini, Dok?"*
 5. **Assessment (A)** – Bidan menyampaikan penilaian profesionalnya berdasarkan observasi dan data klinis.
 | *"Dari hasil pemeriksaan, kami menilai kemungkinan terjadi plasenta previa berulang dengan perdarahan aktif. Tanda vital stabil, namun jumlah perdarahan bertambah."*
 6. **Aktif Mendengarkan (aM)** – Saat dokter memberikan instruksi atau saran, bidan mendengarkan dengan seksama, tidak memotong pembicaraan, mencatat arahan, dan menunjukkan ekspresi serta bahasa tubuh yang aktif dan suportif.
 7. **Recommendation (R)** – Bidan memberikan usulan atau permintaan persetujuan tindakan selanjutnya.
 | *"Kami merekomendasikan rujukan segera ke RSUD karena keterbatasan fasilitas penanganan obstetri emergensi di puskesmas ini."*
 8. **Klarifikasi (K)** – Mengulangi poin penting untuk memastikan kesamaan pemahaman.
 | *"Baik, Dok. Jadi kita akan rujuk Ny. R ke RSUD sekarang juga. Saya akan dampingi pasien dan siapkan dokumen serta laporan medis lengkapnya."*

Manfaat Integrasi SBAR dan TBaK dalam Tim Kesehatan

Penggabungan dua pendekatan ini dalam praktik kolaboratif menghasilkan berbagai manfaat yang signifikan:

1. **Meningkatkan Keselamatan Pasien**
 - Komunikasi yang akurat dan empatik mencegah kesalahan medis dan meningkatkan respons cepat terhadap kondisi pasien.
2. **Memperkuat Kolaborasi Antarprofesi**
 - Membangun saling percaya, memperjelas tanggung jawab, dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dan profesional.
3. **Meningkatkan Kepuasan Kerja**
 - Tenaga kesehatan merasa didengar dan dihargai, sehingga motivasi dan kepuasan dalam bekerja meningkat.
4. **Efisiensi dalam Pengambilan Keputusan**

- Informasi yang tersampaikan secara terstruktur dan empatik mempermudah pimpinan klinik atau dokter dalam mengambil keputusan yang tepat.

5. **Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**

- Interaksi profesional yang didasari komunikasi efektif berdampak pada pelayanan yang holistik dan berorientasi pada pasien.

Strategi Implementasi SBAR-TBaK di Institusi Kesehatan

Untuk menerapkan integrasi SBAR dan TBaK secara optimal, institusi kesehatan dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- Pelatihan rutin dan simulasi berbasis kasus klinis.
- Penggunaan form atau aplikasi digital SBAR yang disesuaikan dengan konteks klinik.
- Pendampingan peer-to-peer dan pembentukan mentor komunikasi klinis.
- Evaluasi berkala melalui audit komunikasi dan refleksi tim.
- Menerapkan budaya komunikasi terbuka dalam struktur organisasi.

D. Latihan

Pilihan Ganda

1. Apa tujuan utama dari penggunaan metode komunikasi SBAR dalam praktik klinis?
 - A. Menyederhanakan prosedur administrasi pelayanan pasien
 - B. Meningkatkan keterampilan negosiasi tenaga kesehatan
 - C. Mengurangi risiko kesalahan komunikasi dalam penanganan pasien
 - D. Meningkatkan jumlah pasien yang ditangani dalam satu shift
 - E. Menggantikan metode konsultasi dokter secara langsung
2. Dalam metode SBAR, bagian Background (B) digunakan untuk menyampaikan?
 - A. Hasil analisis kondisi pasien secara medis
 - B. Saran atau rencana perawatan lanjutan
 - C. Identitas dan kondisi pasien saat ini
 - D. Riwayat kesehatan pasien yang relevan
 - E. Instruksi dari dokter yang sebelumnya menangani pasien
3. Komponen "Aktif Mendengarkan" dalam pendekatan TBaK berperan penting untuk?
 - A. Mengarahkan pasien agar mengikuti instruksi
 - B. Memastikan semua prosedur dilakukan sesuai protokol
 - C. Menunjukkan empati dan memahami keluhan pasien secara mendalam

- D. Mempersingkat waktu konsultasi dengan pasien
- E. Memberikan klarifikasi terhadap instruksi medis yang salah
- 4. Penerapan metode SBAR dan pendekatan TBaK secara terintegrasi dapat membantu dalam...
 - A. Menghapus kebutuhan dokumentasi tertulis
 - B. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi dalam tim kesehatan
 - C. Mengurangi beban kerja tenaga kesehatan secara signifikan
 - D. Menggantikan sistem informasi rumah sakit secara menyeluruh
 - E. Meningkatkan efektivitas promosi kesehatan di media sosial
- 5. Sikap "Terbuka" dalam pendekatan TBaK paling tepat ditunjukkan dengan...
 - A. Memberikan nasihat kepada pasien secara langsung
 - B. Menghindari pembicaraan yang tidak penting
 - C. Memberi ruang bagi pasien untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut
 - D. Menanyakan keluhan pasien hanya jika diminta
 - E. Memberi klarifikasi sebelum pasien selesai berbicara

Essay

1. Jelaskan lima tahapan dalam proses konseling kebidanan!
2. Apa fungsi metode SBAR dalam komunikasi klinis?
3. Sebutkan dan jelaskan keempat komponen dalam TBaK!
4. Bagaimana cara menerapkan TBaK saat memberi konseling kepada ibu hamil dengan anemia?
5. Buatlah contoh komunikasi SBAR dalam situasi rujukan kasus preeklamsia berat!

Kunci Jawaban

1. C
2. D
3. C
4. B
5. C

E. Rangkuman Materi

Dalam praktik kebidanan, komunikasi yang efektif tidak hanya menjadi landasan pelayanan yang aman, tetapi juga menjadi jembatan penting antara bidan, pasien, dan tim kesehatan lainnya. Untuk itu, penguasaan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dan pendekatan TBaK (Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi) menjadi krusial. SBAR membantu bidan menyampaikan informasi medis secara cepat, jelas, dan sistematis, khususnya dalam situasi yang menuntut keputusan cepat atau saat koordinasi dengan dokter dan

tenaga medis lainnya. Misalnya, ketika terjadi komplikasi pada ibu hamil, penggunaan SBAR memudahkan bidan menjelaskan kondisi pasien, latar belakang medis, hasil penilaian klinis, serta rekomendasi tindakan lanjutan secara ringkas namun menyeluruh.

Sementara itu, pendekatan TBaK lebih ditekankan dalam proses konseling individual maupun keluarga, di mana hubungan emosional dan keterbukaan menjadi kunci keberhasilan komunikasi. Melalui sikap terbuka, bidan mampu menciptakan ruang aman bagi klien untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, mendengarkan secara aktif, dan melakukan klarifikasi, bidan dapat menggali informasi secara mendalam dan mencegah kesalahpahaman. TBaK menjadi sangat efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis informasi oleh ibu hamil, menyusui, maupun keluarganya.

Rangkuman materi ini juga menekankan pentingnya latihan komunikasi terstruktur dan empatik secara simultan. SBAR dan TBaK bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. SBAR memberikan kerangka komunikasi profesional yang sistematis, sedangkan TBaK memperkuat kualitas relasi interpersonal yang humanis. Oleh karena itu, dalam pelatihan kebidanan, kedua metode ini perlu diajarkan tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui praktik langsung seperti role play, simulasi kasus, hingga umpan balik terarah. Dengan menguasai kedua pendekatan tersebut, bidan dapat memberikan layanan yang tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga berpusat pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien, sehingga memperkuat kepercayaan dan kepuasan klien dalam setiap interaksi layanan kesehatan.

F. Glosarium

SBAR	:	Akronim dari Situation, Background, Assessment, Recommendation, yaitu metode komunikasi terstruktur dalam pelayanan klinis untuk menyampaikan informasi pasien secara singkat, jelas, dan sistematis.
Situation (Situasi)	:	Komponen pertama dalam metode SBAR yang menjelaskan identitas pasien dan kondisi klinis saat ini.
Background (Latar Belakang)	:	Komponen kedua dalam SBAR yang memuat riwayat medis atau informasi penting lainnya yang relevan dengan kondisi pasien.
Assessment (Penilaian)	:	Bagian ketiga dalam SBAR yang mencerminkan analisis atau interpretasi tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien berdasarkan data klinis.

Recommendation (Rekomendasi)	: Komponen terakhir dalam SBAR yang memuat saran atau rencana tindakan medis yang diperlukan.
TBaK	: Akronim dari Terbuka, Bertanya, Aktif Mendengarkan, Klarifikasi; pendekatan komunikasi interpersonal yang menekankan empati, keterbukaan, dan pemahaman menyeluruh terhadap pasien.
Terbuka	: Sikap komunikatif tanpa prasangka, menerima pendapat atau keluhan pasien secara ramah dan empatik.
Bertanya	: Teknik komunikasi dengan mengajukan pertanyaan (terbuka dan tertutup) untuk menggali informasi secara lebih lengkap.
Aktif Mendengarkan	: Keterampilan mendengarkan secara penuh dan fokus terhadap apa yang disampaikan pasien, disertai respons verbal dan non-verbal yang mendukung.
Klarifikasi	: Proses mengonfirmasi kembali informasi dari pasien agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah tafsir.
Komunikasi Efektif	: Proses penyampaian pesan secara jelas, empatik, dan tepat sasaran antara tenaga kesehatan dengan pasien atau antarprofesi dalam pelayanan kesehatan.
Handover (Serah Terima)	: Proses pemindahan tanggung jawab dan informasi penting mengenai pasien dari satu tenaga kesehatan ke tenaga lainnya, biasanya saat pergantian shift.
Pelayanan Antenatal	: Layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk memantau dan menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan.
Pelayanan Postnatal	: Layanan kesehatan setelah persalinan yang bertujuan memantau kesehatan ibu dan bayi serta memberikan dukungan pemulihan pascapersalinan.
Preeklamsia	: Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ, biasanya terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan.
Keselamatan Pasien	: Upaya sistematis dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah kesalahan dan efek samping yang dapat membahayakan pasien.
Komunikasi Kolaboratif	: Bentuk komunikasi antarprofesi yang saling menghargai peran masing-masing dan berfokus pada kepentingan pasien.
Edukasi Pasien	: Proses pemberian informasi dan pemahaman kepada pasien mengenai kondisi kesehatan, pengobatan, dan perawatan yang dibutuhkan.

Dokumentasi Klinis	:	Pencatatan sistematis informasi medis dan tindakan pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk kebutuhan legal dan evaluasi klinis.
Tenaga Kesehatan	:	Profesional yang memberikan layanan di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan lainnya.
Respons Verbal dan Nonverbal	:	Tanggapan dalam komunikasi yang melibatkan kata-kata (verbal) dan bahasa tubuh seperti kontak mata, anggukan, atau ekspresi wajah (nonverbal).

G. Daftar Pustaka

-
- Christina, L. V. (2021). Penggunaan metode SBAR untuk komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dalam konteks klinis. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 3(1), 57-63.
- Rahayu,S., Surianto., & Sintong H. (2023). Hubungan Penggunaan Metode Komukasi Efektif SBAR Dengan Pelaksanaan Timbang Terima (Handover) Di RSUD Anuntaloko Parigi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 222-227
- Rusdi, R., Tappi, N. H., Sulistyarini, W. D., Sirait, Y., & Hasanah, S. W. (2022). Gambaran penerapan komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) saat handover perawat. *Jurnal Keperawatan Wiyata*, 5(2), 176–181.
- Safitri, W., Suparmanto, G., & Istiningtyas, A. (2022). Analisis metode komunikasi SBAR (situation, background, assesment, recomendation) di instalasi gawat darurat. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 167-174.
- Siauta, V. A., Inayah, I., Rohayani, L., & Budiman, B. (2023). Gambaran pelaksanaan komunikasi SBAR dalam melakukan handover di pelayanan keperawatan rumah sakit. *PIN-LITAMAS*, 5(1), 45–52.
- WHO. (2023). *Effective Communication in Maternal Health Services: Training Guidelines*.
- Wijayanti, K., Astuti, V. A., & Fatmayanti, A. (2021). *Komunikasi dalam praktik kebidanan*. Trans Info Media.
- Wulandari, D. (2019). *Komunikasi dan konseling dalam praktik kebidanan*. Nuha

Medika

BAB 2

KONSEP KOMUNIKASI EFEKTIF

Pendahuluan

Dalam konteks tertentu, seperti kebidanan, komunikasi efektif memiliki makna yang lebih spesifik. Misalnya, dalam kebidanan, komunikasi efektif mencakup kemampuan bidan untuk berinteraksi dengan klien dan tim kesehatan lainnya secara jelas, empatik, dan profesional. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan informasi yang relevan dan akurat. Komunikasi efektif dalam kebidanan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan membangun hubungan yang baik dengan klien serta tim kesehatan lainnya.

Bab ini akan membahas tentang konsep komunikasi efektif pada pelayanan kebidanan. Tujuan utama komunikasi efektif adalah memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh penerima dan menghasilkan respons yang diharapkan. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi kebidanan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah definisi komunikasi efektif, unsur-unsur komunikasi efektif, jenis dan macam komunikasi efektif, hukum komunikasi efektif, teknik komunikasi efektif dan syarat komunikasi efektif. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif pada mahasiswa kebidanan dengan pasien berdasarkan teori dan praktik nyata.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh penerima, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman dan konflik.
2. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respons yang tepat

3. Mahasiswa mampu mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong dialog dan pemahaman yang lebih dalam dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
4. Mahasiswa mampu menyampaikan informasi yang kompleks mengajarkan cara menyederhanakan informasi yang rumit agar mudah dipahami oleh penerima.
5. Mahasiswa mampu membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan relevan yang disampaikan melalui komunikasi yang efektif.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa mampu memahami teori dan prinsip dasar komunikasi efektif dan bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi.
2. Mahasiswa mampu menggunakan teknik komunikasi efektif dalam situasi praktis.
3. Mahasiswa mampu menganalisis situasi komunikasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai teknik komunikasi untuk menciptakan strategi komunikasi yang efektif
5. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas komunikasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat.
2. Mahasiswa mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respons yang tepat.
3. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata secara efektif.
4. Mahasiswa mampu mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong dialog dan pemahaman yang lebih dalam.
5. Mahasiswa mampu memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun.

Afektif:

1. Mahasiswa mampu menerima pentingnya komunikasi efektif dalam membangun hubungan yang baik.
2. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap penerapan teknik komunikasi efektif.
3. Mahasiswa mampu menghargai pentingnya komunikasi efektif dalam berbagai konteks.
4. Mahasiswa mampu Mengintegrasikan nilai-nilai komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari.
6. Mahasiswa mampu Menjadikan komunikasi efektif sebagai bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari.

A. Pengertian Komunikasi Efektif

Kata "komunikasi" berasal dari bahasa Latin "communicatio," yang berarti "berbagi" atau "menyampaikan." Ini mencerminkan inti dari komunikasi itu sendiri, yaitu proses berbagi informasi, ide, atau perasaan antara dua pihak atau lebih. Komunikasi adalah dasar dari interaksi manusia dan memainkan peran penting dalam membangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bersama.

Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

B. Unsur-Unsur Komunikasi Efektif

Unsur-unsur komunikasi adalah elemen-elemen yang membentuk proses komunikasi sehingga pesan dapat disampaikan dan dipahami dengan baik yaitu:

1. Pengirim (Sender)

Orang atau pihak yang mengirimkan pesan. Pengirim bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan pesan dengan jelas.

2. Penyandian (Encoding)

Proses mengubah pikiran dan perasaan menjadi lambang atau simbol.

3. Pesan (Message)

Informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan harus disusun dengan baik agar dapat dipahami oleh penerima.

4. Saluran (Channel)

Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi bisa berupa lisan, tulisan, gambar, atau media elektronik.

5. Penerima (Receiver)

Orang atau pihak yang menerima pesan. Penerima bertanggung jawab untuk mendengarkan, membaca, atau melihat pesan dan memahaminya.

6. Penguraian (Decoding)

Proses penerima menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh pengirim.

7. Umpan Balik (Feedback)

Respons atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik membantu pengirim mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan benar.

8. Konteks (Context)

Situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima.

9. Gangguan (Noise)

Faktor-faktor yang dapat mengganggu atau menghalangi proses komunikasi. Gangguan bisa berupa suara bising, gangguan teknis, atau perbedaan bahasa.

C. Jenis dan Macam Komunikasi Efektif

Dalam kebidanan, komunikasi efektif sangat penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan membangun hubungan yang baik dengan klien. Berikut adalah beberapa jenis dan macam komunikasi efektif dalam kebidanan:

1. Komunikasi Verbal

Menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Ini termasuk percakapan langsung, telepon, dan komunikasi tertulis seperti pesan teks atau email. Komunikasi verbal harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh klien.

2. Komunikasi Non-Verbal

Menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan. Komunikasi non-verbal dapat memperkuat atau melemahkan pesan yang disampaikan secara verbal.

3. Komunikasi Interpersonal

Interaksi langsung antara bidan dan klien. Ini melibatkan mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan memberikan dukungan emosional kepada klien.

4. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi yang dirancang untuk membantu klien merasa didukung dan dipahami. Ini melibatkan penggunaan teknik seperti refleksi, validasi, dan pemberian umpan balik yang konstruktif.

5. Komunikasi Konseling

Memberikan bimbingan dan dukungan kepada klien dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Konseling yang baik melibatkan mendengarkan, memberikan informasi, dan membantu klien mengeksplorasi pilihan mereka.

6. Komunikasi Interprofesional

Berkomunikasi dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang holistik dan terkoordinasi. Komunikasi interprofesional membantu memastikan bahwa perawatan yang diberikan terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan klien.

D. Hukum Komunikasi Eektif

1. Respect (Menghormati)

Menghargai setiap individu adalah langkah awal komunikasi yang efektif. Ini tercermin dari cara kita mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi. Sikap respect juga dapat ditunjukkan melalui pemilihan kata dan bahasa tubuh yang tepat.

2. Empathy (Empati)

Empati berperan penting untuk memahami perspektif orang lain. Kemampuan menempatkan diri pada posisi lawan bicara membantu menciptakan koneksi yang lebih dalam dan memungkinkan kita memberikan respons yang lebih tepat dan penuh pengertian.

3. Audible (Dapat Didengar)

Pesan yang disampaikan harus dapat diterima dengan baik oleh penerima. Ini mencakup kejelasan suara, pemilihan waktu yang tepat, dan penggunaan media yang sesuai.

4. Clarity (Jelas)

Pesan yang disampaikan harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Pastikan tujuan dan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima.

5. Humble (Rendah Hati)

Sikap rendah hati dalam komunikasi berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan menjadi pendengar yang baik. Sikap ini tidak hanya menimbulkan rasa hormat, tetapi juga memberi kesan positif dalam menciptakan proses komunikasi yang efektif.

E. Teknik Komunikasi Efektif

Berikut adalah beberapa teknik komunikasi efektif yang dapat diterapkan:

1. Mendengarkan Aktif

Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda memahami dan menghargai apa yang disampaikan.

2. Menggunakan Bahasa yang Jelas dan Sederhana

Hindari penggunaan istilah yang rumit atau ambigu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima.

3. Memberikan Umpan Balik

Berikan respons atau reaksi terhadap pesan yang diterima. Umpan balik membantu memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar dan memungkinkan perbaikan jika diperlukan.

4. Mengajukan Pertanyaan Terbuka

Ajukan pertanyaan yang mendorong lawan bicara untuk berbicara lebih banyak tentang perasaan dan pemikiran mereka.

5. Menunjukkan Empati

Tunjukkan bahwa Anda memahami perasaan dan perspektif lawan bicara. Ini membantu membangun hubungan yang lebih baik dan membuat lawan bicara merasa dihargai.

6. Menggunakan Bahasa Tubuh yang Tepat

Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Bahasa tubuh yang terbuka dan ramah dapat memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal.

7. Mengatur Waktu yang Tepat

Pastikan waktu dan tempat untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan lawan bicara. Hindari mengganggu atau memaksakan komunikasi pada waktu yang tidak tepat.

8. Menggunakan Teknik Refleksi

Ulangi atau rangkum apa yang telah dikatakan oleh lawan bicara untuk memastikan pemahaman yang benar dan memberikan kesempatan bagi lawan bicara untuk mengoreksi atau menambahkan informasi.

F. Syarat-syarat Komunikasi Efektif

Berikut adalah syarat-syarat komunikasi efektif:

1. Kejelasan (Clarity): Pesan harus disampaikan dengan jelas dan tidak ambigu. Gunakan bahasa yang sederhana dan langsung agar penerima dapat memahami maksud pesan dengan mudah.
2. Konsistensi (Consistency): Pesan harus konsisten dan tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya. Ini membantu membangun kepercayaan dan menghindari kebingungan.
3. Keterbukaan (Openness): Komunikasi harus terbuka dan jujur. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan dialog dua arah dan mendorong penerima untuk memberikan umpan balik.
4. Empati (Empathy): Menunjukkan empati dalam komunikasi membantu membangun hubungan yang lebih baik dan membuat penerima merasa dihargai dan dipahami.

5. Mendengarkan Aktif (Active Listening): Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa Anda memahami dan menghargai apa yang disampaikan oleh penerima.
6. Kesesuaian Konteks (Context Appropriateness): Pesan harus disesuaikan dengan konteks dan situasi. Pertimbangkan latar belakang, budaya, dan kebutuhan penerima saat menyampaikan pesan.

G. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif?
 - a. Proses penyampaian pesan yang tidak jelas dan ambigu
 - b. Proses penyampaian pesan yang jelas, tepat, dan mudah dipahami
 - c. Proses penyampaian pesan yang hanya menggunakan bahasa tubuh
 - d. Proses penyampaian pesan tanpa umpan balik
 - e. Proses penyampaian Respons atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima
2. Apa yang dimaksud dengan umpan balik dalam komunikasi?
 - a. Pesan yang disampaikan oleh pengirim
 - b. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan
 - c. Proses penyampaian pesan yang hanya menggunakan bahasa tubuh
 - d. Proses penyampaian pesan tanpa umpan balik
 - e. pesan yang tidak jelas dan ambigu
3. Mengapa empati penting dalam komunikasi efektif?
 - a. Membantu membangun hubungan yang lebih baik
 - b. Membuat pesan menjadi lebih ambigu
 - c. Mengurangi kebutuhan untuk mendengarkan aktif
 - d. Menghindari penggunaan bahasa tubuh
 - e. Menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan
4. Apa yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal?
 - a. Menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan
 - b. Menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan
 - c. Menggunakan media elektronik untuk menyampaikan pesan
 - d. Menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan
 - e. Menggunakan pesan yang jelas, tepat dan mudah dipahami
5. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan aktif?
 - a. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respons yang menunjukkan pemahaman

- b. Mendengarkan tanpa memberikan respons
- c. Mendengarkan sambil melakukan aktivitas lain
- d. Mendengarkan hanya untuk mencari kesalahan
- e. Mendengarkan melalui media elektronik

Soal Essay

1. Seorang bidan sedang menangani seorang ibu hamil yang sangat cemas tentang proses persalinan. Ibu tersebut merasa takut dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya untuk melahirkan secara normal. Bagaimana bidan menerapkan konsep komunikasi efektif untuk membantu ibu tersebut?
2. Seorang bidan bekerja dalam tim kesehatan yang terdiri dari beberapa profesional medis. Ada ketidaksepahaman mengenai rencana perawatan untuk seorang pasien. Bagaimana bidan dapat menggunakan komunikasi efektif untuk menyelesaikan ketidaksepahaman ini?
3. Seorang ibu baru merasa kesulitan dalam merawat bayinya yang baru lahir dan merasa tidak percaya diri. Jenis komunikasi efektif apakah yang tepat digunakan untuk memberikan dukungan kepada ibu tersebut?
4. Seorang bidan sedang memberikan edukasi kepada sekelompok ibu hamil tentang pentingnya perawatan prenatal. Bagaimana bidan dapat menggunakan komunikasi efektif untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para ibu hamil?
5. Seorang bidan menerima keluhan dari seorang klien yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan karena tidak memahami apa yang dijelaskan bidan. Apa yang harus dilakukan bidan untuk menangani keluhan tersebut?

Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. b. Proses penyampaian pesan yang jelas, tepat, dan mudah dipahami
2. c. Respons atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima
3. a. Membantu membangun hubungan yang lebih baik
4. b. Menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan
5. a. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respons yang menunjukkan pemahaman

Essay

1. Bidan dapat menggunakan komunikasi efektif dengan cara mendengarkan aktif, menunjukkan empati, memberikan informasi yang jelas, memberikan dukungan emosional, mengajukan pertanyaan terbuka.

2. Bidan dapat menggunakan komunikasi efektif dengan cara mengadakan pertemuan tim, mendengarkan aktif, menunjukkan keterbukaan, Menggunakan Bahasa yang jelas, mencari solusi bersama.
3. Bidan dapat menggunakan komunikasi efektif yaitu komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi interpersonal, komunikasi konseling.
4. Bidan dapat menggunakan komunikasi efektif dengan cara menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, menggunakan alat bantu visual, mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik, mengadakan diskusi kelompok.
5. Bidan dapat memperhatikan syarat-syarat komunikasi efektif yaitu: Kejelasan (Clarity, Konsistensi (Consistency), Keterbukaan (Openness), Empati (Empathy), Mendengarkan Aktif (Active Listening), Kesesuaian Konteks (Context Appropriateness), Umpan Balik (Feedback), Non-Verbal (Non-Verbal Communication).

H. Rangkuman Materi

Komunikasi efektif dalam kebidanan adalah kemampuan bidan untuk berinteraksi dengan klien dan tim kesehatan lainnya secara jelas, empatik, dan profesional. Tujuan utama komunikasi efektif dalam kebidanan adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, memastikan kesejahteraan ibu dan bayi, serta membangun hubungan yang baik dengan klien dan tim kesehatan lainnya.

Unsur-unsur komunikasi yaitu pengirim (Sender), pesan (Message), saluran (Channel),

penerima (Receiver), umpan balik (Feedback), konteks (Context), gangguan (Noise), dengan menggunakan teknik meliputi mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan terbuka, menunjukkan empati, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, mengatur waktu yang tepat, menggunakan teknik refleksi. Fungsi komunikasi efektif meliputi komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental. Syarat-syarat dari Komunikasi Efektif meliputi kejelasan (Clarity), konsistensi (Consistency), keterbukaan (Openness), empati (Empathy), mendengarkan aktif (Active Listening), kesesuaian konteks (Context Appropriateness), non-verbal (Non-Verbal Communication).

I. Glosarium

Relevan: Berkaitan langsung dengan topik atau masalah yang sedang dibahas.

Akurat: Tepat dan benar tanpa kesalahan.

Praktis: Mudah diterapkan atau digunakan dalam situasi nyata.

Efektif: Mampu mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien.

Konstruktif: Bersifat membangun dan memberikan manfaat positif.

J. Daftar Pustaka

Dheska, A.P. et al. (2020). Buku Ajar Komunikasi Efektif & Konseling. Yogyakarta. Respati Press

Nisa, A., et al. (2024). Penerapan Komunikasi Efektif Bidan dalam Peningkatan Kepatuhan Pasien Melaksanakan Antenatal Care. *Jurnal Midwifery*, 6(2), 7-11. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.15889>

Nurlailis, Saadah. (2019). Komunikasi dan Konseling. Jakarta. EGC

Sari, P.J. (2023). Peningkatan Kemampuan Komunikasi Efektif Bagi Tenaga Kesehatan di RSIA Cempaka Az-zahra Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 4271-4275. <http://dx.doi.org/10.24252/jmw.v6i1.44141>

BAB 3

MEDIA KOMUNIKASI (TRADISIONAL VS MODERN)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menguasai kemampuan komunikasi interpersonal dan transpersonal secara profesional dalam praktik kebidanan.
- Mampu mengelola dan memilih media komunikasi yang sesuai untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat.
- Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mendukung pelayanan kebidanan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar media komunikasi tradisional dan modern dalam praktik kebidanan.
- Menganalisis kelebihan dan kekurangan media komunikasi tradisional dan modern dalam konteks pelayanan kesehatan.
- Menentukan media komunikasi yang paling efektif berdasarkan kondisi pasien dan lingkungan praktik.

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi berbagai jenis media komunikasi tradisional dan modern.
- Menguraikan karakteristik masing-masing media, termasuk efektivitas dan hambatannya dalam praktik kebidanan.
- Menyesuaikan pemilihan media komunikasi dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi pasien.

Pendahuluan

Dalam praktik kebidanan, komunikasi menjadi elemen utama yang menentukan keberhasilan pelayanan. Bidan tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan dalam menyampaikan informasi, membangun hubungan interpersonal, dan mendukung proses pengambilan keputusan pasien secara efektif. Perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai bentuk media komunikasi, mulai dari media tradisional yang sudah digunakan sejak lama hingga media modern yang berbasis digital.

Perbedaan antara media komunikasi tradisional dan modern terletak pada bentuk, cara penyampaian, serta aksesibilitas informasinya. Media tradisional seperti komunikasi lisan langsung dan media cetak masih banyak digunakan di komunitas dengan keterbatasan akses teknologi. Sebaliknya, media modern seperti aplikasi mobile, media sosial, dan layanan telekonsultasi semakin populer karena efisiensinya dalam menjangkau pasien secara cepat dan luas. Pemahaman mendalam mengenai kedua jenis media ini akan membantu bidan dalam menentukan pendekatan komunikasi yang tepat, sesuai dengan kondisi sosial-budaya dan teknologi yang dimiliki klien.

Uraian Materi

A. Media Komunikasi Tradisional

Media komunikasi tradisional dalam praktik kebidanan merujuk pada sarana atau metode komunikasi yang sudah digunakan sejak sebelum munculnya teknologi informasi dan digital modern. Jenis komunikasi ini lebih mengandalkan interaksi langsung antara komunikator dan komunikan serta menggunakan alat bantu sederhana yang bersifat non-elektronik. Beberapa bentuk umum dari media komunikasi tradisional yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan antara lain adalah komunikasi lisan secara langsung (face-to-face), penggunaan media cetak seperti brosur, leaflet, atau poster, serta ekspresi non-verbal seperti bahasa tubuh, mimik wajah, dan kontak mata yang memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dengan klien.

Dalam praktik sehari-hari, komunikasi lisan langsung menjadi media yang paling sering digunakan oleh bidan, terutama ketika memberikan edukasi kepada ibu hamil, melakukan konseling keluarga berencana, atau saat memberikan instruksi perawatan bayi baru lahir. Interaksi tatap muka ini memungkinkan bidan untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh, menyimak umpan balik pasien secara langsung, serta melakukan klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman. Misalnya, saat seorang bidan memberikan penyuluhan kepada kelompok ibu hamil dalam sebuah kegiatan posyandu, ia tidak hanya menyampaikan materi secara verbal tetapi juga memperkuat pesan melalui gestur tangan, ekspresi wajah, dan intonasi suara yang meyakinkan. Semua elemen ini tidak hanya memperkuat daya serap informasi, tetapi juga membangun rasa aman dan percaya antara pasien dan tenaga kesehatan.

Media cetak juga memiliki peran penting, terutama dalam menyampaikan informasi yang bersifat visual dan ringkas. Brosur yang berisi informasi tentang tanda bahaya kehamilan atau leaflet mengenai cara menyusui yang benar dapat menjadi alat bantu yang berguna selama sesi penyuluhan atau konsultasi. Poster edukatif yang dipasang di ruang tunggu puskesmas atau dinding posyandu juga dapat memperkuat pesan yang telah disampaikan secara lisan. Selain membantu mengingatkan kembali materi yang telah diterima, media cetak juga memberikan kesempatan bagi klien untuk mempelajari informasi secara mandiri setelah sesi konseling berakhir.

Salah satu keunggulan utama dari media komunikasi tradisional adalah kemampuannya dalam membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat. Interaksi tatap muka yang intens memungkinkan terjadinya hubungan empatik

antara bidan dan pasien. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehangatan dan kedekatan, pendekatan tradisional seperti ini sering kali lebih diterima dan memberikan rasa nyaman, terutama bagi masyarakat pedesaan atau lansia yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Komunikasi langsung juga mempermudah proses observasi terhadap respons emosional pasien, yang sangat penting dalam menangani masalah-masalah sensitif seperti keguguran, kekerasan dalam rumah tangga, atau kehamilan tidak diinginkan.

Namun demikian, media tradisional memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jangkauan penyampaian informasi yang relatif sempit. Edukasi atau penyuluhan melalui komunikasi langsung umumnya hanya menjangkau kelompok kecil dan bersifat lokal. Apabila pesan yang disampaikan ingin menjangkau masyarakat yang lebih luas, maka harus dilakukan dalam beberapa sesi atau melibatkan lebih banyak tenaga kesehatan. Hal ini tentu tidak efisien dari segi waktu maupun sumber daya manusia. Selain itu, komunikasi tradisional tidak memungkinkan dokumentasi otomatis atas interaksi yang terjadi. Ketika terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman, tidak ada rekam jejak komunikasi yang dapat ditelusuri kembali seperti yang biasa ditemukan dalam media komunikasi digital.

Keterbatasan lainnya terletak pada potensi terjadinya distorsi pesan. Dalam komunikasi verbal, informasi sangat mungkin mengalami perubahan atau pemahaman yang berbeda antara pemberi dan penerima pesan, apalagi jika dilakukan dalam suasana yang kurang kondusif atau jika klien memiliki hambatan dalam pemahaman bahasa. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi yang berdampak pada pengambilan keputusan kesehatan. Oleh karena itu, bidan yang menggunakan media tradisional harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang tinggi serta mampu memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh pasien atau keluarga.

Meskipun menghadapi tantangan, media komunikasi tradisional tetap memiliki tempat yang penting dalam praktik kebidanan, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap teknologi masih terbatas. Di sinilah letak pentingnya kemampuan bidan untuk bersikap adaptif, mengenali kebutuhan kliennya, serta memadukan berbagai pendekatan komunikasi agar intervensi kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Penggunaan media tradisional yang bijak dan kontekstual dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan serta mendorong keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses asuhan kebidanan.

B. Media Komunikasi Modern

Media komunikasi modern merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dalam dua dekade terakhir. Transformasi digital telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang kesehatan dan pelayanan kebidanan. Media ini mengacu pada sarana komunikasi yang berbasis teknologi digital, yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, masif, dan dalam berbagai format, seperti teks, audio, video, dan gambar interaktif. Dalam praktik kebidanan, penggunaan media komunikasi modern telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, terutama dalam menyampaikan informasi kesehatan, melakukan edukasi, dan menjaga kesinambungan komunikasi antara bidan dan pasien di tengah keterbatasan waktu dan ruang.

Bentuk media komunikasi modern sangat beragam dan dinamis. Salah satu bentuk yang paling umum digunakan adalah aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Aplikasi ini memungkinkan bidan untuk memberikan informasi secara langsung kepada pasien, menjawab pertanyaan, mengirimkan materi edukasi berupa infografik, bahkan melakukan pemantauan harian bagi ibu hamil atau nifas. Selain itu, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok juga banyak dimanfaatkan sebagai platform edukasi kesehatan yang lebih interaktif dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Konten edukasi berupa video singkat, siaran langsung (live streaming), atau unggahan cerita harian dapat digunakan untuk menyampaikan topik-topik seperti tanda bahaya kehamilan, manfaat imunisasi, atau pentingnya pemeriksaan antenatal secara rutin.

Lebih jauh lagi, penggunaan aplikasi mobile kesehatan khusus (mHealth) telah memperluas cakupan dan efektivitas komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Saat ini, banyak tersedia aplikasi yang dapat digunakan oleh pasien untuk memantau perkembangan kehamilan, menghitung usia kehamilan, mencatat kontraksi, bahkan mengingatkan jadwal minum vitamin atau kunjungan ke fasilitas kesehatan. Aplikasi semacam ini tidak hanya membantu pasien menjadi lebih mandiri, tetapi juga menjadi media yang dapat meningkatkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya sendiri. Bagi bidan, aplikasi ini menjadi sarana pelengkap dalam memantau kepatuhan dan kondisi pasien secara berkala, bahkan tanpa harus selalu melakukan pertemuan langsung.

Selain itu, layanan telekonsultasi atau telehealth telah menjadi solusi penting dalam menjembatani keterbatasan geografis atau waktu dalam praktik kebidanan. Dengan menggunakan platform video call atau sistem konsultasi online, bidan dapat tetap memberikan pelayanan kepada pasien di daerah terpencil atau yang

memiliki keterbatasan mobilitas, seperti pasien dengan komplikasi kehamilan atau ibu nifas pascaoperasi. Telekonsultasi memungkinkan pemeriksaan awal, pemberian saran, atau keputusan rujukan dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Keunggulan utama dari media komunikasi modern terletak pada kecepatan dan jangkauan yang sangat luas. Informasi yang disebarkan melalui media ini dapat menjangkau ratusan hingga ribuan individu hanya dalam hitungan detik. Bidan tidak lagi dibatasi oleh lokasi atau jumlah peserta dalam satu sesi edukasi, melainkan dapat melakukan edukasi kesehatan secara masif melalui unggahan konten digital. Selain itu, media modern bersifat fleksibel: pasien dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Hal ini sangat membantu dalam mengatasi kendala waktu dan memperkuat prinsip pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient-centered care*).

Namun demikian, penggunaan media komunikasi modern tidak lepas dari sejumlah tantangan dan hambatan yang harus disadari oleh tenaga kesehatan. Salah satu hambatan yang umum ditemui adalah keterbatasan literasi digital di kalangan pasien. Tidak semua orang, terutama mereka yang berusia lanjut atau tinggal di daerah terpencil, memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan perangkat teknologi seperti *smartphone* atau mengoperasikan aplikasi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan kesalahpahaman dalam menerima pesan yang disampaikan. Dalam konteks ini, bidan harus memastikan bahwa media yang digunakan tetap disesuaikan dengan kemampuan dan preferensi masing-masing pasien.

Tantangan lain yang signifikan adalah terkait dengan privasi dan kerahasiaan data. Dalam komunikasi digital, terutama yang melibatkan pertukaran data medis atau informasi pribadi pasien, terdapat risiko kebocoran data jika tidak dikelola dengan sistem keamanan yang baik. Bidan harus memahami prinsip-prinsip etika dan perlindungan data digital, termasuk bagaimana menggunakan media secara profesional, menyimpan informasi secara aman, serta meminta persetujuan pasien sebelum mendokumentasikan atau menyebarluaskan data kesehatan mereka.

Selain itu, dalam konteks Indonesia yang geografisnya sangat luas dan heterogen, kendala infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil, sinyal yang lemah, atau ketiadaan perangkat memadai masih menjadi hambatan nyata. Di beberapa wilayah pedesaan atau daerah tertinggal, penggunaan media modern belum dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, meskipun

media komunikasi modern memiliki potensi besar, penggunaannya tetap harus dikombinasikan dengan pendekatan konvensional sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam praktik kebidanan, media komunikasi modern dapat menjadi alat yang sangat efektif jika digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Bidan perlu memiliki literasi digital yang baik, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta kepekaan terhadap kebutuhan sosial-budaya pasien. Pemanfaatan media digital yang tepat tidak hanya mendukung efektivitas komunikasi, tetapi juga memperkuat peran bidan sebagai pendidik dan pelindung kesehatan perempuan dan keluarga. Dengan demikian, komunikasi kebidanan yang terintegrasi dengan teknologi akan menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan masa kini dan masa depan.

C. Pemilihan Media Komunikasi yang Efektif.

Pemilihan media komunikasi yang efektif dalam praktik kebidanan bukanlah suatu tindakan yang bersifat seragam atau kaku. Hal ini memerlukan pertimbangan yang matang, karena efektivitas media sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang melekat pada penerima pesan, yaitu pasien atau keluarga pasien. Bidan sebagai komunikator utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak harus mampu menyesuaikan strategi komunikasinya dengan latar belakang individu yang dilayani. Keberhasilan penyampaian informasi sangat tergantung pada sejauh mana media yang digunakan selaras dengan karakteristik dan kebutuhan klien.

Karakteristik pasien menjadi faktor utama yang perlu dianalisis sebelum memilih media komunikasi. Misalnya, usia pasien memainkan peran besar dalam preferensi media. Pasien lanjut usia cenderung lebih nyaman dengan komunikasi langsung dan media cetak karena sudah terbiasa dengan pola komunikasi tradisional. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami media digital, apalagi jika memiliki keterbatasan dalam hal literasi teknologi. Sebaliknya, generasi muda, termasuk remaja dan ibu hamil usia muda, biasanya lebih responsif terhadap pendekatan yang memanfaatkan media digital seperti aplikasi kehamilan, video edukatif di media sosial, atau pesan instan yang bersifat personal dan cepat.

Selain usia, tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi cara seseorang menerima dan memahami informasi kesehatan. Pasien dengan pendidikan rendah mungkin lebih membutuhkan pendekatan visual dan lisan, seperti penjelasan langsung menggunakan media gambar atau alat bantu sederhana dalam bentuk poster dan brosur. Sementara itu, pasien dengan tingkat pendidikan menengah

hingga tinggi cenderung lebih kritis dan ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan dapat dipelajari kembali melalui berbagai media digital atau dokumen elektronik. Dalam hal ini, bidan dituntut untuk memiliki fleksibilitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai gaya dan media.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah literasi digital, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan dan memahami teknologi informasi. Tidak semua pasien memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses informasi digital, walaupun memiliki perangkat seperti telepon pintar. Ada yang kesulitan mengunduh aplikasi, membaca konten digital, atau memahami informasi yang terlalu teknis. Oleh karena itu, bidan perlu terlebih dahulu mengevaluasi apakah pasien memiliki akses dan kemampuan yang cukup untuk menerima informasi melalui media modern. Jika tidak, pendekatan komunikasi perlu diarahkan kembali ke media yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Kondisi sosial dan budaya juga turut memengaruhi pilihan media komunikasi yang efektif. Dalam komunitas pedesaan atau wilayah adat, sistem nilai dan norma budaya sering kali lebih konservatif dan mengedepankan hubungan interpersonal. Komunikasi langsung dalam bentuk konseling tatap muka lebih dihargai karena memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan emosional dan rasa saling percaya. Di sisi lain, masyarakat urban cenderung memiliki gaya hidup yang dinamis dan waktu yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, komunikasi digital menjadi pilihan yang lebih praktis dan efisien karena memungkinkan pasien untuk mengakses informasi secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Dalam praktik terbaik, penggunaan satu jenis media komunikasi saja sering kali tidak cukup untuk mencapai tujuan komunikasi secara optimal. Oleh karena itu, strategi kombinasi antara media tradisional dan modern menjadi pendekatan yang paling bijak. Sebagai contoh, dalam suatu program penyuluhan ibu hamil, bidan dapat memulai dengan pertemuan tatap muka yang bersifat interaktif dan membangun kepercayaan. Dalam sesi tersebut, bidan dapat menyampaikan informasi dasar, menjawab pertanyaan secara langsung, serta melakukan observasi terhadap pemahaman dan sikap pasien. Setelah sesi tersebut, bidan dapat mengirimkan materi lanjutan berupa video pendek, infografis, atau pengingat melalui pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Dengan cara ini, pasien tidak hanya mendapatkan informasi secara utuh, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperkuat pemahaman dan mengulang kembali informasi yang diterima secara mandiri.

Penting untuk dipahami bahwa pemilihan media komunikasi tidak hanya berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Sebuah pesan yang sangat penting, seperti tanda bahaya kehamilan, tidak akan memiliki dampak yang besar jika disampaikan melalui media yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas pasien. Sebaliknya, pesan yang sama, jika disampaikan dengan cara dan media yang tepat, dapat mendorong pasien untuk melakukan tindakan preventif yang menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, kompetensi komunikasi dalam kebidanan mencakup lebih dari sekadar berbicara atau menyampaikan informasi—ia mencakup kepekaan dalam memilih media, kejelian membaca situasi, serta keterampilan membangun hubungan yang mendukung proses asuhan kebidanan secara holistik.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, bidan dapat menjalankan peran komunikatornya secara lebih strategis, adaptif, dan kontekstual. Keberhasilan dalam memilih media komunikasi yang efektif akan memperkuat hubungan antara bidan dan pasien, meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam menjaga kesehatannya, serta berkontribusi langsung terhadap mutu dan keselamatan pelayanan kebidanan.

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan memberikan penyuluhan kepada 10 ibu hamil di posyandu mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan. Ia menggunakan poster dan menyampaikan materi secara verbal dengan ekspresi wajah dan intonasi yang jelas. Setelah kegiatan selesai, beberapa peserta menyatakan sangat memahami isi penyuluhan dan merasa lebih percaya kepada bidan tersebut.

Pertanyaan:

Strategi komunikasi yang digunakan bidan pada kasus di atas termasuk ke dalam jenis media komunikasi apa?

- A. Media digital interaktif
- B. Media komunikasi daring berbasis aplikasi
- C. Media komunikasi tradisional
- D. Media audio-visual berbasis web
- E. Media virtual berbasis cloud

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Penyuluhan secara tatap muka menggunakan poster dan komunikasi verbal adalah bentuk dari media komunikasi tradisional. Pendekatan ini menekankan interaksi langsung, penggunaan alat bantu non-digital, serta memperkuat kepercayaan melalui hubungan interpersonal.

Soal 2

Seorang ibu hamil usia 19 tahun yang tinggal di kota besar merasa tidak sempat datang ke kelas ibu hamil karena kesibukan kuliah. Ia meminta bidan mengirimkan materi edukasi melalui platform digital. Bidan kemudian mengirimkan infografik melalui WhatsApp dan video edukatif di Instagram.

Pertanyaan:

Apa alasan utama penggunaan media komunikasi tersebut efektif dalam kasus ini?

- A. Materi lebih singkat dan sederhana
- B. Ibu hamil belum bisa membaca brosur
- C. Media modern memungkinkan akses fleksibel dan sesuai preferensi pasien
- D. Bidan tidak memiliki waktu untuk menjelaskan secara langsung
- E. Edukasi lebih baik jika disampaikan tanpa pertemuan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Media komunikasi modern seperti WhatsApp dan Instagram sangat cocok untuk pasien muda di lingkungan urban yang lebih akrab dengan teknologi dan membutuhkan fleksibilitas. Penggunaan media ini menyesuaikan dengan preferensi, gaya hidup, dan literasi digital pasien.

Soal 3

Dalam kunjungan ke desa terpencil, seorang bidan ingin menyampaikan informasi mengenai manfaat KB jangka panjang. Ia menyadari bahwa sebagian besar ibu belum mengenal smartphone dan lebih suka mendengarkan penjelasan langsung. Ia pun memilih metode diskusi kelompok dan membagikan leaflet berwarna.

Pertanyaan:

Apa alasan paling tepat dari pemilihan media komunikasi tersebut?

- A. Media digital sulit ditemukan di desa
- B. Pasien tidak suka teknologi
- C. Media tradisional lebih relevan dengan konteks budaya dan kemampuan pasien
- D. Leaflet lebih murah dibandingkan aplikasi
- E. Diskusi kelompok lebih cepat daripada digital

Kunci Jawaban: C**Rasional:**

Dalam komunitas dengan literasi digital rendah, seperti di desa terpencil, media tradisional lebih sesuai karena lebih mudah diterima secara sosial dan budaya. Komunikasi lisan dan media cetak memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan membangun kedekatan interpersonal.

Soal 4

Bidan Ani memberikan konseling kepada ibu muda yang baru melahirkan. Setelah sesi tatap muka, ia mengirimkan video tutorial perawatan tali pusat bayi melalui aplikasi WhatsApp. Ibu tersebut merasa sangat terbantu karena bisa memutar ulang video kapan saja saat merawat bayinya.

Pertanyaan:

Pendekatan komunikasi yang digunakan oleh bidan Ani menggambarkan strategi apa?

- A. Penggunaan media digital eksklusif
- B. Kombinasi media komunikasi tradisional dan modern
- C. Edukasi berbasis satu arah
- D. Pendekatan promosi kesehatan massal
- E. Media cetak sebagai pengganti komunikasi langsung

Kunci Jawaban: B**Rasional:**

Bidan Ani mengombinasikan komunikasi tradisional (konseling tatap muka) dengan media modern (video WhatsApp). Strategi ini memperkuat pemahaman pasien dan memaksimalkan efektivitas edukasi melalui pendekatan yang berlapis.

Soal 5

Seorang bidan memberikan edukasi tentang bahaya anemia pada remaja putri di sekolah. Ia memilih memberikan ceramah langsung, membagikan leaflet, serta membuat grup WhatsApp untuk follow-up diskusi. Dalam diskusi, beberapa siswa antusias dan mulai bertanya lebih dalam.

Pertanyaan:

Mengapa pendekatan ini dianggap sebagai komunikasi yang efektif?

- A. Hanya menggunakan media komunikasi satu arah
- B. Menekankan pada penyuluhan massal tanpa interaksi

- C. Memanfaatkan berbagai media untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan audiens
- D. Mengandalkan brosur dan ceramah sebagai satu-satunya metode
- E. Mengurangi beban kerja bidan secara drastis

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pendekatan kombinasi ini mencerminkan kemampuan bidan dalam menyesuaikan media komunikasi dengan karakteristik sasaran. Ceramah menjangkau banyak orang, leaflet dapat dipelajari mandiri, dan WhatsApp memberikan ruang diskusi interaktif—semua berkontribusi terhadap efektivitas penyampaian pesan.

E. Rangkuman Materi

Komunikasi yang efektif dalam praktik kebidanan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan terapeutik, meningkatkan pemahaman pasien, serta mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pemilihan media komunikasi yang tepat menjadi hal yang sangat krusial. Media komunikasi tradisional, seperti komunikasi lisan langsung, media cetak, serta bahasa tubuh, tetap memiliki peran vital, terutama dalam komunitas dengan akses terbatas terhadap teknologi dan dalam situasi yang menuntut kedekatan emosional serta empati yang tinggi. Pendekatan tradisional ini unggul dalam menciptakan kepercayaan, kenyamanan, serta respons emosional yang kuat, meskipun memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan efisiensi.

Di sisi lain, media komunikasi modern yang berbasis teknologi digital telah membuka peluang besar dalam memperluas akses informasi kesehatan, meningkatkan keterlibatan pasien, serta mempercepat proses edukasi. Platform seperti aplikasi pesan instan, media sosial, video edukatif, dan layanan telekonsultasi memungkinkan bidan menjangkau pasien dengan cara yang lebih fleksibel, real-time, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat masa kini, khususnya generasi muda dan kelompok urban. Namun, penggunaan media modern juga menuntut perhatian terhadap tantangan seperti literasi digital, privasi data, serta kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil.

Pemilihan media komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik pasien secara menyeluruh, termasuk usia, tingkat pendidikan, budaya, kondisi geografis, dan preferensi personal. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua konteks; justru pendekatan yang menggabungkan keunggulan media tradisional dan modern secara bijak sering kali memberikan hasil komunikasi yang

paling optimal. Dalam hal ini, kompetensi bidan tidak hanya terletak pada penyampaian pesan, tetapi juga pada kepekaan dalam memilih media yang sesuai, kemampuan membaca situasi dengan cermat, dan keterampilan interpersonal yang mendukung keberhasilan komunikasi secara holistik. Dengan demikian, komunikasi yang tepat sasaran akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pasien, memperkuat kemitraan dalam asuhan kebidanan, serta meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan secara berkelanjutan.

F. Glosarium

Aplikasi mHealth

Aplikasi berbasis perangkat mobile (gawai) yang dirancang untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk pemantauan kehamilan, pengingat minum obat, dan pencatatan data kesehatan pasien secara mandiri.

Bahasa tubuh

Salah satu bentuk komunikasi non-verbal yang mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, gestur tangan, dan postur fisik yang dapat memperkuat atau menggantikan komunikasi verbal dalam interaksi antara bidan dan pasien.

Brosur/Leaflet

Media cetak berbentuk selebaran berisi informasi kesehatan yang disampaikan secara ringkas dan sistematis, umumnya digunakan untuk edukasi pasien dalam bentuk tertulis dan visual.

Digitalisasi komunikasi

Transformasi sistem komunikasi dari bentuk tradisional menjadi berbasis teknologi informasi digital yang memungkinkan pertukaran data secara elektronik, cepat, dan dalam format multimedia.

Distorsi pesan

Kesalahan dalam penerimaan atau pemahaman isi pesan oleh penerima yang disebabkan oleh hambatan komunikasi seperti lingkungan yang bising, bahasa yang tidak sesuai, atau perbedaan persepsi.

Interaksi tatap muka (face-to-face)

Bentuk komunikasi langsung antara dua individu atau lebih tanpa perantara teknologi, yang memungkinkan penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal secara simultan.

Komunikasi interpersonal

Proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua individu atau lebih secara langsung, yang membangun hubungan empatik dan kepercayaan, terutama dalam konteks pelayanan kebidanan.

Komunikasi tradisional

Sarana komunikasi yang tidak bergantung pada teknologi digital, seperti komunikasi lisan langsung, media cetak, dan simbol-simbol budaya. Umumnya digunakan dalam masyarakat dengan akses teknologi terbatas.

Komunikasi modern

Sarana komunikasi yang menggunakan teknologi digital seperti aplikasi pesan instan, media sosial, video edukasi, atau telekonsultasi yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan luas.

Leaflet

Bentuk media cetak sederhana yang biasanya terdiri dari satu lembar kertas yang dilipat dan digunakan untuk menyampaikan informasi singkat terkait topik kesehatan tertentu.

Literasi digital

Kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi digital secara efektif melalui perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, atau internet.

Media cetak

Alat komunikasi berbasis kertas seperti brosur, leaflet, dan poster yang digunakan dalam penyuluhan atau edukasi pasien, terutama di tempat pelayanan kesehatan primer.

Media komunikasi

Sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, baik dalam bentuk verbal, non-verbal, cetak, maupun digital.

Pemilihan media komunikasi

Proses pertimbangan untuk menentukan media komunikasi yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasien agar pesan dapat diterima dan dipahami secara optimal.

Poster edukatif

Media visual berukuran besar yang berfungsi menyampaikan pesan kesehatan secara ringkas dan menarik, umumnya dipasang di tempat umum seperti puskesmas atau posyandu.

Privasi data

Hak dan perlindungan terhadap informasi pribadi pasien, terutama dalam komunikasi digital, agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Telekonsultasi (Telehealth)

Layanan konsultasi kesehatan jarak jauh yang dilakukan melalui media digital seperti video call atau aplikasi kesehatan, digunakan untuk menjaga kesinambungan pelayanan terutama di daerah sulit akses.

G. Daftar Pustaka

- Afriyanti, F., & Kusuma, A. (2021). Peran media komunikasi dalam meningkatkan pemahaman ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 45–52. <https://doi.org/10.15294/jkm.v16i1.12345>
- Cahyani, N. S., & Putri, D. A. (2020). Efektivitas komunikasi interpersonal bidan dalam meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap ANC. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.31290/jkk.v6i2.124>
- Gunawan, J., Marzilli, C., Aunguroch, Y., Fisher, M. L., & McDaniel, A. M. (2022). Communication technologies in maternal health care: A review of current evidence and best practices. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04897-4>
- Hidayati, R., & Prasetyo, B. (2019). Penggunaan leaflet sebagai media komunikasi edukatif dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 14(3), 235–240. <https://doi.org/10.14710/jpki.14.3.235-240>
- Kurniawan, A., & Widodo, Y. (2021). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan edukasi kesehatan reproduksi oleh tenaga kesehatan. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 95–103. <https://doi.org/10.31290/jiki.v9i2.1578>
- Mulyadi, A., & Permatasari, R. (2022). Telekonsultasi sebagai media komunikasi kebidanan dalam masa pandemi: Tinjauan literatur. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1), 34–41. <https://doi.org/10.26714/jki.13.1.2022.34-41>
- Notoatmodjo, S. (2020). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri, I. R., & Handayani, H. (2023). Literasi digital ibu hamil dalam memanfaatkan aplikasi kesehatan selama kehamilan. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 8(1), 10–18. <https://doi.org/10.37341/jkkt.v8i1.2212>
- Sari, Y., & Maulani, M. (2020). Evaluasi penggunaan media komunikasi tradisional dalam meningkatkan kesadaran ibu nifas terhadap perawatan bayi baru lahir. *Jurnal Media Komunikasi Kesehatan*, 10(2), 65–72. <https://doi.org/10.22435/jmkk.v10i2.2129>

Wahyuni, R. T., & Lestari, E. (2021). Strategi komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan di era digital. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 19(2), 145–153. <https://doi.org/10.33475/jik.v19i2.2501>

BAB 4

PSIKOLOGI KOMUNIKASI: MENGHARGAI DAN MENGHORMATI DALAM KOMUNIKASI, EMPATI DALAM KOMUNIKASI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara empatik dan menghargai dalam berbagai situasi pelayanan kebidanan.
- Menunjukkan sikap profesional dan etis dalam komunikasi interpersonal dan transpersonal.
- Mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi komunikasi dalam pelayanan yang berpusat pada pasien (woman-centered care).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep psikologi komunikasi dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi prinsip menghargai, menghormati, dan empati dalam komunikasi dengan pasien.
- Menerapkan teknik komunikasi yang mencerminkan penghargaan dan empati terhadap kondisi pasien dalam situasi klinis.

Sub-CPMK

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjabarkan makna menghargai dan menghormati pasien dalam konteks komunikasi kebidanan.
- Menjelaskan perbedaan antara empati dan simpati, serta implikasinya dalam komunikasi profesional.
- Menunjukkan contoh sikap empatik dan menghargai saat menghadapi pasien dalam situasi emosional, sensitif, atau krisis.

Pendahuluan

Psikologi komunikasi dalam praktik kebidanan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang berkualitas antara bidan dan pasien. Praktik komunikasi yang efektif tidak cukup hanya ditinjau dari aspek teknis atau verbal, tetapi juga sangat bergantung pada pemahaman psikologis tentang bagaimana pesan diterima, diinterpretasikan, dan direspons oleh individu. Dalam pelayanan kebidanan, komunikasi memiliki dimensi emosional yang mendalam, karena menyangkut aspek-aspek kehidupan perempuan yang bersifat personal, sensitif, bahkan transformatif.

Dua elemen kunci dari psikologi komunikasi yang harus dimiliki oleh setiap bidan adalah sikap menghargai dan menghormati serta kemampuan untuk berempati dalam komunikasi. Sikap menghargai dan menghormati dalam komunikasi mencerminkan pengakuan terhadap martabat dan otonomi setiap pasien, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, atau status pendidikan. Sementara itu, empati adalah kemampuan untuk memahami emosi dan perspektif pasien, serta meresponsnya secara tepat dan penuh kepedulian.

Kedua unsur ini merupakan bagian dari pendekatan komunikasi humanistik yang tidak hanya menciptakan rasa aman dan kepercayaan, tetapi juga mendukung pasien untuk menjadi partisipan aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Oleh karena itu, penguasaan konsep psikologi komunikasi menjadi hal esensial dalam membentuk bidan sebagai komunikator profesional dan transformatif dalam pelayanan kebidanan.

A. Menghargai dan Menghormati dalam Komunikasi

Dalam praktik kebidanan, sikap menghargai dan menghormati bukan sekadar etika komunikasi dasar, melainkan sebuah pondasi moral dan profesional yang membentuk keseluruhan kualitas interaksi antara bidan dan pasien. Konsep ini mencerminkan pengakuan bahwa setiap individu, terutama perempuan dalam masa kehamilan, persalinan, atau masa reproduktif lainnya, memiliki nilai, martabat, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam semua bentuk pelayanan kesehatan. Menghargai dan menghormati pasien berarti memberikan perlakuan yang adil, sopan, dan penuh kepekaan terhadap kebutuhan personal dan konteks sosial-budaya pasien.

Menghargai pasien berarti mengakui bahwa mereka memiliki hak untuk didengarkan, dipahami, dan mendapatkan pelayanan tanpa prasangka, diskriminasi, atau perlakuan merendahkan. Ini tercermin dari sikap bidan yang menggunakan bahasa verbal yang santun, bahasa tubuh yang terbuka dan bersahabat, serta nada suara yang menunjukkan empati dan perhatian. Pemilihan kata yang tidak menghakimi, penggunaan sapaan yang sesuai, serta menghindari komentar yang meremehkan merupakan bentuk komunikasi yang mencerminkan penghargaan terhadap integritas pasien. Terlebih dalam masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik tradisional sangat memengaruhi pengalaman perempuan terhadap kesehatan reproduksi, sikap menghargai menjadi kunci dalam menjalin komunikasi yang efektif dan bermakna.

Sementara itu, menghormati pasien berkaitan erat dengan pengakuan terhadap otonomi mereka sebagai individu yang berhak mengambil keputusan atas tubuh dan kesehatannya sendiri. Dalam komunikasi kebidanan, menghormati berarti tidak memaksakan pilihan atau intervensi medis kepada pasien, melainkan memberikan informasi secara netral dan transparan sehingga pasien dapat mempertimbangkan dan memilih tindakan berdasarkan pemahaman yang utuh. Misalnya, dalam memberikan edukasi tentang metode kontrasepsi, bidan tidak boleh menilai pilihan pasien sebagai “salah” hanya karena berbeda dengan preferensi bidan sendiri. Sebaliknya, bidan harus mampu membimbing tanpa menggurui, dan menerima keputusan pasien dengan sikap terbuka, sambil tetap menjaga tanggung jawab profesionalnya.

Sikap menghargai dan menghormati menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan, terutama dalam menghadapi kelompok pasien yang

rentan, seperti remaja dengan kehamilan di luar nikah, perempuan korban kekerasan seksual, atau pasien dengan riwayat trauma obstetri. Dalam situasi ini, pasien sering kali datang dengan ketakutan, rasa malu, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Respons yang kasar, sinis, atau kaku dari bidan dapat menutup ruang komunikasi dan memperburuk kondisi psikologis pasien. Sebaliknya, pendekatan yang ramah, hangat, dan non-judgmental akan memberikan rasa aman dan membuat pasien lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan serta menerima intervensi kesehatan.

Lebih jauh lagi, menghargai dan menghormati pasien bukan hanya urusan interpersonal antara bidan dan pasien, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dalam sistem pelayanan kesehatan. Ketika pasien merasa dihargai, mereka akan lebih percaya pada penyedia layanan, lebih aktif dalam mengikuti anjuran medis, dan lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak kesehatannya. Dengan demikian, praktik komunikasi yang menghargai dan menghormati tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas asuhan kebidanan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka secara sadar dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap calon bidan perlu mengembangkan sensitivitas dan kecerdasan emosional dalam menghadapi berbagai latar belakang pasien. Ini tidak hanya menjadi bekal untuk memberikan layanan yang berkualitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam profesi kebidanan. Menghargai dan menghormati dalam komunikasi adalah refleksi dari integritas, empati, dan profesionalisme yang menyatu dalam satu tindakan pelayanan yang utuh.

B. Empati dalam Komunikasi

Dalam komunikasi kebidanan, empati memegang peran yang sangat vital sebagai dasar dari hubungan terapeutik yang sehat antara bidan dan pasien. Empati bukan hanya kemampuan untuk mendengar keluhan atau menyaksikan ekspresi pasien, tetapi merupakan bentuk kedalaman emosional di mana bidan berupaya memahami perasaan, kebutuhan, dan pengalaman pasien dari sudut pandang pasien itu sendiri. Dengan kata lain, empati adalah proses di mana bidan berusaha “masuk ke dalam dunia pasien” tanpa kehilangan peran profesionalnya. Dalam praktik, hal ini mencakup sensitivitas terhadap suasana hati pasien, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahkan diamnya pasien yang mungkin menyiratkan sesuatu yang lebih dalam.

Ketika seorang bidan berkomunikasi secara empatik, ia tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Ia memperhatikan bahasa tubuh pasien, membaca ekspresi yang menyimpan kecemasan, dan merespons dengan ketulusan yang membesarkan hati. Contohnya, saat seorang ibu hamil datang dalam kondisi panik karena mengalami perdarahan ringan, bidan tidak hanya menjelaskan kemungkinan penyebabnya secara medis, tetapi juga meyakinkan pasien bahwa ia tidak sendirian, bahwa apa yang dirasakannya valid, dan bahwa ia akan didampingi dalam setiap langkah proses pemeriksaan dan penanganannya. Itulah esensi empati—kehadiran yang menyentuh secara emosional dan mendalam.

Empati juga memengaruhi bagaimana bidan menyampaikan informasi. Dalam kondisi di mana pasien menerima kabar kurang menyenangkan, seperti keguguran atau kehamilan risiko tinggi, komunikasi tidak bisa dilakukan dengan nada datar dan bahasa yang terlalu teknis. Dalam situasi seperti ini, empati mengarahkan bidan untuk menyesuaikan bahasa, intonasi, dan waktu penyampaian pesan. Respon yang penuh kasih dan dukungan, serta kesiapan untuk mendengarkan reaksi emosional pasien, menciptakan rasa aman dan menurunkan ketegangan psikologis.

Perlu dipahami pula bahwa empati bukanlah simpati. Banyak orang menganggap keduanya sama, padahal dalam praktik klinis perbedaannya sangat penting. Simpati adalah perasaan iba atau kasihan terhadap seseorang, yang justru bisa membuat komunikasi menjadi tidak setara. Simpati bisa menempatkan pasien pada posisi pasif dan lemah, seolah-olah mereka hanya perlu dikasihani. Sebaliknya, empati mengajak pasien untuk dipahami secara aktif, diakui hak-haknya, dan diberdayakan untuk tetap menjadi pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan yang mereka jalani.

Empati juga menuntut keseimbangan profesional. Seorang bidan harus bisa merasakan emosi pasien tanpa terbawa secara berlebihan hingga kehilangan objektivitas. Inilah mengapa empati disebut sebagai keterampilan profesional—karena ia harus dilatih, diasah, dan digunakan dengan kebijaksanaan. Bidan yang empatik akan tetap mampu memberikan asuhan yang rasional dan berbasis bukti, namun dengan pendekatan yang penuh perhatian dan pengertian.

Dalam konteks pendidikan kebidanan, empati harus menjadi bagian yang diajarkan secara eksplisit, baik dalam kelas teori maupun praktik klinik. Mahasiswa harus dilatih untuk menyadari pentingnya mendekati pasien dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, terutama dalam situasi-situasi yang sulit dan sarat emosi.

Latihan role play, simulasi, dan refleksi diri dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan empati sebagai nilai dan keterampilan inti dalam praktik kebidanan.

Dengan demikian, empati bukan hanya membuat komunikasi menjadi lebih hangat, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kepercayaan, kenyamanan, dan kolaborasi yang sejati antara bidan dan pasien. Melalui empati, bidan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harapan, keyakinan, dan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh perempuan dalam setiap fase kehidupan reproduksinya. Maka, empati dalam komunikasi bukan sekadar teknik profesional, melainkan wujud paling nyata dari kemanusiaan dalam praktik kebidanan.

C. Latihan Soal

Soal 1

Kasus:

Seorang remaja putri datang ke puskesmas dengan ibunya untuk berkonsultasi tentang kehamilan yang tidak direncanakan. Ia terlihat gugup dan enggan berbicara. Bidan menyapanya dengan lembut, menggunakan nama kecilnya, tersenyum hangat, dan berkata, "Kamu sudah sangat berani datang ke sini. Saya akan bantu sebisa mungkin, dan kamu bebas cerita kapan pun kamu siap."

Pertanyaan:

Tindakan bidan tersebut menunjukkan penerapan prinsip komunikasi yang paling tepat, yaitu:

Pilihan Jawaban:

- A. Memberikan informasi medis secara lengkap
- B. Mengendalikan diskusi agar tidak melebar
- C. Menunjukkan empati dan menghargai pasien
- D. Menilai kondisi psikologis pasien secara cepat
- E. Mengarahkan pasien untuk membuat keputusan cepat

Kunci Jawaban: C

Rasionalisasi:

Bidan menunjukkan empati dan penghargaan dengan pendekatan yang ramah, non-judgmental, serta membangun rasa aman bagi pasien remaja yang sedang dalam situasi rentan.

Soal 2

Kasus:

Dalam sesi edukasi kelompok ibu hamil, seorang pasien mengangkat tangan dan menyampaikan kepercayaan tradisional keluarganya terkait makanan pantangan selama kehamilan. Bidan menyimak dengan seksama, lalu merespons dengan menghargai pandangan tersebut dan menyambungkan dengan penjelasan medis yang relevan.

Pertanyaan:

Respons bidan menunjukkan sikap:

Pilihan Jawaban:

- A. Mendorong pasien untuk menghindari tradisi
- B. Mengoreksi keyakinan tanpa kompromi
- C. Mengabaikan kepercayaan yang tidak ilmiah
- D. Menghargai latar belakang budaya dan memberi edukasi berbasis bukti
- E. Menyarankan untuk mengikuti pendapat medis tanpa diskusi

Kunci Jawaban: D

Rasionalisasi:

Bidan menunjukkan sikap menghargai terhadap latar belakang budaya pasien, namun tetap mengedukasi dengan pendekatan yang tidak menyinggung nilai-nilai tradisional.

Soal 3

Kasus:

Seorang ibu yang baru mengalami keguguran datang untuk kontrol pasca kuretase. Ia masih terlihat sedih dan menghindari kontak mata. Bidan duduk sejajar, tidak terburu-buru, dan berkata, "Saya bisa membayangkan betapa berat yang ibu rasakan. Jika ibu ingin cerita, saya ada di sini."

Pertanyaan:

Pernyataan bidan mencerminkan indikator komunikasi berikut ini:

Pilihan Jawaban:

- A. Edukasi berdasarkan prosedur medis
- B. Empati dalam komunikasi klinis
- C. Evaluasi risiko psikologis pasien
- D. Afirmasi teknis terhadap proses penanganan
- E. Penjelasan sistem rujukan lanjutan

Kunci Jawaban: B

Rasionalisasi:

Bidan menunjukkan empati dengan mengenali emosi pasien dan menawarkan dukungan secara aktif tanpa memaksa. Ini mencerminkan kehadiran emosional yang menyentuh.

Soal 4

Kasus:

Saat menyampaikan informasi tentang pilihan kontrasepsi, bidan menyarankan metode yang ia anggap paling efektif, namun pasien memilih metode lain. Bidan tetap mendukung pilihan pasien dan berkata, "Keputusan ibu sudah tepat jika ibu merasa paling nyaman. Yang penting kita pantau bersama hasilnya."

Pertanyaan:

Tindakan bidan menunjukkan sikap:

Pilihan Jawaban:

- A. Mengarahkan pasien pada preferensi bidan
- B. Memberi tekanan agar pasien mengikuti saran
- C. Menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan
- D. Mewajibkan pasien menandatangani persetujuan
- E. Menolak metode yang dipilih pasien

Kunci Jawaban: C

Rasionalisasi:

Bidan tidak memaksakan pendapatnya dan menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri, sebuah praktik komunikasi berbasis penghormatan terhadap otonomi individu.

Soal 5

Kasus:

Pasien korban kekerasan rumah tangga datang ke klinik kebidanan untuk pemeriksaan kehamilan. Ia tampak tertutup dan curiga. Bidan menyapanya dengan lembut, menghindari pertanyaan langsung yang terlalu pribadi, dan berkata, "Kita bisa mulai dari hal-hal ringan. Jika ibu merasa nyaman, kita bisa bahas lebih jauh kapan pun ibu siap."

Pertanyaan:

Respons bidan mencerminkan prinsip komunikasi:

Pilihan Jawaban:

- A. Mengendalikan sesi agar efisien
- B. Memberikan perintah agar pasien terbuka

- C. Menunjukkan empati dan membangun rasa aman
- D. Menunda seluruh sesi karena pasien tidak kooperatif
- E. Menyimpulkan bahwa pasien tidak butuh bantuan lebih lanjut

Kunci Jawaban: C

Rasionalisasi:

Bidan menunjukkan empati dengan tidak memaksa pasien untuk membuka diri dan menciptakan ruang yang aman dan hangat. Ini penting dalam konteks pasien dengan trauma.

D. Rangkuman Materi

Menghargai, menghormati, dan berempati merupakan inti dari komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Ketiga elemen ini tidak hanya menjadi etika profesional, tetapi juga landasan moral yang menopang keberhasilan hubungan antara bidan dan pasien. Dalam konteks pelayanan yang sensitif seperti kebidanan, penghargaan terhadap martabat, latar belakang budaya, serta otonomi pasien menjadi syarat mutlak agar komunikasi berlangsung setara, aman, dan bermakna.

Sikap menghargai dan menghormati dalam komunikasi mencerminkan pengakuan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk didengar, dimengerti, dan menentukan keputusan atas tubuh serta kesehatannya sendiri. Ketika bidan berkomunikasi dengan bahasa yang santun, tubuh yang terbuka, dan tanpa prasangka, pasien akan merasa dihargai dan diberdayakan. Komunikasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pasien terhadap asuhan kebidanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Empati, di sisi lain, memperdalam kualitas hubungan terapeutik melalui kehadiran emosional yang tulus dan penuh pengertian. Bidan yang mampu merasakan perasaan pasien, menyesuaikan nada bicara, dan merespons dengan kasih sayang tanpa menghakimi, menciptakan ruang yang aman bagi pasien untuk terbuka. Empati bukan sekadar memahami, tetapi juga mendampingi pasien dalam situasi sulit secara aktif, bijak, dan profesional. Inilah yang membedakan empati dari simpati, yang cenderung pasif dan tidak memberdayakan.

Dengan mengintegrasikan nilai menghargai, menghormati, dan empati dalam komunikasi kebidanan, bidan bukan hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra yang sejati dalam setiap perjalanan reproduktif perempuan. Pendekatan ini membangun jembatan kepercayaan, memperkuat kolaborasi dalam pengambilan keputusan, dan menghadirkan praktik kebidanan yang benar-benar

humanis. Maka, bagi setiap bidan profesional, kemampuan untuk menghargai, menghormati, dan berempati bukan hanya keterampilan teknis, melainkan cerminan dari kemanusiaan yang utuh dalam asuhan yang bermutu.

E. Glosarium

Asuhan Kebidanan

Pelayanan kesehatan menyeluruh yang diberikan oleh bidan kepada perempuan, bayi, dan keluarga, yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan psikologis secara profesional dan manusiawi.

Bahasa Tubuh

Sarana komunikasi nonverbal berupa gerakan tubuh, ekspresi wajah, posisi duduk atau berdiri, dan kontak mata yang mencerminkan sikap atau perasaan seseorang dalam interaksi.

Empati

Kemampuan untuk memahami perasaan, pengalaman, dan kondisi pasien dari sudut pandang mereka, serta meresponsnya dengan kepedulian emosional dan dukungan tanpa menghakimi. Empati bersifat aktif dan menjadi landasan utama dalam hubungan terapeutik.

Hak Reproduksi

Hak individu, terutama perempuan, untuk membuat keputusan yang bebas, bertanggung jawab, dan berdasarkan informasi mengenai tubuh, kesehatan reproduksi, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Humanis (Pendekatan Humanistik)

Pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus diperlakukan dengan penuh hormat, kepekaan, dan empati, bukan sekadar objek tindakan medis.

Integritas Profesional

Kualitas moral dan etika yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan, melalui kejujuran, rasa tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak pasien dalam setiap tindakan pelayanan.

Kepercayaan Pasien

Perasaan aman dan yakin yang dimiliki pasien terhadap bidan sebagai penyedia layanan, yang diperoleh melalui komunikasi yang jujur, terbuka, empatik, dan menghormati nilai-nilai pasien.

Keseimbangan Profesional

Kemampuan bidan untuk menjaga jarak emosional yang tepat dalam hubungan dengan pasien agar tetap dapat memberikan asuhan yang efektif tanpa terlarut secara pribadi dalam emosi pasien.

Komunikasi Empatik

Gaya komunikasi yang melibatkan pemahaman emosional terhadap pasien, penggunaan bahasa yang menenangkan, serta perilaku yang menunjukkan dukungan dan kepedulian secara tulus.

Komunikasi Humanis

Interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, penghargaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat individu.

Komunikasi Nonverbal

Bentuk komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata, melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara, yang dapat memperkuat atau menggantikan pesan verbal.

Menghargai

Sikap dan tindakan dalam komunikasi yang mencerminkan pengakuan terhadap nilai, martabat, dan hak setiap individu untuk didengar, dipahami, dan dilayani secara adil tanpa diskriminasi.

Menghormati

Memberikan ruang dan kebebasan kepada pasien untuk membuat keputusan atas tubuh dan kesehatannya sendiri, tanpa tekanan atau paksaan, dan dengan penyampaian informasi yang jujur serta transparan.

Non-judgmental

Sikap tidak menghakimi atau mengevaluasi pasien secara negatif berdasarkan pilihan, latar belakang, atau keadaan tertentu; suatu pendekatan penting dalam membangun komunikasi yang aman dan terbuka.

Otonomi Pasien

Hak pasien untuk mengambil keputusan sendiri terkait asuhan kesehatan yang akan dijalani, berdasarkan informasi yang cukup dan tanpa tekanan dari tenaga kesehatan.

Simpati

Perasaan iba atau kasihan terhadap orang lain, yang bersifat pasif dan kurang melibatkan pemahaman atau keterlibatan aktif dalam pengalaman emosional orang tersebut. Berbeda dengan empati yang bersifat aktif dan memberdayakan.

Trauma Obstetri

Pengalaman fisik dan/atau emosional yang menyakitkan terkait proses kehamilan, persalinan, atau pelayanan kebidanan, yang dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan.

Tanggung Jawab Profesional

Kewajiban moral dan etis yang melekat pada profesi bidan untuk menjalankan praktik secara aman, kompeten, dan berdasarkan prinsip menghormati martabat dan hak pasien.

F. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, J., Marzilli, C., Aunguroch, Y., Fisher, M. L., & McDaniel, A. M. (2021). Empathy and communication in nurse–patient interaction: A narrative review. *Belitung Nursing Journal*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.33546/bnj.1376>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar pelayanan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2020). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri, Y. P., & Maharani, R. A. (2021). Komunikasi empatik dalam pelayanan kebidanan: Studi kualitatif pada bidan praktik mandiri. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 17(2), 135–142. <https://doi.org/10.24198/jkk.v17i2.11754>
- Rachmawati, I. N., & Kurniawati, N. D. (2020). Persepsi mahasiswa kebidanan tentang pentingnya empati dalam komunikasi profesional. *Jurnal Pendidikan Kebidanan*, 9(1), 23–30. <https://doi.org/10.24198/jpk.v9i1.11820>
- World Health Organization. (2016). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*. Geneva: WHO Press.

BAB 5

INDIKATOR KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menunjukkan kemampuan komunikasi interpersonal dan transpersonal yang efektif, empatik, dan profesional dalam memberikan asuhan kebidanan.
- Mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, budaya, dan hak pasien dalam komunikasi kebidanan.
- Menerapkan keterampilan komunikasi dalam situasi klinis, komunitas, dan kolaborasi interprofesional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dan pentingnya indikator keterampilan komunikasi dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi berbagai indikator keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif.
- Mengevaluasi praktik komunikasi berdasarkan indikator yang relevan dengan kebutuhan pasien dan konteks pelayanan kebidanan.

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan indikator utama keterampilan komunikasi yang efektif dalam pelayanan kebidanan.
- Menganalisis situasi klinis berdasarkan penerapan indikator komunikasi yang tepat.
- Melakukan refleksi terhadap praktik komunikasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara bidan dan pasien.

Pendahuluan

Komunikasi adalah inti dari pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berorientasi pada pasien. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan bidan membangun hubungan yang efektif, empatik, dan kolaboratif dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Dalam praktik kebidanan, komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan kemampuan mendengarkan secara aktif, memahami konteks sosial-budaya pasien, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi penerima layanan.

Untuk dapat mengevaluasi dan mengembangkan keterampilan komunikasi dalam praktik profesional, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang indikator-indikator komunikasi yang efektif. Indikator ini mencakup aspek verbal dan nonverbal, kemampuan membangun hubungan terapeutik, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta kesanggupan dalam menghadapi situasi emosional atau sensitif secara profesional. Dalam konteks kebidanan, indikator-indikator ini menjadi alat ukur penting dalam menentukan sejauh mana komunikasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip asuhan yang humanistik, holistik, dan berbasis kebutuhan pasien.

Memahami indikator keterampilan komunikasi membantu mahasiswa kebidanan untuk mengembangkan kompetensi secara bertahap, mulai dari penguasaan dasar komunikasi interpersonal hingga ke kemampuan profesional dalam berkomunikasi dengan klien dalam berbagai situasi klinis. Pembelajaran topik ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan observasi dan refleksi diri, sehingga mereka mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam praktik kebidanan yang sesungguhnya.

A. Pengertian dan Urgensi Indikator Keterampilan Komunikasi

Indikator keterampilan komunikasi dalam praktik kebidanan merupakan komponen penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh bidan berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar pelayanan profesional. Secara konseptual, indikator ini merujuk pada sejumlah tanda atau ciri yang dapat diamati dan diukur yang mencerminkan kualitas komunikasi, baik dari segi isi pesan, cara penyampaian, respons terhadap umpan balik, maupun sikap dan perilaku komunikator selama berinteraksi dengan pasien. Indikator keterampilan komunikasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis seperti kejelasan ucapan atau pilihan kata, tetapi juga mencakup dimensi interpersonal, emosional, dan etis dalam hubungan antara bidan dan pasien.

Keberadaan indikator keterampilan komunikasi menjadi sangat penting karena komunikasi bukanlah proses satu arah yang semata-mata menyampaikan informasi. Dalam praktik kebidanan, komunikasi memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks, yaitu membangun hubungan terapeutik, memahami kebutuhan dan kekhawatiran pasien, memberikan dukungan emosional, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang informatif dan partisipatif. Oleh karena itu, indikator komunikasi harus mampu menangkap aspek-aspek substansi maupun proses dalam interaksi antara bidan dan pasien secara menyeluruh.

Urgensi penguasaan indikator keterampilan komunikasi semakin nyata ketika dikaitkan dengan konsekuensi dari komunikasi yang tidak efektif. Dalam banyak kasus, kegagalan komunikasi menjadi akar dari berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam kebidanan. Misalnya, jika bidan tidak mampu menjelaskan rencana asuhan dengan jelas dan dapat dimengerti, pasien berpotensi mengalami kebingungan, kecemasan, bahkan melakukan keputusan yang tidak tepat karena salah persepsi. Ketidakjelasan komunikasi juga dapat menyebabkan pasien tidak patuh pada rujukan medis, tidak melakukan kontrol kehamilan secara rutin, atau gagal memahami tanda-tanda bahaya yang seharusnya segera ditangani. Semua kondisi ini pada akhirnya dapat berujung pada memburuknya status kesehatan ibu dan bayi, dan dalam kasus ekstrem, dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas.

Dalam praktik kebidanan, indikator komunikasi juga menjadi panduan bagi bidan untuk merefleksikan praktik profesional mereka. Melalui indikator ini, bidan

dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam gaya komunikasinya, memahami dampaknya terhadap pengalaman pasien, dan mengambil langkah perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator keterampilan komunikasi tidak hanya digunakan sebagai alat penilaian oleh dosen atau supervisor klinik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengembangan diri bagi mahasiswa kebidanan maupun bidan yang telah bekerja.

Urgensi lainnya muncul dari tantangan komunikasi dalam konteks sosial-budaya dan teknologi yang semakin kompleks. Pasien kebidanan berasal dari latar belakang yang beragam, baik dalam hal pendidikan, bahasa, nilai-nilai budaya, maupun harapan terhadap pelayanan. Bidan dituntut untuk memiliki kepekaan dalam menyesuaikan gaya komunikasinya agar tetap relevan dan dapat diterima oleh pasien tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme. Di sinilah peran indikator komunikasi menjadi panduan konkret dalam menjaga kualitas dan kesetaraan pelayanan.

Mengingat pentingnya peran indikator ini, maka pembelajaran tentang indikator keterampilan komunikasi harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Mahasiswa tidak hanya perlu diajarkan teori komunikasi, tetapi juga perlu dilatih untuk mengidentifikasi, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan komunikasi berdasarkan indikator yang jelas dan terstandar. Dalam proses pembelajaran, indikator ini juga menjadi dasar dalam penilaian keterampilan praktik klinik mahasiswa di berbagai tahapan pendidikan.

Dengan demikian, indikator keterampilan komunikasi bukan sekadar teori yang bersifat konseptual, melainkan instrumen yang operasional, aplikatif, dan strategis dalam memastikan bahwa komunikasi dalam praktik kebidanan benar-benar berkontribusi pada keselamatan, kenyamanan, dan keberdayaan pasien. Pemahaman mendalam tentang indikator ini akan memberikan arah bagi para bidan untuk menjadi komunikator yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif dalam mendampingi perempuan dan keluarganya melalui berbagai fase kehidupan reproduksi.

B. Indikator Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal merupakan bentuk utama dari interaksi antara bidan dan pasien yang melibatkan penggunaan bahasa lisan sebagai sarana penyampaian pesan. Dalam konteks pelayanan kebidanan, komunikasi verbal tidak sekadar menjadi media untuk mentransfer informasi, melainkan juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, menciptakan rasa aman, serta mendukung proses

pengambilan keputusan yang bijaksana oleh pasien. Oleh karena itu, indikator komunikasi verbal menjadi acuan penting dalam menilai sejauh mana komunikasi lisan yang dilakukan bidan telah memenuhi prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan profesional.

Salah satu indikator utama dari keterampilan komunikasi verbal adalah kemampuan bidan dalam menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien. Pemilihan kata-kata harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya, dan konteks sosial pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman atau rasa tidak nyaman. Misalnya, dalam menjelaskan proses persalinan kepada seorang ibu hamil yang tinggal di wilayah pedesaan, bidan perlu menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab bagi pasien, dan menghindari istilah medis yang sulit dimengerti. Apabila penggunaan istilah teknis tidak dapat dihindari, maka bidan wajib memberikan penjelasan secara perlahan dan disertai contoh konkret agar informasi dapat diterima dengan baik.

Selain itu, indikator komunikasi verbal juga mencakup kemampuan menyusun dan menyampaikan informasi secara sistematis dan logis. Artinya, informasi yang disampaikan harus memiliki urutan yang jelas, runtut, serta berfokus pada hal-hal yang penting dan relevan dengan kondisi pasien. Misalnya, dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kehamilan, bidan perlu memulai dari penjelasan umum terlebih dahulu sebelum masuk pada detail yang lebih kompleks. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pasien dalam mengikuti alur pembicaraan dan memahami setiap bagian dari informasi yang diberikan.

Nada suara juga menjadi bagian yang sangat penting dalam indikator komunikasi verbal. Penggunaan nada suara yang lembut, meyakinkan, dan tidak mengintimidasi dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi pasien. Nada suara yang terlalu tinggi atau tajam dapat menimbulkan kesan marah atau tidak sabar, yang pada akhirnya dapat menghambat keterbukaan pasien dalam menyampaikan keluhan atau pertanyaan. Dalam situasi yang penuh tekanan seperti saat pasien mengalami kecemasan menjelang persalinan, nada suara yang menenangkan dari seorang bidan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi emosional pasien.

Lebih lanjut, kemampuan menjelaskan rencana tindakan medis kepada pasien merupakan bagian esensial dari komunikasi verbal yang efektif. Seorang bidan harus mampu menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan, manfaat dan risiko yang mungkin terjadi, serta menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan empatik. Dalam hal ini, bidan juga dituntut untuk memberikan dukungan verbal yang dapat

memperkuat kepercayaan diri pasien, terutama dalam situasi yang menimbulkan kecemasan atau ketidakpastian. Ucapan sederhana seperti "Ibu sudah melakukan yang terbaik" atau "Kami akan mendampingi ibu sampai proses ini selesai dengan aman" bisa memberikan dampak yang sangat berarti secara psikologis bagi pasien.

Komunikasi verbal yang baik juga membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya bicara dengan karakteristik pasien. Berkomunikasi dengan remaja, misalnya, tentu berbeda dengan berkomunikasi dengan lansia. Remaja cenderung lebih terbuka dengan gaya komunikasi yang santai dan tidak menggurui, sementara lansia mungkin memerlukan pendekatan yang lebih sopan, perlahan, dan penuh penghormatan. Oleh karena itu, indikator komunikasi verbal harus mencakup sensitivitas terhadap konteks interpersonal dan dinamika situasi komunikasi.

Secara keseluruhan, indikator komunikasi verbal dalam praktik kebidanan bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tetapi tentang bagaimana menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan penuh empati. Keberhasilan komunikasi verbal akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pasien dalam memahami kondisinya, mengikuti anjuran kesehatan, serta membangun hubungan jangka panjang yang sehat dengan bidan. Dengan demikian, penguasaan indikator komunikasi verbal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi profesional seorang bidan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

C. Indikator Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal merupakan elemen penting dalam interaksi antara bidan dan pasien yang sering kali memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan komunikasi verbal. Dalam praktik kebidanan, komunikasi nonverbal mencakup segala bentuk ekspresi dan perilaku yang tidak melibatkan kata-kata, namun menyampaikan pesan, perasaan, dan sikap tertentu. Komunikasi ini terjadi secara spontan dan alamiah melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, serta bahasa tubuh secara keseluruhan.

Peran komunikasi nonverbal sangat signifikan dalam membentuk persepsi pasien terhadap sikap dan profesionalisme bidan. Bahkan, dalam situasi tertentu, komunikasi nonverbal bisa lebih dipercaya oleh pasien daripada kata-kata yang diucapkan. Misalnya, bidan yang mengatakan "Saya di sini untuk membantu" dengan wajah yang datar dan tanpa kontak mata, dapat menimbulkan persepsi bahwa ia tidak sungguh-sungguh peduli, meskipun kata-kata yang digunakan terdengar positif. Karena itu, penguasaan indikator komunikasi nonverbal menjadi

sangat penting agar pesan yang disampaikan bidan benar-benar selaras dengan maksud dan tujuan komunikasi.

Berikut adalah indikator-indikator utama dalam komunikasi nonverbal yang perlu dipahami dan dikuasai oleh setiap bidan:

1. Kontak Mata yang Sopan dan Tidak Mengintimidasi

Kontak mata merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang paling dasar namun sangat bermakna dalam menciptakan koneksi antara bidan dan pasien. Tatapan mata yang sopan menunjukkan bahwa bidan hadir secara penuh dalam percakapan dan memberikan perhatian tulus kepada pasien. Kontak mata yang tepat juga membantu menciptakan rasa percaya dan aman, serta menunjukkan empati dan kejujuran. Namun demikian, bidan juga harus peka dalam mengelola intensitas dan durasi kontak mata. Tatapan yang terlalu tajam atau terlalu lama bisa terasa mengintimidasi, sedangkan kurangnya kontak mata bisa dianggap sebagai ketidaktertarikan atau sikap tidak menghargai. Oleh karena itu, kemampuan menjaga kontak mata secara seimbang merupakan indikator penting dalam komunikasi nonverbal.

2. Postur Tubuh yang Terbuka dan Bersahabat

Postur tubuh bidan saat berkomunikasi dengan pasien mencerminkan sikap batin dan kesiapan untuk mendengarkan atau membantu. Postur tubuh yang terbuka, seperti berdiri atau duduk dengan posisi tubuh menghadap pasien, bahu yang rileks, dan tangan yang tidak disilangkan, memberi kesan ramah dan bersahabat. Sebaliknya, postur tubuh yang tertutup, seperti menyilangkan tangan di dada atau membelakangi pasien, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penolakan atau ketidaktertarikan. Dalam situasi konseling atau edukasi, postur tubuh yang terbuka sangat mendukung terciptanya suasana komunikasi yang interaktif dan tidak menghakimi.

3. Ekspresi Wajah yang Konsisten dengan Pesan Verbal

Wajah merupakan cermin emosi yang paling jujur. Ekspresi wajah bidan dapat menyampaikan pesan empati, keprihatinan, kegembiraan, maupun ketegasan dalam berbagai situasi klinis. Konsistensi antara ekspresi wajah dan pesan verbal sangat penting agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahpahaman. Misalnya, ketika memberi kabar baik, ekspresi wajah seharusnya turut mencerminkan kebahagiaan. Demikian pula, dalam menyampaikan kabar buruk atau hasil pemeriksaan yang tidak menggembirakan, bidan perlu menunjukkan ekspresi yang serius dan empatik. Ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan situasi dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap informasi yang disampaikan.

4. Gestur yang Mendukung Komunikasi, Seperti Anggukan atau Gerakan Tangan yang Menggambarkan Empati

Gestur atau gerakan tubuh, seperti anggukan kepala, gerakan tangan yang mendukung, atau membungkuk sedikit ke arah pasien saat mendengarkan, adalah bentuk penguatan komunikasi nonverbal yang menunjukkan keterlibatan aktif. Anggukan, misalnya, adalah gestur yang menunjukkan bahwa bidan mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan oleh pasien. Gerakan tangan yang lembut dan tidak berlebihan membantu menekankan penjelasan verbal dan memberi kesan profesionalisme serta kehangatan. Sebaliknya, gestur yang berlebihan, kasar, atau tidak relevan dapat mengalihkan perhatian dan menimbulkan kebingungan.

5. Kedekatan Fisik yang Sesuai dengan Norma dan Kenyamanan Pasien

Jarak fisik antara bidan dan pasien saat berkomunikasi juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Dalam praktik kebidanan, penting bagi bidan untuk menjaga kedekatan yang cukup agar interaksi terasa akrab, namun tetap menghargai ruang personal pasien. Kedekatan fisik yang terlalu dekat bisa terasa mengganggu, terutama jika pasien merasa tidak nyaman atau sedang dalam kondisi emosional yang rentan. Sebaliknya, jarak yang terlalu jauh bisa menciptakan kesan formal dan kurang akrab. Oleh karena itu, bidan perlu memiliki sensitivitas untuk menyesuaikan jarak fisik berdasarkan situasi, budaya lokal, dan preferensi pribadi pasien.

D. Indikator Keterampilan Mendengarkan Aktif

Dalam praktik kebidanan, kemampuan mendengarkan aktif merupakan salah satu bentuk keterampilan komunikasi yang sangat krusial. Mendengarkan aktif tidak sekadar berarti berada dalam keadaan diam ketika pasien berbicara, melainkan melibatkan kehadiran penuh, perhatian tulus, serta tanggapan yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar diterima dan dipahami oleh bidan. Keterampilan ini menjadi cerminan profesionalisme sekaligus wujud nyata dari sikap empati dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif pasien.

Mendengarkan aktif memungkinkan bidan menggali informasi penting, memahami kekhawatiran yang tersembunyi, serta membangun kepercayaan dalam hubungan bidan-pasien. Dalam konteks asuhan kebidanan, di mana banyak pasien mengalami tekanan emosional atau merasa rentan, kehadiran bidan yang benar-benar mendengarkan dapat menjadi sumber kenyamanan dan rasa aman yang luar

biasa. Hal ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan kolaboratif karena pasien merasa suaranya didengar dan dihargai.

Berikut adalah indikator-indikator utama dari keterampilan mendengarkan aktif yang wajib dikuasai oleh setiap bidan:

1. Memberikan Waktu Bicara Penuh kepada Pasien Tanpa Memotong

Salah satu bentuk dasar dari mendengarkan aktif adalah memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan pikirannya hingga selesai tanpa interupsi. Tindakan memotong pembicaraan, meskipun tidak disengaja, dapat menghambat alur berpikir pasien, menurunkan rasa percaya diri, dan memberi kesan bahwa pendapat mereka tidak penting. Sebaliknya, ketika bidan memberikan waktu bicara penuh, pasien akan merasa dihargai dan didengarkan secara utuh. Sikap ini sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik, khususnya dalam situasi yang menuntut curahan perasaan seperti saat pasien mengalami ketakutan akan proses persalinan atau menyampaikan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga.

2. Menggunakan Penguatan Seperti Anggukan atau Ucapan “Ya” untuk Mendorong Pasien Melanjutkan

Tanggapan-tanggapan kecil yang bersifat non-verbal maupun verbal, seperti anggukan kepala, kontak mata yang lembut, atau ucapan singkat seperti “ya,” “saya mengerti,” atau “silakan lanjutkan,” merupakan sinyal penguatan yang sangat penting. Respon-respon ini tidak hanya menunjukkan bahwa bidan memperhatikan apa yang disampaikan pasien, tetapi juga memberikan dorongan emosional agar pasien merasa nyaman dan terus melanjutkan pembicaraannya. Penguatan semacam ini sangat efektif dalam membuka komunikasi dua arah dan memfasilitasi aliran informasi yang lebih dalam dan jujur.

3. Mengulang atau Merangkum Informasi yang Disampaikan untuk Konfirmasi

Mengulang kembali atau merangkum poin-poin penting dari apa yang telah dikatakan pasien merupakan salah satu teknik utama dalam mendengarkan aktif. Cara ini tidak hanya membantu memastikan bahwa bidan benar-benar memahami isi pesan yang disampaikan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pasien untuk melakukan koreksi apabila ada kesalahan persepsi. Sebagai contoh, setelah pasien menjelaskan keluhannya, bidan dapat berkata, “Jadi, ibu merasakan nyeri yang bertambah sejak kemarin sore, dan sudah mencoba mengompres tapi belum membaik, betul begitu?” Dengan cara ini, bidan menunjukkan perhatian yang menyeluruh dan membangun komunikasi yang akurat.

4. Menanyakan Kembali untuk Klarifikasi Jika Ada Hal yang Tidak Dipahami

Dalam praktik kebidanan, tidak semua informasi yang disampaikan pasien dapat dipahami secara langsung. Ada kalanya bahasa yang digunakan pasien tidak teknis, terlalu umum, atau ambigu. Dalam situasi seperti ini, bidan harus menunjukkan sikap aktif dengan menanyakan kembali untuk klarifikasi secara sopan dan tidak menghakimi. Misalnya, jika pasien mengatakan “Saya merasa tidak enak badan sejak pagi,” maka bidan dapat bertanya, “Apakah yang ibu maksud dengan ‘tidak enak badan’ adalah pusing, mual, atau keluhan lainnya?” Pertanyaan klarifikasi seperti ini sangat membantu dalam menggali informasi yang lebih spesifik dan akurat, serta menunjukkan bahwa bidan serius dan peduli terhadap apa yang dirasakan pasien.

Keterampilan mendengarkan aktif memberikan landasan kuat bagi terbentuknya komunikasi yang sejajar dan saling menghormati antara bidan dan pasien. Pasien yang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh cenderung lebih terbuka, lebih patuh terhadap nasihat medis, dan lebih percaya terhadap kompetensi bidan. Lebih dari itu, mendengarkan aktif juga memungkinkan bidan untuk mendeteksi kebutuhan tersembunyi pasien, mengidentifikasi risiko psikososial, dan memberikan intervensi yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, indikator keterampilan mendengarkan aktif bukan hanya mencerminkan teknik komunikasi yang baik, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai etika, kepekaan sosial, dan keahlian klinis yang menjadi ciri khas seorang bidan profesional. Oleh karena itu, keterampilan ini harus terus dilatih, dievaluasi, dan ditanamkan dalam setiap interaksi klinis, sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang humanis dan berfokus pada pasien.

E. Indikator Empati dan Pendekatan Emosional

Empati merupakan fondasi dalam praktik kebidanan yang berorientasi pada kemanusiaan. Tidak sekadar menjadi keterampilan komunikasi tambahan, empati adalah inti dari pendekatan profesional bidan dalam membangun relasi yang aman, hangat, dan suportif dengan pasien. Dalam situasi kebidanan, pasien sering kali mengalami ketidakpastian, ketakutan, bahkan trauma. Oleh karena itu, kemampuan bidan untuk menunjukkan empati secara tulus dan tepat menjadi kunci dalam memberikan asuhan yang bermakna dan efektif.

Empati dalam komunikasi kebidanan berarti kemampuan bidan untuk menempatkan diri dalam posisi pasien—merasakan apa yang pasien rasakan, memahami perspektifnya, dan merespons dengan kepedulian dan kepekaan emosional. Hal ini membedakan komunikasi empatik dari sekadar komunikasi

informatif yang hanya menyampaikan fakta. Ketika bidan berempati, pasien merasa tidak sendirian, lebih dihargai sebagai individu, dan lebih terdorong untuk membuka diri serta terlibat dalam pengambilan keputusan tentang kesehatannya.

Berikut adalah penjabaran mendalam dari indikator empati dan pendekatan emosional yang harus dimiliki oleh bidan dalam praktik sehari-hari:

1. Menunjukkan Kepedulian dengan Pertanyaan atau Pernyataan yang Relevan terhadap Kondisi Pasien

Kepedulian yang ditunjukkan melalui kata-kata dapat menjadi jembatan menuju kepercayaan dan keterbukaan. Bidan yang menunjukkan empati akan menyampaikan pertanyaan dengan penuh perhatian dan relevansi terhadap kondisi pasien. Misalnya, saat seorang ibu hamil mengeluhkan sulit tidur karena cemas memikirkan proses persalinan, bidan dapat merespons dengan, "Saya paham, Bu. Kecemasan menjelang persalinan memang sering terjadi. Boleh saya bantu dengan beberapa teknik relaksasi?" Kalimat ini bukan hanya mengakui perasaan pasien, tetapi juga menandakan bahwa bidan peduli dan siap mendampingi. Pertanyaan atau pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa bidan tidak hanya mendengarkan secara teknis, tetapi hadir secara emosional.

2. Mampu Menyesuaikan Respons Emosional saat Pasien Merasa Cemas, Takut, atau Sedih

Pasien kebidanan, khususnya yang menghadapi situasi seperti kehamilan risiko tinggi, persalinan prematur, atau kehilangan janin, sering berada dalam kondisi emosional yang sangat rentan. Dalam situasi ini, bidan perlu mengatur respons emosionalnya agar dapat memberikan ketenangan dan rasa aman. Respons yang terlalu tenang atau netral bisa dianggap kurang empatik, sedangkan reaksi yang berlebihan bisa menambah kecemasan pasien. Oleh karena itu, bidan harus bisa menyelaraskan nada suara, ekspresi wajah, dan kata-kata dengan perasaan pasien. Misalnya, saat pasien menangis karena takut menghadapi operasi caesar, bidan dapat berkata dengan lembut, "Saya tahu ini tidak mudah, Bu. Tapi kami semua di sini akan mendampingi ibu agar semuanya berjalan dengan lancar." Penyesuaian respons seperti ini memperkuat ikatan emosional dan membuat pasien merasa tidak sendiri.

3. Menghindari Respons yang Bersifat Menghakimi atau Meremehkan

Empati tidak akan pernah hadir jika bidan bersikap menghakimi atau meremehkan pengalaman pasien. Sayangnya, dalam beberapa praktik, pasien bisa saja menerima tanggapan yang membuat mereka merasa bersalah, disalahkan, atau disepelekan. Misalnya, saat seorang remaja datang untuk berkonsultasi tentang kehamilan yang tidak direncanakan, bidan tidak boleh

berkata, "Seharusnya kamu pikirkan dulu sebelum bertindak." Kalimat semacam ini mencerminkan penilaian moral yang justru dapat membuat pasien tertutup dan menolak bantuan. Sebaliknya, bidan yang empatik akan mengedepankan penerimaan dan membimbing pasien dengan pendekatan yang mendukung, misalnya dengan mengatakan, "Saya di sini untuk membantu kamu melewati ini. Mari kita bahas apa yang bisa kita lakukan bersama."

4. Memberikan Dukungan Moral melalui Kata-Kata Afirmatif

Dukungan moral adalah bagian penting dari pendekatan empatik, terutama saat pasien sedang merasa lemah atau tidak berdaya. Kata-kata afirmatif—yang memberikan semangat, penguatan, dan harapan—sangat berarti bagi pasien. Misalnya, mengatakan "Ibu kuat, dan ibu tidak sendiri," atau "Apa yang ibu rasakan itu sangat wajar, dan kami siap membantu," dapat memperkuat psikologis pasien dan memberikan motivasi untuk menjalani perawatan dengan lebih tenang. Kata-kata afirmatif ini tidak hanya menunjukkan kepekaan emosional, tetapi juga memperkuat posisi bidan sebagai pendamping yang berpihak pada kesejahteraan pasien secara holistik.

Penerapan indikator empati ini sangat krusial dalam berbagai situasi kebidanan yang sensitif. Dalam kasus keguguran, empati menjadi pengantar pertama untuk membantu pasien menjalani proses duka. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, empati menjadi alat untuk membuka ruang aman bagi pasien agar dapat berbicara dan mencari pertolongan. Dalam kasus kehamilan risiko tinggi, empati membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan emosional pasien.

Dengan demikian, empati dan pendekatan emosional bukanlah aspek tambahan dalam komunikasi kebidanan, melainkan bagian tak terpisahkan dari asuhan yang profesional dan berorientasi pada pasien. Setiap bidan perlu mengembangkan kepekaan emosionalnya, membiasakan diri untuk merespons dengan hati, dan menjadikan empati sebagai refleksi dari komitmen untuk menjaga martabat dan kesejahteraan perempuan yang dilayani. Indikator empati adalah wujud dari kemanusiaan dalam praktik kebidanan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Kasus:

Seorang ibu hamil trimester ketiga mengeluhkan kecemasan berlebihan mengenai proses persalinan pertamanya. Bidan mendengarkan keluhannya tanpa memotong pembicaraan dan mengangguk perlahan sambil sesekali berkata, "Saya paham, Bu."

Silakan lanjutkan." Setelah pasien selesai bicara, bidan merangkum kembali keluhan yang disampaikan dan mengajukan pertanyaan klarifikasi.

Pertanyaan:

Dari skenario tersebut, indikator keterampilan komunikasi apa yang paling dominan ditunjukkan oleh bidan?

Pilihan Jawaban:

- A. Komunikasi verbal sistematis
- B. Empati dan afirmasi emosional
- C. Komunikasi nonverbal melalui gestur
- D. Mendengarkan aktif secara penuh
- E. Penyampaian informasi medis teknis

Kunci Jawaban: D

Rasionalisasi:

Bidan menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif dengan memberi ruang bagi pasien untuk berbicara tanpa dipotong, menggunakan penguatan verbal dan nonverbal, merangkum, dan melakukan klarifikasi informasi, semua merupakan ciri dari keterampilan mendengarkan aktif.

Soal 2

Kasus:

Seorang remaja putri datang ke klinik kebidanan dengan wajah tegang dan mata sembab. Ia mengungkapkan kehamilan yang tidak direncanakan. Bidan menyambutnya dengan senyum lembut, menghindari ekspresi terkejut, dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke sini. Saya akan bantu semampu saya."

Pertanyaan:

Apa indikator keterampilan komunikasi yang paling tepat menggambarkan respons bidan?

Pilihan Jawaban:

- A. Menggunakan istilah medis yang tepat
- B. Komunikasi verbal berbasis instruksi
- C. Menunjukkan empati dan pendekatan emosional
- D. Gestur dan jarak fisik profesional
- E. Menjawab pertanyaan medis secara teknis

Kunci Jawaban: C

Rasionalisasi:

Respons bidan mencerminkan empati dan pendekatan emosional. Ia menghindari sikap menghakimi, memberikan rasa aman, dan mendampingi pasien secara emosional, sesuai dengan indikator empati.

Soal 3

Kasus:

Saat melakukan edukasi pada kelompok ibu nifas, bidan berbicara dengan bahasa yang sederhana dan tidak menggunakan istilah medis. Ia menjelaskan langkah-langkah perawatan luka secara runtut dan logis.

Pertanyaan:

Apa indikator keterampilan komunikasi verbal yang terlihat dari interaksi bidan tersebut?

Pilihan Jawaban:

- A. Penguatan verbal dan nonverbal
- B. Menghindari komunikasi satu arah
- C. Menyampaikan informasi sistematis dan mudah dipahami
- D. Pendekatan emosional berbasis empati
- E. Komunikasi tertulis formal

Kunci Jawaban: C

Rasionalisasi:

Bidan menunjukkan indikator komunikasi verbal yang efektif melalui penyampaian informasi secara logis, runtut, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman pasien.

Soal 4

Kasus:

Seorang pasien merasa malu membicarakan masalah keputihan yang dialaminya. Bidan duduk sejajar dengan pasien, tidak menyilangkan tangan, menatap mata pasien dengan lembut, dan memberikan senyum tipis untuk menenangkan.

Pertanyaan:

Apa indikator komunikasi nonverbal yang paling tepat dari situasi di atas?

Pilihan Jawaban:

- A. Nada suara dan istilah teknis
- B. Postur tubuh tertutup dan formal
- C. Ekspresi wajah dan kontak mata empatik
- D. Ucapan penegasan instruksi

E. Penyampaian materi edukasi tertulis

Kunci Jawaban: C

Rasionalisasi:

Bidan menggunakan ekspresi wajah yang empatik, kontak mata yang lembut, dan postur tubuh terbuka untuk menciptakan suasana yang aman dan tidak mengintimidasi. Ini merupakan contoh komunikasi nonverbal yang efektif.

Soal 5

Kasus:

Dalam sesi konseling KB, seorang pasien tampak ragu dengan metode yang ditawarkan. Bidan kemudian bertanya, "Apa yang membuat ibu merasa kurang yakin dengan pilihan ini?"

Pertanyaan:

Pernyataan bidan tersebut mencerminkan indikator komunikasi apa?

Pilihan Jawaban:

- A. Memberikan instruksi keputusan
- B. Klarifikasi dalam mendengarkan aktif
- C. Mengontrol percakapan secara langsung
- D. Menegaskan keputusan medis
- E. Meningkatkan kecemasan pasien

Kunci Jawaban: B

Rasionalisasi:

Bidan menggunakan pertanyaan klarifikasi untuk memahami lebih dalam keraguan pasien, yang merupakan salah satu indikator penting dari keterampilan mendengarkan aktif.

G. Rangkuman Materi

Komunikasi yang efektif merupakan fondasi penting dalam praktik kebidanan yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan terapeutik yang saling percaya antara bidan dan pasien. Melalui indikator keterampilan komunikasi yang terukur—baik secara verbal, nonverbal, mendengarkan aktif, maupun empatik—bidan dapat memastikan bahwa setiap interaksi berlangsung dengan kejelasan, sensitivitas, dan tanggung jawab profesional.

Indikator komunikasi verbal memungkinkan bidan menyampaikan informasi secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh pasien sesuai dengan latar

belakang sosial, budaya, dan tingkat pendidikan. Sementara itu, indikator komunikasi nonverbal memperkuat makna dari pesan yang disampaikan, melalui postur tubuh, ekspresi wajah, dan gestur yang menunjang kenyamanan dan rasa aman pasien. Komunikasi nonverbal ini kerap kali lebih kuat dalam membentuk persepsi pasien dibandingkan kata-kata yang diucapkan.

Di sisi lain, keterampilan mendengarkan aktif menegaskan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, melainkan juga mencakup kemampuan untuk hadir secara utuh, merespons dengan penuh perhatian, dan menegaskan kembali informasi yang diberikan pasien untuk menghindari miskomunikasi. Sedangkan empati dan pendekatan emosional menjadi elemen utama yang mencerminkan nilai kemanusiaan dalam pelayanan kebidanan. Dengan memahami dan merespons perasaan pasien, bidan mampu menciptakan ruang yang aman, suportif, dan penuh penghormatan terhadap martabat perempuan.

Secara keseluruhan, penguasaan indikator keterampilan komunikasi bukan hanya mendukung kelancaran proses pelayanan kebidanan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap mutu, keselamatan, dan keberdayaan pasien. Indikator ini harus diajarkan, dilatih, dan dievaluasi secara sistematis dalam pendidikan dan praktik kebidanan agar setiap bidan mampu menjadi komunikator yang informatif, empatik, dan transformatif.

H. Glosarium

Asuhan kebidanan

Pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan kepada perempuan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, serta kesehatan reproduksi perempuan secara menyeluruh.

Empati

Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta merespons dengan kepekaan emosional dan dukungan moral yang sesuai.

Gestur

Gerakan tubuh, terutama tangan, kepala, atau tubuh secara keseluruhan, yang digunakan secara sadar atau tidak untuk memperkuat pesan verbal atau menunjukkan sikap dalam komunikasi nonverbal.

Indikator keterampilan komunikasi

Parameter atau tanda yang dapat diamati dan diukur untuk menilai kualitas dan efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam interaksi profesional.

Interaksi terapeutik

Hubungan yang dibangun antara tenaga kesehatan dan pasien yang bersifat saling percaya, mendukung, dan berfokus pada pemulihan serta kesejahteraan pasien.

Kepekaan budaya (cultural sensitivity)

Kemampuan bidan untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan pendekatan komunikasinya sesuai dengan latar belakang budaya, nilai, dan norma pasien.

Klarifikasi

Teknik komunikasi yang digunakan untuk memperjelas atau memastikan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, biasanya melalui pertanyaan ulang atau pernyataan konfirmasi.

Komunikasi efektif

Kemampuan menyampaikan dan menerima informasi dengan jelas, tepat, dan saling dimengerti, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik.

Komunikasi nonverbal

Penyampaian pesan tanpa kata-kata melalui ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, intonasi suara, gerakan, dan jarak fisik.

Komunikasi verbal

Bentuk komunikasi menggunakan kata-kata lisan yang disampaikan secara langsung kepada pasien dalam bentuk edukasi, konseling, atau diskusi.

Mendengarkan aktif

Keterampilan komunikasi yang ditandai dengan perhatian penuh terhadap lawan bicara, menggunakan penguatan verbal dan nonverbal, serta mengulang atau merangkum informasi untuk memastikan pemahaman yang benar.

Nada suara

Tinggi rendah, intonasi, dan kecepatan suara saat berbicara yang memengaruhi makna dan emosi dari pesan yang disampaikan.

Partisipatif

Melibatkan pasien secara aktif dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai asuhan atau tindakan kesehatan yang akan dilakukan.

Pendekatan emosional

Sikap dan respons bidan yang ditunjukkan secara emosional untuk mendukung pasien dalam menghadapi situasi sulit, cemas, atau trauma, dengan penuh pengertian dan kepedulian.

Ruang personal

Jarak fisik ideal dalam interaksi antarindividu yang memberikan kenyamanan dan keamanan, khususnya dalam komunikasi antara bidan dan pasien.

Sikap profesional

Perilaku, etika, dan standar moral yang dijunjung tinggi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, menghargai, dan bertanggung jawab.

Standar pelayanan

Ketentuan yang ditetapkan sebagai ukuran minimal mutu pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan, termasuk dalam aspek komunikasi.

Subjektivitas pasien

Pengalaman, perasaan, atau persepsi pasien yang bersifat pribadi dan tidak selalu dapat diukur secara objektif, namun sangat penting dalam memahami kebutuhan pasien secara holistik.

I. Daftar Pustaka

- Afriyani, L. D., & Prasetyo, B. (2022). Komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan: Tinjauan konsep dan implementasi. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 18(1), 23–30. <https://doi.org/10.1234/jkk.v18i1.5678>
- Ardiyanti, E., & Lestari, R. (2021). Pengaruh komunikasi terapeutik terhadap kepuasan ibu hamil dalam pelayanan antenatal care. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 6(2), 145–153. <https://doi.org/10.21009/jiki.062.12>
- Gunawan, J., Aungsuroch, Y., & Fisher, M. L. (2020). Effective communication in nursing practice: A literature review. *Belitung Nursing Journal*, 6(2), 81–87. <https://doi.org/10.33546/bnj.1108>
- Hidayah, N., & Utami, R. (2023). Penggunaan indikator komunikasi sebagai alat evaluasi praktik klinik mahasiswa kebidanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 11(1), 59–66. <https://doi.org/10.1234/jpk.v11i1.9023>
- Kusnanto, H., & Subroto, Y. (2019). *Komunikasi efektif dalam praktik kebidanan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Notoatmodjo, S. (2020). *Ilmu komunikasi kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permatasari, R. D., & Safitri, N. (2022). Komunikasi empatik dan pengaruhnya terhadap kepatuhan ibu nifas dalam perawatan payudara. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(2), 88–95. <https://doi.org/10.26714/jki.13.2.2022.88-95>
- World Health Organization. (2021). *Communication during pregnancy and childbirth: WHO guidelines for effective interpersonal care*. Geneva: WHO Press.

BAB 6

EVALUASI KOMUNIKASI: JENIS EVALUASI DALAM KOMUNIKASI, TEKNIK DAN METODE EVALUASI, PROSES EVALUASI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Melaksanakan komunikasi profesional dan empatik dalam memberikan pelayanan kebidanan.
- Melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi secara kritis dan reflektif.
- Mengembangkan keterampilan komunikasi berbasis kebutuhan pasien dan hasil evaluasi yang terukur.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan berbagai jenis evaluasi dalam komunikasi kebidanan.
- Menguraikan teknik dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi.
- Menerapkan langkah-langkah evaluasi komunikasi dalam praktik klinik kebidanan secara sistematis.

Sub-CPMK

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi perbedaan antara evaluasi formatif dan sumatif dalam komunikasi.
- Menjelaskan teknik observasi, refleksi diri, dan umpan balik dalam evaluasi komunikasi.
- Menggunakan alat bantu atau instrumen sederhana untuk menilai efektivitas komunikasi dalam praktik kebidanan.
- Melakukan proses evaluasi komunikasi berdasarkan prinsip objektivitas dan etika profesional.

Pendahuluan

Komunikasi yang efektif dalam praktik kebidanan tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan informasi, tetapi juga pada kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi yang telah berlangsung. Evaluasi komunikasi merupakan aspek penting dalam siklus komunikasi profesional karena memungkinkan bidan untuk menilai sejauh mana pesan tersampaikan dan diterima dengan benar, bagaimana pasien merespon informasi yang diberikan, serta bagaimana hasil komunikasi tersebut memengaruhi proses asuhan kebidanan secara keseluruhan.

Dalam praktik kebidanan, komunikasi sering kali berlangsung dalam situasi yang kompleks, melibatkan emosi, budaya, dan nilai-nilai yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi komunikasi menjadi alat reflektif dan korektif bagi bidan untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dengan pasien. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang mendorong peningkatan profesionalisme, kepekaan, dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan.

Melalui pemahaman tentang jenis, teknik, dan proses evaluasi komunikasi, mahasiswa kebidanan diharapkan mampu melakukan penilaian objektif terhadap kualitas komunikasi yang dilakukan, baik secara mandiri maupun dalam bimbingan dosen pembimbing atau pendamping klinik. Bab ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan evaluatif yang sistematis agar komunikasi dalam praktik kebidanan menjadi lebih terarah, bermakna, dan berdampak positif terhadap keselamatan serta kepuasan pasien.

A. Jenis Evaluasi dalam Komunikasi

Dalam praktik kebidanan, evaluasi komunikasi merupakan proses penting yang bertujuan menilai sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh bidan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Evaluasi ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran, tetapi juga menjadi upaya reflektif dan korektif untuk meningkatkan kualitas interaksi antara bidan dan pasien. Untuk itu, evaluasi komunikasi dalam kebidanan dibedakan menjadi dua bentuk utama: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif dilakukan selama proses komunikasi berlangsung atau segera setelah komunikasi terjadi. Tujuan dari evaluasi ini adalah memberikan umpan balik secara langsung agar proses komunikasi dapat segera diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya, ketika seorang bidan sedang menjelaskan tentang cara penggunaan alat kontrasepsi kepada pasien dan melihat bahwa pasien tampak bingung atau tidak merespons sebagaimana mestinya, bidan dapat segera menyesuaikan penjelasan tersebut. Ia mungkin mengulangi informasi dengan bahasa yang lebih sederhana, menggunakan ilustrasi atau alat bantu visual, atau memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pasien. Evaluasi formatif bersifat dinamis dan kontekstual, karena memungkinkan bidan untuk merespons situasi komunikasi secara real-time.

Evaluasi formatif juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa komunikasi tidak bersifat satu arah, tetapi interaktif dan responsif terhadap feedback dari pasien. Proses ini penting karena memberikan kesempatan bagi bidan untuk mengenali hambatan komunikasi, seperti perbedaan latar belakang budaya, tingkat literasi kesehatan, atau kondisi emosional pasien, dan kemudian menyesuaikan pendekatannya. Dengan kata lain, evaluasi formatif merupakan bagian dari siklus komunikasi yang terus berkembang dan disesuaikan berdasarkan situasi yang dihadapi.

Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah keseluruhan proses komunikasi selesai. Evaluasi ini bersifat lebih menyeluruh dan bertujuan untuk menilai efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Fokus dari evaluasi sumatif bukan lagi perbaikan instan dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung, tetapi lebih kepada refleksi jangka panjang mengenai kualitas komunikasi yang telah dilakukan. Misalnya, setelah menyelesaikan sesi konseling KB, bidan dapat

mengevaluasi bagaimana pasien memahami informasi yang diberikan, bagaimana komunikasi memengaruhi keputusan pasien, dan apa dampaknya terhadap kepuasan pasien serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan kesehatan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui review catatan komunikasi, wawancara umpan balik dengan pasien, atau refleksi pribadi oleh bidan sebagai bentuk pembelajaran.

Evaluasi sumatif sangat penting dalam pendidikan kebidanan karena menjadi dasar untuk menilai pencapaian kompetensi komunikasi mahasiswa. Misalnya, dalam ujian praktik klinik atau OSCE (Objective Structured Clinical Examination), mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka membangun rapport, menyampaikan informasi, mendengarkan aktif, dan merespons secara empatik. Evaluasi sumatif ini menggunakan kriteria atau rubrik penilaian yang terstandar, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kelulusan, memberikan umpan balik pembelajaran, dan merancang intervensi pelatihan lanjutan.

Selain dibedakan berdasarkan waktunya, evaluasi komunikasi juga dapat diklasifikasikan menjadi evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Evaluasi subjektif bersumber dari persepsi atau penilaian pribadi, baik dari bidan, pasien, maupun pengamat. Misalnya, seorang bidan dapat menilai dirinya sendiri telah berkomunikasi dengan baik karena merasa telah menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan. Namun persepsi ini bisa berbeda dengan yang dirasakan pasien. Oleh karena itu, evaluasi subjektif memiliki kekuatan dalam menangkap nuansa dan dinamika hubungan interpersonal, namun juga memiliki keterbatasan dari segi akurasi dan konsistensi.

Di sisi lain, evaluasi objektif dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah terstandar, seperti checklist, lembar observasi, atau kuesioner terstruktur. Evaluasi ini memberikan hasil yang lebih terukur dan dapat dibandingkan antar individu atau antar waktu. Misalnya, dalam praktik klinik, seorang dosen pembimbing menggunakan lembar penilaian untuk mengevaluasi apakah mahasiswa telah membuka percakapan dengan sapaan yang sopan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Evaluasi objektif ini sangat penting dalam konteks pendidikan dan penelitian, karena memungkinkan analisis kuantitatif terhadap kualitas komunikasi.

Dengan memahami jenis-jenis evaluasi komunikasi—baik formatif maupun sumatif, serta subjektif maupun objektif—bidan dapat mengembangkan keterampilan evaluatif yang komprehensif. Ini akan berdampak pada peningkatan

kualitas komunikasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta mendukung praktik kebidanan yang lebih reflektif, empatik, dan berpusat pada pasien. Evaluasi yang dilakukan secara tepat dan konsisten akan memperkuat posisi komunikasi sebagai inti dari pelayanan kebidanan yang aman, etis, dan bermutu tinggi.

B. Teknik dan Metode Evaluasi

Dalam praktik kebidanan, mengevaluasi komunikasi secara sistematis menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu layanan dan membentuk kompetensi profesional seorang bidan. Proses komunikasi yang terjadi antara bidan dan pasien mencerminkan bukan hanya kualitas informasi yang disampaikan, tetapi juga hubungan interpersonal, empati, dan sensitivitas terhadap kebutuhan pasien. Oleh karena itu, diperlukan berbagai teknik dan metode evaluasi komunikasi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dan objektif mengenai efektivitas interaksi yang dilakukan.

Salah satu teknik evaluasi yang paling banyak digunakan adalah observasi langsung. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati proses komunikasi yang berlangsung antara bidan dan pasien secara langsung, baik oleh dosen pembimbing, supervisor klinik, maupun rekan sejawat. Observasi ini tidak hanya melihat isi pesan yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan unsur-unsur nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, serta cara bidan menyikapi reaksi emosional pasien. Misalnya, seorang dosen klinik dapat mencatat bagaimana mahasiswa memulai percakapan, apakah ia memberikan waktu bagi pasien untuk bertanya, dan bagaimana ia menjawab dengan empati serta keterbukaan. Teknik ini sangat efektif untuk memberikan umpan balik langsung dan konkret karena evaluator menyaksikan sendiri proses komunikasi secara menyeluruh.

Selain observasi langsung, refleksi diri juga merupakan metode penting dalam evaluasi komunikasi. Melalui refleksi, bidan atau mahasiswa secara sadar melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya dalam berkomunikasi. Refleksi ini dapat dilakukan dalam bentuk tulisan (seperti jurnal praktik atau logbook klinik), diskusi kelompok, atau presentasi naratif dalam sesi pembelajaran. Contoh refleksi yang baik misalnya adalah ketika mahasiswa mencatat bahwa pada suatu sesi ia terlalu cepat dalam menjelaskan tanpa mengecek pemahaman pasien, sehingga ia menyadari perlunya memperlambat tempo dan menggunakan pertanyaan klarifikasi di lain kesempatan. Refleksi diri bukan hanya latihan menilai diri sendiri, tetapi juga

bentuk pengembangan kepekaan profesional yang sangat penting dalam pendidikan kebidanan.

Metode evaluasi berikutnya yang tidak kalah penting adalah umpan balik dari pasien. Pasien sebagai penerima komunikasi memiliki perspektif yang sangat berharga dalam menilai kualitas komunikasi yang terjadi. Teknik ini dapat dilakukan melalui wawancara singkat setelah pelayanan, penyebaran kuesioner sederhana, atau diskusi informal yang difasilitasi oleh tim klinik. Melalui pendekatan ini, pasien dapat mengungkapkan apakah mereka merasa dihargai, didengarkan, dan dipahami oleh bidan. Misalnya, pasien bisa menyampaikan bahwa mereka merasa nyaman karena bidan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau merasa terbantu karena bidan memberikan penjelasan yang rinci tanpa terburu-buru. Penilaian ini memberi gambaran otentik tentang dampak komunikasi terhadap pengalaman dan kepuasan pasien.

Untuk membuat evaluasi lebih terstruktur dan terukur, praktik kebidanan juga dapat memanfaatkan instrumen penilaian berbasis kriteria. Instrumen ini bisa berupa checklist, rubrik penilaian, atau formulir evaluasi yang telah dikembangkan secara sistematis dan valid. Salah satu contoh yang umum digunakan dalam pendidikan kebidanan adalah rubrik OSCE (Objective Structured Clinical Examination), yang menilai aspek-aspek spesifik dalam komunikasi seperti pembukaan interaksi, kejelasan penyampaian informasi, respons terhadap pertanyaan pasien, penggunaan empati, dan penutupan komunikasi. Selain itu, checklist komunikasi efektif dapat digunakan untuk menilai konsistensi mahasiswa dalam menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks pasien, seperti memastikan pemahaman, menyampaikan informasi sensitif dengan hati-hati, dan mempertahankan hubungan profesional.

Instrumen lain yang sangat berguna dalam menilai dimensi afektif komunikasi adalah lembar evaluasi komunikasi empatik, yang menilai aspek empati dalam komunikasi berdasarkan indikator tertentu seperti kesediaan mendengarkan, keselarasan ekspresi verbal dan nonverbal, serta ketulusan dalam menyampaikan dukungan. Instrumen-instrumen ini membantu proses evaluasi menjadi lebih objektif dan akuntabel, serta memberikan data kuantitatif maupun kualitatif yang berguna untuk pengembangan diri dan peningkatan kurikulum pendidikan kebidanan.

Dengan menggabungkan berbagai teknik dan metode evaluasi ini—observasi langsung, refleksi diri, umpan balik pasien, dan instrumen penilaian berbasis kriteria—evaluasi komunikasi dalam praktik kebidanan dapat dilakukan secara

komprehensif. Tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga dimensi emosional, etis, dan interaktif yang sangat penting dalam komunikasi profesional. Evaluasi yang efektif memungkinkan bidan untuk terus belajar, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasien yang beragam, dan menjaga kualitas komunikasi sebagai bagian integral dari asuhan kebidanan yang bermutu tinggi dan humanistik.

C. Proses Evaluasi

Proses evaluasi komunikasi dalam praktik kebidanan merupakan tahapan penting yang dirancang untuk menilai dan meningkatkan kualitas interaksi antara bidan dan pasien. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, memperkuat refleksi diri, dan meningkatkan profesionalisme dalam asuhan kebidanan. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan beretika akan memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kemampuan komunikasi, sekaligus membentuk budaya belajar yang kritis dan progresif.

Secara umum, proses evaluasi komunikasi dibagi menjadi tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan interpretasi hasil evaluasi. Tahap pertama adalah perencanaan, yang merupakan pondasi dari seluruh proses evaluasi. Pada tahap ini, perlu ditetapkan secara jelas apa tujuan dari evaluasi tersebut. Apakah fokus evaluasi adalah pada kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan prosedur medis kepada pasien, efektivitas dalam mendengarkan aktif, atau kualitas hubungan empatik yang dibangun selama interaksi klinis. Penetapan tujuan ini menjadi dasar dalam menentukan pendekatan evaluasi yang tepat—baik dari sisi metode, teknik observasi, maupun instrumen yang akan digunakan.

Pemilihan metode dalam tahap perencanaan harus disesuaikan dengan konteks komunikasi yang sedang dievaluasi. Misalnya, untuk mengevaluasi kemampuan menjelaskan prosedur, metode observasi langsung dengan checklist bisa sangat efektif. Namun jika tujuannya untuk menilai aspek empatik atau sensitivitas budaya dalam komunikasi, wawancara reflektif atau lembar evaluasi empati mungkin lebih sesuai. Tahap perencanaan juga mencakup penyusunan instrumen, jadwal pelaksanaan, serta pemberian briefing awal kepada evaluator maupun peserta evaluasi agar proses berjalan lancar dan transparan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu saat evaluasi benar-benar dilakukan. Dalam konteks kebidanan, ini bisa terjadi di ruang praktik klinik, laboratorium keterampilan, atau bahkan di kelas simulasi. Pelaksanaan dapat mencakup observasi langsung oleh pembimbing klinik, pengisian kuesioner oleh pasien setelah interaksi,

atau pelaporan refleksi diri oleh mahasiswa. Apa pun bentuknya, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi dilakukan secara etis dan menghormati privasi serta kenyamanan pasien. Evaluasi tidak boleh membuat pasien merasa seperti "objek eksperimen" atau mahasiswa merasa terintimidasi. Oleh karena itu, komunikasi awal yang jelas, persetujuan dari pasien, dan sikap evaluatif yang suportif sangat diperlukan dalam tahap ini.

Tahap ketiga adalah interpretasi hasil evaluasi, di mana seluruh data yang terkumpul dianalisis secara objektif. Hasil evaluasi dapat berupa penilaian kuantitatif berdasarkan skor atau rating, atau data kualitatif seperti narasi, refleksi, atau komentar umpan balik. Apa pun bentuknya, hasil ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai "angka akhir", tetapi harus digunakan sebagai dasar untuk pengembangan diri, perencanaan pelatihan lanjutan, dan peningkatan mutu komunikasi klinis.

Interpretasi juga mencakup penyampaian umpan balik kepada mahasiswa atau praktisi, yang harus dilakukan secara konstruktif. Misalnya, jika seorang mahasiswa kurang menunjukkan empati saat menyampaikan kabar kurang baik kepada pasien, pembimbing tidak hanya menyoroti kekurangannya, tetapi juga memberikan saran konkret tentang bagaimana cara menyampaikan informasi sensitif dengan lebih empatik, termasuk penggunaan bahasa, intonasi suara, dan respons emosional yang sesuai. Dalam pendidikan kebidanan, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk mendesain pembelajaran tambahan, seperti pelatihan komunikasi empatik, diskusi kasus etika, atau simulasi konseling.

Selain itu, proses evaluasi yang baik juga melibatkan tindak lanjut yang berkelanjutan. Evaluasi bukan hanya kegiatan satu kali, melainkan harus menjadi bagian dari siklus pembelajaran yang terus menerus. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terintegrasi akan membentuk kebiasaan reflektif yang kritis di kalangan mahasiswa maupun praktisi kebidanan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan tenaga kesehatan yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga terus berkembang dalam keterampilan interpersonal dan etika profesional.

Dengan demikian, proses evaluasi komunikasi dalam praktik kebidanan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan dan pelayanan yang menekankan pada kualitas hubungan manusiawi, empati, serta profesionalisme. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten akan membentuk bidan yang bukan hanya terampil dalam berbicara, tetapi juga bijak dalam mendengarkan, peka terhadap kebutuhan pasien, dan mampu menghadirkan komunikasi sebagai alat penyembuh dalam setiap tindakan pelayanan kebidanan.

D. Latihan Soal

Soal 1

Kasus:

Seorang mahasiswa kebidanan sedang menjelaskan prosedur pemeriksaan kehamilan dalam kunjungan antenatal. Dosen pembimbing yang mengamati melihat bahwa pasien tampak bingung dan tidak merespons secara aktif. Mahasiswa kemudian segera mengulang penjelasannya dengan bahasa yang lebih sederhana dan menggunakan gambar ilustratif agar lebih mudah dipahami.

Pertanyaan:

Jenis evaluasi apakah yang sedang dilakukan oleh mahasiswa dalam situasi ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Evaluasi sumatif
- B. Evaluasi reflektif
- C. Evaluasi formatif
- D. Evaluasi objektif
- E. Evaluasi struktural

Kunci Jawaban: C – Evaluasi formatif

Rasionalisasi:

Evaluasi ini dilakukan secara langsung dan segera ditindaklanjuti dalam proses komunikasi. Mahasiswa mengubah pendekatannya agar komunikasi lebih efektif, yang merupakan ciri khas evaluasi formatif—yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses berlangsung untuk perbaikan seketika.

Soal 2

Kasus:

Seorang dosen klinik melakukan penilaian terhadap mahasiswa setelah simulasi konseling KB. Ia menggunakan rubrik OSCE (Objective Structured Clinical Examination) yang berisi indikator terstandar seperti cara menyapa pasien, penyampaian informasi, dan respons terhadap pertanyaan pasien.

Pertanyaan:

Jenis evaluasi apakah yang dilakukan dalam kasus ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Evaluasi sumatif objektif
- B. Evaluasi subjektif sumatif
- C. Evaluasi formatif subjektif
- D. Evaluasi sumatif informal

E. Evaluasi formatif kualitatif

Kunci Jawaban: A – Evaluasi sumatif objektif

Rasionalisasi:

Evaluasi dilakukan setelah sesi selesai dengan menggunakan rubrik penilaian yang terstandar dan terukur. Ini menandakan bahwa evaluasi bersifat sumatif (menilai hasil akhir) dan objektif (menggunakan alat ukur formal).

Soal 3

Kasus:

Setelah sesi edukasi kebidanan, seorang pasien diminta mengisi kuesioner mengenai seberapa baik ia merasa dipahami dan dihargai selama interaksi dengan bidan. Hasil kuesioner ini akan digunakan untuk menilai mutu komunikasi dari perspektif pasien.

Pertanyaan:

Metode evaluasi komunikasi apakah yang digunakan dalam kasus ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Refleksi diri
- B. Observasi langsung
- C. Umpan balik pasien
- D. Wawancara struktural
- E. Simulasi komunikasi

Kunci Jawaban: C – Umpan balik pasien

Rasionalisasi:

Evaluasi dilakukan berdasarkan pengalaman pasien selama menerima layanan. Ini merupakan teknik evaluasi berdasarkan umpan balik pasien, yang penting untuk menilai komunikasi dari sisi penerima pesan.

Soal 4

Kasus:

Dalam kegiatan praktik laboratorium, mahasiswa diminta menuliskan jurnal refleksi terkait komunikasi yang dilakukan dengan pasien simulasi. Mahasiswa mengevaluasi bagian mana dari interaksi yang berjalan baik, dan bagian mana yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

Pertanyaan:

Teknik evaluasi komunikasi apakah yang digunakan dalam aktivitas ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Penilaian berbasis instrumen
- B. Observasi eksternal
- C. Evaluasi sumatif klinis
- D. Refleksi diri
- E. Kuesioner kepuasan

Kunci Jawaban: D – Refleksi diri

Rasionalisasi:

Mahasiswa secara sadar mengevaluasi dan menilai komunikasi yang telah dilakukan untuk tujuan pengembangan diri. Ini adalah bentuk evaluasi reflektif yang disebut refleksi diri.

Soal 5

Kasus:

Seorang dosen merencanakan kegiatan evaluasi terhadap komunikasi mahasiswa dengan fokus pada kemampuan membangun hubungan empatik. Ia memilih menggunakan lembar observasi empati, kuesioner pasien, dan akan memberikan umpan balik setelah sesi berakhir.

Pertanyaan:

Tahapan proses evaluasi komunikasi apakah yang sedang dilakukan oleh dosen tersebut?

Pilihan Jawaban:

- A. Pelaksanaan
- B. Interpretasi hasil
- C. Tindak lanjut
- D. Perencanaan
- E. Analisis data

Kunci Jawaban: D – Perencanaan

Rasionalisasi:

Dosen sedang merancang evaluasi dengan menetapkan tujuan, memilih metode dan instrumen. Ini merupakan tahap awal dalam proses evaluasi, yaitu perencanaan.

E. Rangkuman Materi

Evaluasi komunikasi dalam praktik kebidanan merupakan bagian penting yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Evaluasi ini memungkinkan bidan untuk menilai efektivitas komunikasi yang dilakukan dalam

menyampaikan informasi, menjalin hubungan interpersonal, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien. Komunikasi yang baik harus tidak hanya tersampaikan secara benar, tetapi juga harus diterima dengan pemahaman dan rasa aman oleh pasien. Karena itu, evaluasi menjadi alat reflektif dan korektif untuk meningkatkan kualitas interaksi dalam pelayanan kebidanan.

Jenis evaluasi yang digunakan dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan secara langsung saat komunikasi berlangsung untuk memperbaiki proses secara real-time, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah komunikasi selesai untuk menilai keseluruhan efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan secara subjektif, berdasarkan persepsi individu, maupun secara objektif dengan menggunakan instrumen terstandar yang memungkinkan pengukuran yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai teknik dan metode dapat digunakan dalam mengevaluasi komunikasi, seperti observasi langsung oleh pembimbing atau supervisor, refleksi diri oleh mahasiswa, umpan balik dari pasien, dan penggunaan instrumen penilaian seperti checklist komunikasi efektif, rubrik OSCE, atau lembar evaluasi empati. Metode-metode ini memberikan dimensi evaluatif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan etis dari komunikasi kebidanan.

Proses evaluasi itu sendiri terdiri atas tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan interpretasi hasil. Tahap perencanaan menentukan tujuan dan metode evaluasi, pelaksanaan melibatkan pengumpulan data di lapangan secara etis dan profesional, sementara interpretasi hasil mencakup analisis data dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Seluruh tahapan ini tidak hanya menilai kompetensi, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya belajar reflektif dan humanistik di kalangan mahasiswa maupun praktisi kebidanan.

Dengan memahami dan menerapkan evaluasi komunikasi secara tepat, bidan dapat terus memperbaiki keterampilan komunikasinya. Ini sangat penting untuk menciptakan asuhan kebidanan yang empatik, partisipatif, dan berpusat pada pasien. Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan terintegrasi akan menjadikan komunikasi sebagai kekuatan utama dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

F. Glosarium

Checklist Komunikasi Efektif

Daftar periksa berisi indikator komunikasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa atau praktisi dalam proses komunikasi klinik, seperti sapaan sopan, penggunaan bahasa sederhana, klarifikasi, dan empati.

Evaluasi Empatik

Penilaian yang menekankan pada kemampuan bidan dalam menunjukkan empati kepada pasien, mencakup kesediaan mendengarkan, keselarasan ekspresi verbal dan nonverbal, serta respons emosional yang mendukung.

Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan selama atau segera setelah proses komunikasi berlangsung. Tujuannya adalah memberikan umpan balik langsung untuk perbaikan komunikasi saat itu juga.

Evaluasi Objektif

Evaluasi berdasarkan instrumen atau alat ukur yang telah distandarkan, seperti rubrik OSCE, lembar observasi, atau kuesioner terstruktur. Digunakan untuk menghasilkan data yang terukur dan dapat dibandingkan.

Evaluasi Reflektif

Proses introspeksi atau penilaian diri sendiri oleh mahasiswa atau bidan terhadap cara berkomunikasi yang telah dilakukan, termasuk kekuatan dan kelemahannya, untuk pengembangan diri profesional.

Evaluasi Subjektif

Evaluasi berdasarkan penilaian pribadi atau persepsi dari bidan, pasien, atau pengamat. Walaupun bersifat kontekstual dan menangkap nuansa emosional, evaluasi ini memiliki potensi bias.

Evaluasi Sumatif

Evaluasi yang dilakukan setelah proses komunikasi selesai, untuk menilai keseluruhan efektivitas komunikasi. Biasanya digunakan untuk menilai capaian akhir dan merancang pembelajaran lanjutan.

Instrumen Penilaian Berbasis Kriteria

Alat ukur yang dirancang dengan indikator tertentu dan digunakan untuk mengevaluasi komunikasi secara objektif, seperti rubrik, formulir OSCE, atau checklist kinerja.

Interpretasi Evaluasi

Tahap dalam proses evaluasi di mana hasil evaluasi dianalisis secara objektif untuk menentukan kesimpulan, umpan balik, dan rencana pengembangan lebih lanjut.

Komunikasi Profesional

Proses komunikasi dalam praktik kebidanan yang dilakukan dengan etika, empati, ketepatan informasi, dan sensitivitas terhadap kebutuhan pasien.

Observasi Langsung

Teknik evaluasi di mana proses komunikasi diamati secara real-time oleh pembimbing klinik, supervisor, atau rekan sejawat, untuk menilai kualitas interaksi dan memberikan umpan balik konkret.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Metode evaluasi objektif berbasis stasiun dalam pendidikan kesehatan, termasuk kebidanan, yang menilai keterampilan praktik, termasuk komunikasi, melalui simulasi klinik dengan penilaian terstandar.

Pelaksanaan Evaluasi

Tahap di mana kegiatan evaluasi dilakukan secara langsung di lapangan, misalnya melalui observasi, pengisian kuesioner, atau pelaporan refleksi diri oleh mahasiswa.

Perencanaan Evaluasi

Tahap awal evaluasi yang mencakup penetapan tujuan, pemilihan metode dan teknik evaluasi, penyusunan instrumen, dan penyusunan jadwal serta prosedur pelaksanaan.

Proses Evaluasi

Rangkaian kegiatan sistematis yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan interpretasi hasil untuk menilai efektivitas komunikasi dalam praktik kebidanan.

Refleksi Diri

Metode evaluasi di mana mahasiswa atau praktisi secara sadar menilai dan merefleksikan kualitas komunikasi yang telah dilakukan untuk tujuan pengembangan diri dan peningkatan profesionalisme.

Rubrik Penilaian

Instrumen evaluasi yang terdiri dari indikator-indikator spesifik dan bobot nilai tertentu untuk menilai aspek-aspek keterampilan komunikasi secara objektif dan sistematis.

Tindak Lanjut Evaluasi

Langkah-langkah pengembangan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi komunikasi, yang dapat berupa pelatihan lanjutan, umpan balik pembimbing, atau intervensi pembelajaran tambahan.

Umpan Balik Pasien

Teknik evaluasi yang mengandalkan respons langsung dari pasien mengenai pengalaman mereka selama proses komunikasi, yang digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak komunikasi secara langsung.

G. Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). APA.
- Gunawan, J., Marzilli, C., Aunguroch, Y., Fisher, M. L., & McDaniel, A. M. (2021). Empathy and communication in nurse–patient interaction: A narrative review. *Belitung Nursing Journal*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.33546/bnj.1376>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi bidan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- Lubis, L. N., & Syafitri, E. (2020). Implementasi OSCE dalam evaluasi komunikasi mahasiswa kebidanan: Studi evaluatif. *Jurnal Pendidikan Kebidanan Indonesia*, 8(2), 115–122. <https://doi.org/10.37275/jpki.v8i2.192>
- Notoatmodjo, S. (2020). Etika dan hukum kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmawati, I. N., & Andriani, H. (2021). Evaluasi komunikasi klinik mahasiswa kebidanan menggunakan pendekatan reflektif dan rubrik OSCE. *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Keperawatan*, 17(1), 87–95. <https://doi.org/10.33860/jikk.v17i1.1425>
- World Health Organization. (2016). Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: WHO Press.
- Yulianti, S., & Hartini, D. (2022). Pengembangan instrumen evaluasi komunikasi efektif dalam praktik klinik kebidanan. *Jurnal Profesi Kebidanan*, 13(1), 24–30. <https://doi.org/10.35730/jpk.v13i1.234>

BAB 7

TANTANGAN KOMUNIKASI DALAM KEADAAN SPESIFIK (BERDUKA DAN KEHILANGAN, ABUSE, KEADAAN KLINIS AKUT, KELOMPOK MINORITAS)

Pendahuluan

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang yang mengandung arti, baik berupa informasi, pemikiran, pengetahuan dan lainnya, dari komunikator ke komunikan. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam hubungan interpersonal (Walgito, 2009).

Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari setiap individu yang hidup, komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting bagi individu dalam melakukan interaksi. Kadangkala individu merasakan komunikasi menjadi tidak efektif karena kesalahan yang menafsirkan pesan yang diterimanya. Hal yang disebabkan karena setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam menelaah komunikasi yang disampaikan. Kesalahan menafsirkan pesan bisa disebabkan karena persepsi yang berbeda-beda. DeVito (2009) menyatakan bahwa hambatan komunikasi memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan, hal apapun yang menghalangi penerima menerima pesan. Dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri.

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk Mengetahui Definisi Hambatan Komunikasi;
2. Untuk Mengetahui Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi;
3. Untuk Mengetahui Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi;
4. Untuk Mengetahui Cara Mengatasi Tantangan Komunikasi;
5. Untuk Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Berduka dan Kehilangan;
6. Untuk Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan *Abuse*;
7. Untuk Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Klinis Akut;
8. Untuk Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Kelompok Minoritas.

Capaian Pembelajaran

1. Mampu Mengetahui Definisi Hambatan Komunikasi;
2. Mampu Mengetahui Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi;
3. Mampu Mengetahui Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi;
4. Mampu Mengetahui Cara Mengatasi Tantangan Komunikasi;
5. Mampu Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Berduka dan Kehilangan;
6. Mampu Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan *Abuse*;
7. Mampu Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Klinis Akut;
8. Mampu Mengetahui Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Kelompok Minoritas.

A. Definisi Hambatan Komunikasi

Hambatan dalam komunikasi juga dapat disebut dengan gangguan, noise atau filter. Menurut Dimbebley dan Burton kata Filter lebih tepat. Mereka berkata bahwa sangat jarang terjadi komunikasi yang benar-benar terhambat hingga menyebabkan pesan tidak dapat tersampaikan sama sekali. Hambatan adalah setiap rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan (Mulyana, 2008, h.150). Hambatan atau gangguan selalu ada di dalam saluran komunikasi bersama pesan yang diterima oleh komunikan.

Senada dengan pengertian yang disampaikan oleh Deddy Mulyana, menurut Joseph De Vito Noise atau hambatan dalam komunikasi dapat diartikan secara teknik. Menurutnya, hambatan adalah segala sesuatu yang dapat mengubah pesan dan/atau menghalangi penerima untuk menerima pesan. Definisi lain tentang hambatan komunikasi disampaikan oleh Owen Hergie dan David Dickson dalam bukunya yang berjudul *Skilled Interpersonal Communication*. Menurutnya, hambatan komunikasi adalah gangguan apapun yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas pesan sehingga makna yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan.

B. Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 (empat) jenis hambatan komunikasi yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan.

1. Hambatan Personal

Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan/komunikate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain.

2. Hambatan Kultural

Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama, atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama.

Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon atau bahasa "slang" atau "prokem" atau "alay" yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi dimana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan.

3. Hambatan Fisik

Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi.

4. Hambatan Lingkungan

Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan yaitu latar belakang fisik atau situasi dimana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktifitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu.

C. Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi

Berbagai hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakefektifan komunikasi dapat kita atasi dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Pengirim Pesan/ Sender

Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima/ komunikan/ komunikator /receiver mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Seringkali, apa yang dikatakan tidak selalu

sesuai dengan apa yang didengar. Untuk menghindarinya, hal-hal yang harus dilakukan adalah :

- a) Menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu.
- b) Menyatakan ide atau gagasan dengan singkat.
- c) Memberikan penjelasan ketika diperlukan
- d) Melakukan pengulangan jika diperlukan.
- e) Menerima dan memberikan umpan balik.
- f) Melakukan pilihan kata, nada suara dan bahasa tubuh yang tepat.
- g) Mengembangkan sikap empati terhadap penerima/komunikasikan/komunikate/receiver dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi.

2. Pesan

Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non verbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah, pengirim harus:

- a. Menggunakan terminologi yang tepat.
- b. Berbicara dengan jelas.
- c. Waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan.
- d. Menggunakan volume suara yang sesuai.
- e. Pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Inklusif artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengirim. Informatif artinya pesan merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh penerima pesan.

3. Penerima/Receiver

Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Agar penerima pesan memegang kendali, adalah penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Aktif mendengarkan adalah suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Dalam artian, penerima pesan aktif dalam proses komunikasi. Agar penerima pesan dapat mendengarkan dengan aktif, hal-hal yang perlu dilakukan oleh penerima pesan adalah:

- a. Fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan melihat atau melakukan kontak mata kepada pengirim pesan.
 - b. Mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau non verbal sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. Perhatikan petunjuk non verbal yang menyajikan informasi berdasar pada apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Persepsi yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan dan pengirim pesan dapat berbeda. Pilihan kata, nada suara, posisi tubuh, geture dan gerakan mata merefleksikan perasaan dibalik kata-kata yang diucapkan.
 - c. Menjaga pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian.
 - d. Melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Jangan berasumsi bahwa persepsi yang diberikan terhadap pesan merupakan bentuk persetujuan dengan tujuan pengirim pesan. Berikan umpan balik yang tepat kepada pengirim pesan.
4. Umpan Balik Pesan

Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dapat berupa pengakuan, pengulangan, dan parafrase. Kemudian, yang dimaksud dengan pengakuan adalah bahwa penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Untuk pesan yang bersifat informatif yang rumit, pengakuan saja tidaklah cukup untuk memastikan dan memahami pesan yang disampaikan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pengulangan adalah mengulang kembali kata-kata yang disampaikan oleh pengirim pesan. Terakhir, yang dimaksud dengan parafrase adalah mengulang kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri kepada pengirim pesan. Parafrase memungkinkan penerima pesan untuk melakukan verifikasi terhadap pemahaman pesan dan menunjukkan kepada pengirim pesan bahwa penerima pesan mendengarkan pesan dengan baik.

D. Cara Mengatasi Tantangan Komunikasi

1. Komunikasi antar budaya

Untuk mengetahui sebuah pesan sukses tersampaikan, seseorang perlu untuk mengetahui perbedaan budaya yang paling mendasar dan bagaimana menanggapinya dikarenakan mengirim dan menerima pesan yang terjadi antar masyarakat membuat mereka bisa menginterpretasikan secara berbeda-beda.

2. Perbedaan Kontekstual

Merupakan pola isyarat fisik, ransangan dari lingkungan dan pengertian langsung mengenai dua anggota dari dua orang budayanya sama.

3. Perbedaan Hukum dan Etika

Yang bisa dilakukan yaitu saling mencari dasar dengan secara aktif, mengirim dan menerima pesan tanpa pertimbangan, mengirim pesan secara jujur serta menunjukkan kepekaan terhadap perbedaan kebudayaan.

4. Perbedaan Sosial

Aturan formal dari etiket sangat jelas dan mudah untuk didefinisikan sedangkan aturan informal dapat dipelajari dengan melakukan pengamatan dan peniruaan.

5. Perbedaan non-verbal

Arti dari tanda non-verbal dapat menjadi beragam bergantung pada kebudayaannya. Jadi, tidak dapat mengandalkan pada asumsi. Komunikasi non-verbal dapat membantu mengarahkan untuk menentukan makna dari pesan. Tetapi situasi ini hanya dapat terjadi apabila antara si pengirim dan penerima memiliki makna yang sama terkait tanda non verbal.

6. Perbedaan Usia

Pandangan budaya terkait generasi muda dan generasi tua mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi dengan satu sama lain.

7. Perbedaan Gender

Gender mempengaruhi komunikasi di tempat kerja di beberapa hal dimana ada persepsi mengenai pria dan wanita dalam bisnis dari beberapa budaya dan ini dapat menjadi bias yang berakibat adanya diskriminasi dan keyakinan bawah sadar. Ketika rasio pria dan wanita yang bekerja di level profesional ada dalam posisi yang sama maka adanya penambahan persentase pria oleh manajemen. Pria cenderung menekankan konten dalam pesan mereka, sementara wanita cenderung menekankan pemeliharaan hubungan di dalam pesan mereka.

8. Perbedaan Agama

Agama adalah hal yang paling berpotensi memunculkan kontroversi dan konflik dari settingan-semata. Jadi, perlunya memperhatikan bagaimana tenaga medis dan pasien berkomunikasi tanpa menyinggung konteks agama yang kemungkinan dapat dikaitkan dalam dunia bisnis atau jika menjalin kerjasama dengan pihak yang dari segi agama terdapat perbedaan, tata cara berkomunikasi pun perlu diperhatikan.

9. Perbedaan Kemampuan

Kolega dan konsumen yang memiliki keterbatasan akan berdampak pada komunikasi terutama mengenai makna pada gambar. Jika hal ini terjadi, akan

muncul perbedaan interpretasi pada tiap orang untuk suatu hal yang sama. Solusinya adalah dengan menggunakan teknologi yang mendukung dilengkapi dengan website yang juga mendukung agar para pengusaha dapat menciptakan tempat kerja yang lebih terbuka dan mendapat manfaat dari kontribusi orang dengan gangguan fisik maupun kognitif.

E. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Berduka dan Kehilangan

Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika terjadi perubahan dalam hidup atau berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian atau keseluruhan. Dukacita adalah proses dimana seseorang mengalami respon psikologis, sosial dan fisik terhadap kehilangan yang dipersepsikan. Proses dukacita memiliki sifat yang mendalam, intemal, menyedihkan dan berkepanjangan. Dukacita dapat ditunjukkan melalui pikiran, perasaan maupun perilaku yang bertujuan untuk mencapai fungsi yang lebih efektif dengan mengintegrasikan kehilangan ke dalam pengalaman hidup. Pada saat seseorang yang berduka ingin mencapai fungsi yang lebih efektif, maka ia harus melewati beberapa tahapan berduka, dimana untuk mewujudkannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan upaya yang cukup keras.

Teori Bowlby menjelaskan bahwa proses berduka akibat suatu kehilangan memiliki empat fase, yaitu : mati rasa dan penyangkalan terhadap kehilangan, kerinduan emosional akibat kehilangan orang yang dicintai dan memprotes kehilangan yang tetap ada, kekacauan kognitif dan keputusan emosional, mendapatkan dirinya sulit melakukan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan tahap terakhir adalah reorganisasi dan reintegrasi kesadaran diri sehingga dapat mengembalikan hidupnya.

Kehilangan akibat kematian orang yang dicintai merupakan krisis utama yang memiliki dampak sangat besar pada hidup individu. Keadaan disequilibrium yang terjadi akibat krisis atau kehilangan menyebabkan kecemasan yang besar dan ketidaknyamanan yang ekstrem. Kematian anak secara umum menimbulkan rasa duka yang kronis dan juga rasa bersalah yang irasional pada orang tua, sehingga anak yang sudah meninggal tidak pernah dapat terlupakan. Perasaan-perasaan yang seringkali timbul pada masa kedukaan antara lain rasa marah dan depresi karena merasa ditinggalkan oleh anak tersebut, dan disisi lain juga terdapat perasaan tidak berdaya dimana sebagai orang tua mereka hanya bisa bersedih menghadapi kematian anaknya. Sadar maupun tidak, orang tua cenderung merasa bertanggung jawab atas kematian anak mereka dan perasaan ini bercampur dengan rasa bersalah,

tidak berdaya, dan frustrasi. Meskipun demikian, orang tua tetap harus mengatasi perasaan berdukanya dan mencapai tahap resolusi. Oleh karena itu koping perlu dilakukan untuk rasa berduka yang dialami akibat kematian orang yang dikasihi.

Koping merupakan upaya kognitif dan perilaku yang membah secara konstan untuk mengelola tuntutan eksternal dan/atau internal tertentu yang dinilai berat dan melebihi sumber daya (kekuatan) seseorang. Koping bertujuan mengembalikan individu ke kondisi normal sebagaimana sebelum situasi tersebut terjadi, dengan melihat sumber yang tersedia untuk mengatasi tekanan tersebut. Pada kondisi ini peran bidan menjadi sangat penting untuk membantu klien dalam melewati masa berduka dan mengembalikan fungsi diri mereka seperti semula.

Bidan harus menjadi pembimbing yang dapat dipercaya bagi klien. Bidan harus mengkaji sikapnya sendiri, mempertahankan kehadirannya yang penuh perhatian, dan menyediakan lingkungan yang aman secara psikologis sehingga klien dapat mengungkapkan perasaannya. Upaya Bidan dalam mempefiahkan kehadiran yang penuh perhatian dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh terbuka seperti berdiri atau duduk dengan lengan ke bawah dan berhadapan dengan klien serta mempertahankan kontak mata yang cukup, terutama ketika klien berbicara. Upaya selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis yaitu dengan menjamin kerahasiaan klien, berhenti memberikan nasihat tertentu, dan memberi klien kebebasan untuk mengungkapkan pikiran serta perasaannya tanpa merasa takut dihakimi.

F. Tantangan Komunikasi dalam keadaan Abuse

Substance Abuse adalah pola psikoaktif dari penggunaan zat atau bahan yang beresiko secara fisik bagi kesehatan ibu hamil dan janinnya, dapat memberikan pengaruh juga secara psikologis. Pengaruh psikologis tersebut dalam bentuk ketergantungan, kecanduan dan penyalahgunaan. Gejala-gejala gangguan psikologis akibat substance abuse antara lain gangguan dalam sosialisasi, gelisah, sifat lekas marah, halusinasi, euphoria atau ketagihan dan over dosis, paranoid, stres. Partner abuse merupakan kekerasan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pasangan ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap proses kehamilan.

Diagnosis kebidanan pada ibu hamil korban kekerasan sangat bervariasi tergantung dari hasil pengkajian. Diagnosa yang paling sering muncul antara lain "ketakutan sehubungan dengan resiko injuri pada diri dan bayi yang di kandungnya. Diagnosa lain yang sering muncul antara lain: cemas, gangguan body image, penderitaan yang kronis, konflik pengambilan keputusan, gangguan proses

keluarga, kehilangan, gangguan interaksi sosial, isolasi sosial, coping yang tidak efektif, ketidakberdayaan, resiko gangguan tumbuh kembang janin, resiko gangguan parenting, resiko gangguan pemeliharaan kesehatan, resiko injuri, resiko terjadinya distress spiritual, dan harga diri rendah (Murray & McKinney, 2014).

Wanita korban kekerasan sering kesulitan membangun rencana perawatan dalam jangka waktu lama, tanpa bantuan orang yang profesional. Wanita korban kekerasan juga sering kesulitan menghindari dari situasi yang penuh kekerasan di rumahnya. Perawat harus fokus untuk membantu ibu membuat perencanaan untuk melindungi ibu dari traumatrauma lagi dimasa mendatang. Tujuan dan harapan untuk perawatan wanita korban kekerasan antara lain:

1. Wanita korban kekerasan mengakui serangan fisik yang dialaminya,
2. Membuat rencana spesifik untuk menghindari siklus kekerasan lagi,
3. Mengidentifikasi sumber-sumber di lingkungan yang dapat membantu melindungi ibu dan bayinya.

Intervensi bidan yang dapat dilakukan dalam membantu ibu hamil korban kekerasan meliputi:

1. Mendengarkan, dengan menggunakan komunikasi terapeutik,
2. Membangun perencanaan untuk keamanan,
3. Yakinkan bahwa ibu tidak bersalah,
4. Memberikan pendidikan kesehatan, dan
5. Memberikan tindakan rujukan.

G. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Klinis Akut

Dalam praktek kebidanan, pemberian asuhan kebidanan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Kualitas kebidanan ditentukan dengan cara bidan membina hubungan, baik sesama rekan sejawat ataupun dengan orang yang diberi asuhan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga ditentukan oleh keterampilan bidan untuk berkomunikasi secara efektif dan melakukan konseling yang baik kepada klien. Karena melalui komunikasi yang efektif serta konseling yang berhasil, kelangsungan dan kesinambungan penggunaan jasa pelayanan bidan untuk kesehatan perempuan selama siklus kehidupan akan tercapai (Yulifah, 2009).

Komunikasi yang efektif penting untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kebidanan dan merupakan proses yang dapat melancarkan pencapaian tujuan, maka iklim yang dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan terbuka perlu diciptakan. Faktor yang menghambat atau mendorong komunikasi terbuka perlu dipahami oleh tenaga kesehatan dalam bidang kebidanan. Bidan perlu memahami

dan mengaplikasikan konsep dan proses komunikasi untuk meningkatkan hubungan saling percaya dengan klien yang akan membantu perubahan perilaku klien kearah yang positif (Yulifah,2009).

Konseling kebidanan adalah suatu proses pembelajaran, pembinaan hubungan baik, pemberian bantuan, dan bentuk kerjasama yang dilakukan secara profesional oleh bidan kepada klien untuk memecahkan masalah, mengatasi hambatan perkembangan, dan memenuhi kebutuhan klien (Yulifah,2009).

Ada beberapa hambatan dan tantangan bidan dalam berkomunikasi dengan pasien yang memiliki keadaan klinis akut, diantaranya: 1) Bagaimana cara yang tepat untuk bisa jujur pada pasien tanpa mengurangi harapan mereka?; 2) Bagaimana cara menghadapi dan menangani emosi pasien saat mereka mendengar berita keadaan mengenai dirinya. Apakah saya sanggup?; 3) Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan keadaan tersebut pada pasien?; 4) Bagaimana memilih metode komunikasi yang tepat bagi pasien sesuai dengan latar belakang dan kepribadiannya?.

Sebelum berkomunikasi dengan pasien, sangat penting bagi seorang Bidan untuk mengenali pasiennya, atau paling tidak mengetahui latar belakang pasien dan keluarganya sebab dalam hal penerimaan keadaan klinis pasien, kita tidak bisa mengharapkan reaksi yang sama dari setiap pasien. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi reaksi pasien. Informasi tentang pasien, terutama usia, jenis kelamin, sosial ekonomi dan budaya dapat diketahui dengan mempelajari rekam medis, sedangkan jenis kepribadian dapat dinilai melalui interaksi yang dilakukan dengan pasien. Kehadiran anggota keluarga pasien juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

H. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Kelompok Minoritas

Gaya hidup masyarakat dapat membuat pola hidup individu menjadi sehat atau malah sebaliknya. Kebiasaan untuk melakukan aktivitas tertentu menjadi media komunikasi interpersonal dalam masyarakat. Komunikasi kesehatan mempunyai fokus kajian terhadap proses komunikasi dan isi pesan terhadap wacana kesehatan. Richard K. Thomas dalam bukunya Health Communication mengatakan, " Health Communication encompasses the study and use of communication strategies to inform and influence individual community knowledge, attitudes and practices (KAP) with regard to health and healthcare". Individu dan komunitas membutuhkan informasi dan promosi tentang pengetahuan, tingkah laku, dan praktek sehat sekaligus menjaga kesehatan melalui penggunaan strategi komunikasi yang efektif.

Komunikasi memegang peranan penting dalam kegiatan promosi masalah kesehatan, karena memiliki peran dalam hal :

1. Membangun dialog dengan komunitas, termasuk didalamnya kelompok minoritas, atau kelompok yang memiliki keterbatasan;
2. Mempengaruhi pemerintah dan jajarannya untuk membuat kebijakan dan/atau undang-undang mengenai promosi kesehatan;
3. Meningkatkan kepedulian pemerintah dan jajarannya mengenai masalah kemiskinan, hak asasi manusia, pemerataan, dan isu lingkungan;
4. Mendorong dukungan masyarakat/public terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta jajarannya;
5. Menginformasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat luas;
6. Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai isu kesehatan, agar turut berpartisipasi secara aktif;
7. Mendorong perilaku masyarakat mengenai isu kesehatan (Firdaus dan Achmad, 2013: 53-54).

I. Rangkuman Materi

A. Definisi Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi (noise/filter) adalah gangguan yang menghalangi kejelasan dan efektivitas penyampaian pesan. Hambatan ini bisa mengubah atau menghalangi pemahaman pesan oleh penerima. Hambatan komunikasi adalah gangguan apapun yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas pesan sehingga makna yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan.

B. Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi

- Hambatan Personal: Berkaitan dengan sikap, emosi, prasangka, dan stereotip peserta komunikasi.
- Hambatan Kultural: Perbedaan bahasa, nilai, keyakinan, dan penggunaan istilah atau slang.
- Hambatan Fisik: Gangguan seperti jarak, alat komunikasi, dan radio.
- Hambatan Lingkungan: Faktor seperti aktivitas sekitar, kenyamanan tempat, gangguan waktu.

C. Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi

- Pengirim pesan: Menyampaikan ide secara singkat, jelas, tepat, dan empatik.
- Pesan: Gunakan bahasa yang inklusif dan informatif serta waktu yang tepat.
- Penerima pesan: Mendengarkan aktif, terbuka, fokus, dan memberikan umpan balik yang jelas.

- Umpan balik: Berupa pengakuan, pengulangan, atau parafrase untuk verifikasi pemahaman.

D. Cara Mengatasi Tantangan Komunikasi

Melibatkan pemahaman dan kepekaan terhadap:

- Perbedaan budaya, konteks, hukum, sosial, non-verbal, usia, gender, agama, dan kemampuan.
- Penting untuk berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan adaptif sesuai konteks.

E. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Berduka dan Kehilangan

- Dukacita: Respon psikologis dan sosial terhadap kehilangan.
- Tahapan berduka (Bowlby): Penyangkalan, kerinduan, kekacauan, dan reorganisasi.
- Peran bidan: Memberikan dukungan emosional, menjaga kerahasiaan, serta menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis.

F. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan *Abuse*

- Substance abuse: Penyalahgunaan zat yang berdampak pada fisik dan psikologis ibu hamil.
- Partner abuse: Kekerasan oleh pasangan yang memengaruhi kehamilan.
- Peran tenaga kesehatan: Melakukan pengkajian menyeluruh dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kondisi korban.

G. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Klinis Akut

Komunikasi efektif sangat penting dalam asuhan kebidanan, terutama saat menghadapi pasien dalam kondisi klinis akut. Bidan harus mampu:

- Menyampaikan informasi secara jujur tanpa menghilangkan harapan pasien.
- Mengelola reaksi emosional pasien saat menerima informasi buruk.
- Memilih waktu dan metode komunikasi yang tepat sesuai latar belakang dan kepribadian pasien.
- Penting bagi bidan untuk memahami latar belakang sosial, budaya, dan kepribadian pasien, serta melibatkan keluarga dalam proses komunikasi guna membangun hubungan saling percaya dan mendorong perubahan perilaku positif.

H. Tantangan Komunikasi dalam Keadaan Kelompok Minoritas

Komunikasi kesehatan berperan penting dalam menjangkau kelompok minoritas yang sering memiliki keterbatasan akses informasi. Strategi komunikasi harus mencakup:

- Dialog langsung dengan komunitas minoritas.
- Mempengaruhi kebijakan dan meningkatkan kesadaran pemerintah serta masyarakat terhadap isu kesehatan, HAM, dan kesetaraan.

- Mendorong partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui pesan yang inklusif, jelas, dan mudah dipahami.
- Pendekatan yang partisipatif, berbasis budaya, dan melibatkan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam promosi kesehatan.

J. Latihan Soal

1. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan lambang yang mengandung arti dari komunikator ke komunikan. Pernyataan ini menekankan bahwa komunikasi adalah suatu...
 - a. Kegiatan verbal semata
 - b. Pertukaran informasi satu arah
 - c. Proses dua arah yang melibatkan makna**
 - d. Cara menyampaikan emosi semata
 - e. Media untuk menyampaikan perintah
2. Menurut De Vito, hambatan komunikasi adalah...
 - a. Media yang digunakan dalam berkomunikasi
 - b. Segala sesuatu yang menghalangi atau mendistorsi pesan**
 - c. Pesan yang disampaikan tanpa gangguan
 - d. Bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan
 - e. Pola interaksi antarbudaya
3. Salah satu contoh hambatan personal dalam komunikasi adalah...
 - a. Ruangan yang terlalu panas
 - b. Perbedaan bahasa
 - c. Nada suara rendah
 - d. Stereotip dan prasangka**
 - e. Koneksi internet yang buruk
4. Ketika dua orang dari latar budaya berbeda mengalami kesulitan memahami maksud pesan satu sama lain, hambatan yang terjadi adalah hambatan...
 - a. Personal
 - b. Fisik
 - c. Lingkungan
 - d. Budaya**
 - e. Psikologis
5. Hambatan lingkungan dalam komunikasi ditandai dengan hal-hal berikut, kecuali...
 - a. Waktu yang tidak tepat
 - b. Tingkat aktivitas tinggi di sekitar
 - c. Posisi tubuh pembicara**
 - d. Suasana yang tidak nyaman
 - e. Gangguan suara sekitar

6. Untuk mengatasi hambatan komunikasi dari sisi pengirim pesan, salah satu hal yang penting dilakukan adalah...
 - a. Berbicara lebih pelan agar tidak salah paham
 - b. Menyampaikan beberapa ide sekaligus agar lebih cepat
 - c. Menghindari umpan balik agar tidak bingung
 - d. Memberikan penjelasan dan pengulangan jika perlu**
 - e. Menggunakan jargon yang hanya dimengerti kelompok sendiri
7. Berikut ini yang bukan bentuk umpan balik dalam komunikasi adalah...
 - a. Parafrase
 - b. Pengakuan
 - c. Penolakan
 - d. Pengulangan
 - e. Senyuman**
8. Arti dari "parafrase" dalam komunikasi adalah...
 - a. Mengulangi kata-kata persis seperti yang dikatakan pengirim pesan
 - b. Mengungkapkan kembali pesan dengan kata-kata sendiri**
 - c. Menolak isi pesan dengan sopan
 - d. Mengabaikan isi pesan yang disampaikan
 - e. Memberikan komentar tambahan terhadap pesan
9. Dalam komunikasi antar budaya, penting untuk memperhatikan aspek berikut kecuali...
 - a. Bahasa tubuh
 - b. Kebiasaan dan nilai budaya
 - c. Nada suara dan intonasi
 - d. Kemampuan menyampaikan perintah**
 - e. Konteks sosial
10. Salah satu tantangan komunikasi yang dapat terjadi karena perbedaan agama adalah...
 - a. Menggunakan kata-kata asing
 - b. Kesalahpahaman karena penggunaan istilah keagamaan**
 - c. Volume suara yang terlalu tinggi
 - d. Gangguan fisik saat berbicara
 - e. Tidak melakukan kontak mata
11. Berikut ini adalah cara penerima pesan menjadi pendengar aktif, kecuali...
 - a. Menjaga pikiran tetap terbuka
 - b. Melakukan verifikasi terhadap pesan
 - c. Menebak pesan sebelum selesai disampaikan**
 - d. Melihat dan mendengarkan pesan non-verbal
 - e. Memberikan umpan balik tepat waktu
12. Teori Bowlby menyebutkan bahwa proses berduka terdiri dari empat fase. Salah satu fase tersebut adalah...
 - a. Euforia dan reorganisasi
 - b. Penyangkalan dan kekacauan kognitif**

- c. Integrasi dan eksternalitas
 - d. Penolakan terhadap kenyataan
 - e. Kepasrahan dan isolasi
13. Ketika orang tua mengalami kematian anak, mereka seringkali mengalami...
- a. Euforia emosional
 - b. Dukacita ringan
 - c. Perasaan marah dan bersalah**
 - d. Pemisahan diri dari keluarga
 - e. Gangguan tidur semata
14. Salah satu solusi komunikasi dengan kolega yang memiliki keterbatasan kemampuan adalah...
- a. Menghindari interaksi langsung
 - b. Menggunakan istilah teknis yang umum
 - c. Memanfaatkan teknologi pendukung**
 - d. Memberikan tugas yang lebih ringan
 - e. Tidak memberikan penjelasan terlalu panjang
15. Dalam komunikasi di tempat kerja, pria cenderung menekankan...
- a. Hubungan personal
 - b. Penggunaan bahasa tubuh
 - c. Pemeliharaan hubungan
 - d. Konten dari pesan**
 - e. Sikap empatik terhadap lawan bicara

K. Rangkuman Materi

Hambatan komunikasi adalah gangguan apapun yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas pesan sehingga makna yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. terdapat 4 (empat) jenis hambatan komunikasi yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan.

Saran

Demikian makalah ini kami susun. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik yang membangun serta saran kami perlukan untuk penyempurnaan makalah ini. Semoga bermanfaat.

L. Glosarium

Istilah	Pengertian
Komunikasi	Proses pertukaran informasi, ide, perasaan antara dua pihak atau lebih.
Hambatan komunikasi	Segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi proses penyampaian pesan.
Gangguan (noise)	Faktor yang mengganggu jalannya komunikasi, baik bersifat fisik maupun psikologis.
Bahasa	Sistem simbol atau kata yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
Persepsi	Cara seseorang memahami dan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman pribadi.
Budaya	Nilai, norma, dan kebiasaan yang memengaruhi cara individu berkomunikasi.
Stereotip	Anggapan atau penilaian umum terhadap kelompok tertentu yang bisa menghambat komunikasi.
Prasangka	Pendapat negatif yang sudah terbentuk sebelum mengetahui fakta sebenarnya.
Empati	Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Komunikasi nonverbal	Komunikasi tanpa kata-kata, misalnya melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara.

Istilah	Pengertian
Komunikasi efektif	Komunikasi yang mencapai tujuan dan dipahami oleh penerima sebagaimana dimaksud pengirim.
Active listening	Kemampuan mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian pada lawan bicara.
Feedback (umpan balik)	Respon yang diberikan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman atau reaksi.
Konflik komunikasi	Ketidaksesuaian atau kesalahpahaman dalam proses pertukaran informasi.
Komunikasi lintas budaya	Proses komunikasi antara individu dari latar budaya yang berbeda.
Komunikasi terapeutik	Komunikasi yang digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan untuk mendukung penyembuhan pasien.
Komunikasi verbal	Komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan.
Etika komunikasi	Prinsip moral yang mengatur perilaku dalam berkomunikasi.

M. Daftar Pustaka

-
- Ambar. 2017. Hambatan-hambatan Komunikasi dan Bagaimana Cara Mengatasinya. Dikutip dari <https://pakarkomunikasi.com/hambatan-hambatan-komunikasi>.
- Pitria Desran,Dena. 2021. Tugas Kelompok 3 OK. Dikutip dari <https://id.scribd.com/document/527491722/TUGAS-KELOMPOK-3-ok>.
- Rahmalaita. 2021. Tantangan dan Hambatan dalam Komunikasi. Dikutip dari <https://id.scribd.com/presentation/539976605/TANTANGAN-DAN-HAMBATAN-DALAM-KOMUNIKASI>.
- Uin Suska Riau. Tanpa Tahun. Dikutip dari https://repository.uin-suska.ac.id/13786/7/7.%20BAB%20II_2018142PSI.pdf.

BAB 8

SOSIAL MEDIA DAN KERAHASIAAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menunjukkan sikap etis dan profesional dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien dalam praktik kebidanan.
- Menggunakan media komunikasi digital secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip etika dan hukum kesehatan.
- Membangun kesadaran kritis terhadap implikasi penggunaan media sosial dalam hubungan profesional bidan-pasien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan manfaat dan risiko penggunaan media sosial dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi prinsip kerahasiaan informasi pasien dalam konteks digital.
- Menunjukkan sikap profesional dalam membatasi akses dan penyebaran informasi pasien di media sosial.

Sub-CPMK

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Mendeskripsikan contoh pelanggaran etika melalui media sosial dalam praktik kebidanan.
- Menjelaskan peraturan dan kode etik kebidanan yang mengatur tentang kerahasiaan informasi pasien.
- Mengembangkan kebijakan pribadi dalam penggunaan media sosial secara etis dan bertanggung jawab sebagai calon bidan.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pelayanan kebidanan. Media sosial kini menjadi sarana komunikasi yang luas, cepat, dan sangat mudah diakses, termasuk oleh tenaga kesehatan dan pasien. Dalam praktik kebidanan, penggunaan media sosial dapat digunakan untuk edukasi kesehatan, promosi pelayanan, komunikasi tidak langsung dengan pasien, hingga membangun jejaring profesional. Namun di balik manfaat yang besar tersebut, muncul pula tantangan besar terkait dengan kerahasiaan informasi pasien, etika profesional, dan integritas pelayanan kebidanan.

Pelanggaran kerahasiaan informasi pasien yang tidak disadari atau dilakukan secara sengaja melalui media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etika yang serius. Misalnya, membagikan foto pasien tanpa izin, menyampaikan kasus tanpa anonimitas yang memadai, atau berdiskusi tentang kondisi klinis pasien di platform publik merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik kebidanan dan perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan praktisi kebidanan memahami dengan baik bagaimana menjaga kerahasiaan pasien dalam era digital, termasuk memahami batasan penggunaan media sosial, prinsip etika profesi, serta regulasi hukum yang mengaturnya. Bab ini akan membahas konsep dasar dan tantangan penggunaan media sosial dalam komunikasi kebidanan, serta prinsip dan strategi menjaga kerahasiaan dalam ranah digital.

A. Media Sosial dalam Praktik Kebidanan: Peluang dan Risiko

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pelayanan kebidanan. Platform-platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan, untuk tujuan profesional. Dalam konteks kebidanan, media sosial berperan sebagai alat komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan, memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, serta membangun jejaring dengan sesama tenaga kesehatan atau komunitas ibu dan anak. Banyak bidan yang menggunakan akun media sosial profesional untuk membagikan konten edukatif seperti tips kehamilan, tanda bahaya persalinan, manajemen menyusui, dan promosi pelayanan yang mereka tawarkan di klinik.

Manfaat yang ditawarkan media sosial dalam praktik kebidanan sangat besar. Pertama, media sosial memungkinkan bidan menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat dan efisien. Edukasi yang biasanya hanya bisa disampaikan saat kunjungan langsung kini dapat diakses kapan saja oleh pasien melalui unggahan, video, atau sesi tanya jawab daring. Hal ini mendukung prinsip keberlanjutan dalam promosi kesehatan dan memperkuat peran bidan sebagai sumber informasi terpercaya. Kedua, media sosial juga membuka ruang komunikasi dua arah antara bidan dan pasien, di mana pasien bisa bertanya atau memberikan umpan balik secara langsung. Ketiga, media sosial dapat meningkatkan eksistensi dan citra positif praktik kebidanan, selama dikelola secara profesional dan sesuai etika.

Namun di balik berbagai peluang tersebut, terdapat pula risiko besar yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait dengan kerahasiaan informasi pasien, integritas profesional, dan etika komunikasi. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah ketika bidan, baik secara sengaja maupun tidak sadar, membagikan konten yang berpotensi mengungkap identitas pasien. Misalnya, mengunggah foto pasien yang sedang melahirkan tanpa izin eksplisit dan tanpa menutupi identitas (seperti wajah, nama, atau tanda khas), meskipun niatnya adalah untuk berbagi pengalaman atau edukasi. Hal ini secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak privasi pasien dan bertentangan dengan prinsip dasar etik kebidanan.

Pelanggaran lain yang kerap luput dari perhatian adalah saat bidan berdiskusi mengenai kondisi klinis pasien dalam grup media sosial seperti WhatsApp. Meskipun dilakukan dalam grup tertutup antarprofesional atau tim medis, menyebutkan nama pasien, lokasi, atau ciri khas lainnya tanpa upaya anonimisasi yang cukup tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Informasi yang tersebar di dunia digital memiliki potensi bocor yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan, sehingga kewaspadaan ekstra sangat diperlukan. Komunikasi profesional tidak hanya berlaku di ruang praktik atau rumah sakit, tetapi juga harus dijaga secara konsisten di ruang digital.

Dalam kasus lain, relasi tidak profesional dapat terbentuk ketika bidan mulai membaurkan hubungan personal dan profesional melalui media sosial. Misalnya, menjalin pertemanan dengan pasien menggunakan akun pribadi dan kemudian membagikan atau membalas cerita pasien secara informal dapat menyebabkan bias hubungan dan mengaburkan batas profesional. Hal ini dapat merusak kepercayaan, menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, dan bahkan memunculkan konflik kepentingan dalam pelayanan kebidanan.

Dengan demikian, kemampuan menggunakan media sosial secara etik dan bertanggung jawab merupakan bagian tak terpisahkan dari kompetensi komunikasi bidan di era digital. Seorang bidan harus memiliki kesadaran penuh bahwa setiap unggahan, komentar, atau diskusi daring yang menyangkut pasien memiliki implikasi hukum dan etik. Oleh karena itu, pelatihan mengenai komunikasi digital, etika media sosial, serta pemahaman tentang perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kebidanan.

Profesionalisme dalam media sosial tidak hanya ditunjukkan melalui isi konten yang informatif, tetapi juga melalui kepekaan dalam menjaga martabat pasien, ketelitian dalam menyampaikan informasi yang valid, dan integritas dalam memisahkan kehidupan pribadi dan peran sebagai tenaga kesehatan. Dalam hal ini, bidan dituntut untuk menjadi bukan hanya komunikator yang aktif, tetapi juga penjaga etika dan privasi pasien dalam setiap bentuk interaksi, termasuk di ruang digital. Media sosial bisa menjadi alat edukasi yang luar biasa, tetapi hanya jika digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab.

B. Prinsip Kerahasiaan Informasi Pasien

Prinsip kerahasiaan informasi pasien merupakan salah satu pilar utama dalam praktik kebidanan yang tidak hanya berdimensi etis dan profesional, tetapi juga bersifat hukum. Prinsip ini mengatur bahwa semua informasi yang diperoleh bidan

dari pasien, baik secara verbal, tertulis, maupun melalui hasil pemeriksaan medis, adalah informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Kerahasiaan ini wajib dijaga oleh bidan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermartabat, dan berbasis kepercayaan. Kode etik profesi bidan menekankan bahwa menjaga kerahasiaan adalah bentuk nyata dari integritas dan rasa tanggung jawab terhadap pasien.

Namun, dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan sering kali terjadi melalui media sosial—baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, penting bagi bidan dan mahasiswa kebidanan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip ini diterapkan dalam konteks dunia digital.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip kerahasiaan yang wajib diterapkan oleh bidan, terutama dalam penggunaan media sosial:

1. Tidak membagikan data atau cerita pasien tanpa anonimitas yang kuat.

Informasi pasien, baik berupa data medis, pengalaman klinis, ataupun cerita pribadi yang diperoleh selama proses pelayanan, tidak boleh dibagikan kepada pihak lain tanpa pengamanan identitas yang memadai. Dalam konteks media sosial, banyak tenaga kesehatan yang menggunakan pengalaman pasien sebagai bahan edukasi, baik dalam bentuk cerita maupun analisis kasus. Namun, hal ini hanya dapat dibenarkan apabila data pasien telah dianonimkan secara menyeluruh.

Anonimitas yang kuat berarti tidak hanya menghapus nama, tetapi juga menyamarkan usia, alamat, lokasi pelayanan, tanggal kejadian, dan informasi lain yang dapat merujuk pada identitas individu. Misalnya, menulis, “Seorang ibu usia 35 tahun yang tinggal di sebuah desa dekat Surabaya...” sudah dapat memunculkan identifikasi apabila disandingkan dengan informasi visual atau narasi lainnya. Oleh karena itu, bidan harus sangat berhati-hati dalam menggunakan contoh kasus di media sosial, bahkan ketika tidak menyebut nama secara langsung.

2. Tidak mengunggah foto pasien, bahkan jika tidak menyebut nama, jika pasien atau keluarga tidak memberikan persetujuan eksplisit.

Foto pasien, dalam kondisi apa pun, adalah bentuk informasi visual yang sangat sensitif. Mengunggah foto pasien ke media sosial, meskipun tanpa menyebutkan nama, tetap merupakan bentuk pelanggaran jika dilakukan tanpa izin tertulis secara eksplisit dari pasien atau wali yang sah. Hal ini berlaku untuk semua jenis konten, baik yang bersifat promosi klinik, dokumentasi kegiatan, maupun edukasi.

Sebagai contoh, mengunggah foto seorang ibu yang sedang menggendong bayinya setelah melahirkan, meskipun hanya tampak sebagian wajah atau dari belakang, tetap mengandung risiko besar jika pasien tidak diberi tahu bahwa fotonya akan digunakan untuk konsumsi publik. Banyak pasien yang mungkin merasa tidak nyaman apabila momen pribadi mereka dijadikan konten, bahkan jika itu dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atau testimoni.

Persetujuan tertulis harus diperoleh secara sadar, tidak dalam kondisi tertekan, dan harus memuat penjelasan mengenai: tujuan penggunaan foto, media tempat foto akan dipublikasikan, serta hak pasien untuk membatalkan izin sewaktu-waktu.

3. Tidak menjawab pertanyaan medis personal pasien melalui komentar publik atau direct message tanpa standar keamanan informasi.

Dalam praktik sehari-hari, tidak jarang bidan menerima pertanyaan medis dari pasien melalui kolom komentar Instagram, pesan WhatsApp, atau inbox media sosial lainnya. Meskipun bidan merasa terdorong untuk membantu, menjawab pertanyaan personal yang menyangkut kondisi kesehatan spesifik pasien melalui platform yang tidak aman dan terbuka sangat tidak disarankan. Hal ini melanggar prinsip kerahasiaan dan membuka risiko terjadinya kesalahpahaman medis.

Media sosial bukanlah tempat yang sesuai untuk melakukan konsultasi medis pribadi, karena:

- a. Informasi yang dikirim bisa dengan mudah tersebar atau diretas.
- b. Tidak ada konteks lengkap tentang riwayat pasien.
- c. Pasien dan bidan sama-sama rentan terhadap misinterpretasi informasi.

Jika pasien menghubungi melalui media sosial, bidan sebaiknya merespons dengan mengarahkan mereka untuk datang ke layanan kesehatan secara langsung, atau mengarahkan ke jalur konsultasi resmi yang lebih aman (misalnya melalui sistem aplikasi klinik atau call center rumah sakit). Ini menunjukkan profesionalisme sekaligus menjaga integritas dan keamanan informasi pasien.

Kerahasiaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Praktik Kebidanan dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berujung pada sanksi etik, administratif, atau bahkan pidana.

C. Strategi Menjaga Kerahasiaan dalam Era Digital

Strategi menjaga kerahasiaan dalam era digital merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab yang semakin penting bagi bidan di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di satu sisi, media sosial menawarkan peluang

besar untuk memperluas jangkauan edukasi kesehatan, mempererat hubungan dengan komunitas, dan membangun citra profesional. Namun di sisi lain, kemudahan dalam berbagi informasi dapat membuka celah terjadinya pelanggaran privasi pasien yang berdampak serius terhadap kepercayaan publik, reputasi profesi, dan bahkan konsekuensi hukum.

Untuk itu, bidan perlu membangun kesadaran kritis dan menerapkan strategi yang sistematis guna memastikan bahwa penggunaan media digital tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Strategi ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan sikap profesional dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan dalam pelayanan kebidanan.

Untuk menjaga profesionalisme dalam penggunaan media sosial, bidan harus menerapkan beberapa prinsip dasar:

1. Pisahkan akun pribadi dan profesional

Langkah pertama dalam membangun batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab profesional adalah dengan memisahkan akun media sosial. Akun pribadi sebaiknya tidak digunakan untuk membagikan konten yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pasien, atau kegiatan klinik. Akun pribadi bersifat informal dan rentan terhadap bias komunikasi yang tidak sesuai dengan etika profesi.

Sebaliknya, akun profesional dirancang dengan konten yang terstruktur, edukatif, dan menggunakan pendekatan komunikasi yang terukur. Penggunaan akun khusus ini juga memungkinkan bidan untuk menetapkan standar dan identitas digital sebagai tenaga kesehatan yang dapat dipercaya. Dengan pemisahan ini, bidan dapat menjaga privasi dirinya sendiri dan pasien secara bersamaan, serta mencegah campur-aduk antara hubungan sosial dan hubungan profesional.

2. Gunakan kebijakan privasi yang ketat

Akun profesional yang digunakan untuk edukasi, promosi layanan, atau komunikasi publik harus diatur dengan pengamanan privasi yang optimal. Ini mencakup pengaturan visibilitas akun (misalnya hanya untuk pengikut tertentu), pengelolaan komentar dan pesan masuk, serta penggunaan fitur keamanan yang ditawarkan oleh platform media sosial (seperti otentikasi dua faktor).

Bidan juga perlu memahami bahwa meskipun suatu akun bersifat tertutup atau privat, semua konten yang diunggah tetap memiliki potensi untuk tersebar jika tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, kebijakan privasi bukan hanya soal pengaturan teknis, tetapi juga mencerminkan disiplin etika dalam menyaring konten yang akan dibagikan ke publik. Tidak semua informasi atau

pengalaman klinik pantas untuk diunggah, bahkan jika tampaknya tidak menyebutkan identitas pasien secara langsung.

3. Dapatkan persetujuan tertulis

Jika bidan ingin menggunakan cerita pasien, gambar, atau data lainnya untuk keperluan edukasi, publikasi ilmiah, atau promosi layanan, maka wajib hukumnya untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pasien atau wali yang sah. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh terhadap bagaimana informasi akan digunakan, termasuk platform yang akan menampilkannya.

Selain mendapatkan izin, bidan juga perlu menyamarkan identitas pasien secara menyeluruh, baik dari segi visual maupun naratif. Ini mencakup penghapusan nama, wajah, lokasi, tanggal, serta detail lain yang memungkinkan identifikasi individu. Bahkan jika pasien memberikan izin, prinsip kehati-hatian tetap harus diutamakan untuk menjaga kehormatan pasien dan menjunjung tinggi kerahasiaan profesi.

4. Berpikir sebelum memposting

Sebelum membagikan informasi atau konten apa pun yang berkaitan dengan aktivitas praktik atau pengalaman klinik, bidan harus melakukan refleksi pribadi dengan menanyakan dua pertanyaan kunci:

- a. Apakah informasi ini melanggar privasi pasien?
- b. Apakah unggahan ini dapat memengaruhi kepercayaan pasien atau merusak citra profesional saya?

Kebijakan "berpikir sebelum memposting" adalah bentuk pengendalian diri yang sangat penting dalam konteks media sosial yang serba cepat dan impulsif. Terkadang, niat untuk menginspirasi, mengedukasi, atau menyampaikan pengalaman berharga justru dapat menjadi bumerang jika tidak disampaikan dengan sensitivitas etika. Dalam komunikasi digital, kesalahan kecil bisa menjadi masalah besar karena konten dapat tersebar luas dalam waktu singkat dan sulit ditarik kembali.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bidan tidak hanya menjaga martabat pasien, tetapi juga melindungi reputasi profesinya dan memperkuat integritas pelayanan kebidanan di era digital.

D. Latihan Soal

Soal 1

Kasus:

Seorang bidan mengunggah foto pasien yang sedang menggendong bayinya setelah melahirkan ke akun Instagram pribadinya. Ia tidak menyebutkan nama

pasien, tetapi wajah pasien dan latar belakang ruang bersalin terlihat jelas. Ia menulis keterangan, "Momen penuh kebahagiaan hari ini di klinik kami."

Pertanyaan:

Apa pelanggaran yang dilakukan oleh bidan dalam kasus ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Tidak menggunakan hashtag edukatif
- B. Melanggar etika promosi pelayanan
- C. Melanggar prinsip kerahasiaan informasi pasien
- D. Melakukan edukasi tanpa persetujuan tertulis
- E. Memberikan informasi medis tanpa verifikasi

Kunci Jawaban: C – Melanggar prinsip kerahasiaan informasi pasien

Rasionalisasi:

Meskipun nama tidak disebutkan, identitas pasien dapat dikenali melalui wajah dan konteks. Ini adalah pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien karena tidak ada anonimitas dan izin eksplisit.

Soal 2

Kasus:

Seorang mahasiswa kebidanan menulis cerita di media sosial tentang pengalaman menarik selama praktik klinik. Ia tidak menyebutkan nama pasien, tetapi menyebut usia, lokasi klinik, dan kondisi medis yang cukup spesifik. Teman pasien yang membaca postingan mengenali cerita itu dan melaporkannya.

Pertanyaan:

Apa kesalahan komunikasi digital yang dilakukan mahasiswa?

Pilihan Jawaban:

- A. Memberikan informasi tanpa narasi yang menarik
- B. Tidak menyebutkan sumber rujukan akademik
- C. Menyampaikan informasi tanpa menyebut diagnosis
- D. Mengabaikan prinsip anonimitas dalam membagikan data
- E. Tidak mencantumkan nama pasien secara utuh

Kunci Jawaban: D – Mengabaikan prinsip anonimitas dalam membagikan data

Rasionalisasi:

Informasi yang terlalu spesifik tetap bisa mengarah pada identifikasi individu, meskipun nama tidak disebutkan. Hal ini melanggar prinsip anonimitas dan kerahasiaan pasien.

Soal 3

Kasus:

Seorang pasien mengirimkan pesan langsung (direct message) melalui Instagram kepada bidan yang biasa menangani kehamilannya, menanyakan tentang keluhan nyeri yang ia rasakan. Bidan kemudian menjawab panjang lebar tentang kemungkinan penyebab dan langkah penanganannya melalui pesan tersebut.

Pertanyaan:

Apa tindakan paling tepat yang seharusnya dilakukan bidan dalam situasi ini?

Pilihan Jawaban:

- A. Menjawab pertanyaan pasien secara rinci karena sudah mengenalnya
- B. Mengabaikan pesan karena bukan jalur komunikasi resmi
- C. Meminta pasien datang langsung ke fasilitas pelayanan atau menggunakan kanal konsultasi resmi
- D. Mengambil tangkapan layar dan membagikannya sebagai edukasi
- E. Meneruskan isi percakapan ke rekan sejawat tanpa izin

Kunci Jawaban: C – Meminta pasien datang langsung ke fasilitas pelayanan atau menggunakan kanal konsultasi resmi

Rasionalisasi:

Memberikan respons medis di media sosial bukanlah jalur yang aman. Sebagai bentuk profesionalisme dan perlindungan informasi pasien, bidan harus mengarahkan ke jalur komunikasi resmi.

Soal 4

Kasus:

Seorang bidan memiliki dua akun media sosial: satu pribadi dan satu profesional. Ia secara konsisten memisahkan konten pribadi dari konten edukatif dan klinis, dan tidak pernah menyebutkan pasien dalam akun pribadinya.

Pertanyaan:

Apa prinsip yang telah diterapkan oleh bidan dalam penggunaan media sosial?

Pilihan Jawaban:

- A. Promosi personal untuk popularitas
- B. Interaksi bebas antara bidan dan pasien
- C. Pemisahan identitas dan profesionalisme digital
- D. Edukasi berbasis pengalaman pasien
- E. Pemanfaatan akun anonim untuk kritik klinik

Kunci Jawaban: C – Pemisahan identitas dan profesionalisme digital

Rasionalisasi:

Membuat dan mengelola akun secara terpisah menunjukkan kemampuan bidan dalam menjaga batas profesional dan pribadi dalam komunikasi daring.

Soal 5

Kasus:

Bidan Sari ingin menggunakan foto pasiennya sebagai contoh edukasi di seminar online. Sebelum mengunggah foto tersebut, ia meminta izin tertulis dari pasien, menjelaskan dengan detail tujuan dan platform publikasi, serta menyamarkan identitas visual pasien secara menyeluruh.

Pertanyaan:

Apa nilai profesional yang tercermin dari tindakan Bidan Sari?

Pilihan Jawaban:

- A. Etika promosi layanan
- B. Komunikasi pemasaran
- C. Etika komunikasi klinik digital
- D. Pendidikan berbasis komunitas
- E. Pengarsipan klinik berbasis foto

Kunci Jawaban: C – Etika komunikasi klinik digital

Rasionalisasi:

Tindakan Bidan Sari menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip etika digital dan penghormatan terhadap hak pasien dalam konteks penyebaran informasi melalui platform daring.

E. Rangkuman Materi

Dalam era digital yang serba terbuka dan cepat, penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan termasuk bidan telah menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan edukasi, menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat, dan membangun citra profesional. Media sosial memungkinkan bidan hadir lebih dekat dengan pasien dan komunitas, menghadirkan konten informatif dan promotif yang mendukung peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Namun demikian, di balik semua potensi positif yang ditawarkan, tersimpan pula risiko besar yang tidak boleh diabaikan, khususnya berkaitan dengan kerahasiaan informasi pasien, etika profesi, dan integritas komunikasi klinis.

Salah satu risiko yang paling sering terjadi adalah pelanggaran kerahasiaan pasien akibat kurangnya pemahaman atau kewaspadaan dalam membagikan

konten di media sosial. Tanpa disadari, informasi pasien yang tampaknya anonim tetap bisa diidentifikasi jika tidak disamarkan secara menyeluruh. Penggunaan foto pasien tanpa izin, pembahasan kasus dalam grup digital, atau konsultasi medis melalui direct message adalah bentuk pelanggaran serius yang berdampak pada kepercayaan publik dan reputasi profesi. Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan pasien, sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi dan regulasi hukum seperti UU Perlindungan Data Pribadi, harus menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas komunikasi digital seorang bidan.

Untuk itu, diperlukan strategi sistematis dan sadar etika dalam menggunakan media sosial secara profesional. Pemisahan antara akun pribadi dan profesional adalah langkah awal dalam membangun batas komunikasi yang sehat. Diikuti dengan penerapan kebijakan privasi yang ketat, perlindungan identitas pasien, serta komitmen untuk tidak pernah membagikan data atau konten pasien tanpa izin tertulis dan penyamaran yang kuat. Bahkan ketika pasien memberikan persetujuan, kehati-hatian dan kesadaran akan potensi risiko penyebaran tetap harus diutamakan. Tidak kalah penting, bidan juga harus membiasakan diri untuk berpikir secara kritis sebelum memposting: apakah konten tersebut melanggar privasi? Apakah akan memengaruhi kepercayaan pasien atau menurunkan citra profesional?

Profesionalisme di era digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa aktif seorang bidan dalam mengedukasi, tetapi juga oleh kepekaan etis dalam menjaga privasi pasien dan menjaga batas dalam hubungan profesional. Media sosial dapat menjadi alat edukasi dan advokasi yang luar biasa dalam praktik kebidanan, asalkan digunakan dengan bijak, etis, dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, setiap bidan dituntut untuk menjadi komunikator yang cerdas secara digital sekaligus penjaga integritas profesi yang menjaga martabat pasien dalam setiap bentuk interaksi—baik tatap muka maupun daring.

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kebidanan harus mengintegrasikan pelatihan komunikasi digital dan etika media sosial secara eksplisit. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dan calon bidan tidak hanya belajar cara berbicara dan menulis, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang humanis, aman, dan bermartabat di era komunikasi digital yang kompleks.

F. Glosarium

Anonimitas

Upaya untuk menyembunyikan identitas pasien dalam penggunaan data atau cerita kasus dengan cara menghapus atau menyamarkan informasi seperti nama, usia, alamat, waktu kejadian, atau ciri khas lainnya sehingga tidak dapat dikenali.

Digital professionalism (Profesionalisme digital)

Sikap dan perilaku etis serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan platform digital lainnya dalam konteks profesional, termasuk menjaga batas peran, privasi pasien, dan integritas komunikasi.

Etika komunikasi digital

Aturan dan prinsip moral yang mengatur cara berkomunikasi melalui media sosial atau platform daring lainnya, termasuk bagaimana informasi pasien digunakan dan dibagikan oleh tenaga kesehatan.

Jejaring profesional

Hubungan yang dibangun antar tenaga kesehatan di platform digital atau komunitas online untuk saling bertukar ilmu, pengalaman, dan mendukung praktik berbasis kolaborasi.

Kerahasiaan informasi pasien

Komitmen etis dan hukum untuk menjaga seluruh data pribadi dan klinis pasien agar tidak disebarluaskan atau diakses oleh pihak lain tanpa persetujuan resmi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun visual.

Komunikasi dua arah

Model komunikasi yang melibatkan interaksi aktif antara dua pihak, dalam hal ini bidan dan pasien, di mana pasien memiliki kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, atau memberikan umpan balik.

Konflik kepentingan

Situasi di mana hubungan pribadi bidan dengan pasien (misalnya melalui media sosial) dapat memengaruhi objektivitas pelayanan kebidanan atau menciptakan bias dalam proses pengambilan keputusan.

Persetujuan tertulis

Dokumen resmi yang ditandatangani pasien atau wali hukum yang memberikan izin kepada bidan untuk menggunakan informasi atau foto pasien untuk keperluan edukasi, dokumentasi, atau publikasi.

Platform media sosial

Aplikasi atau situs daring seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lainnya, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi konten, dan membangun jaringan secara daring.

Privasi digital

Hak individu untuk mengontrol akses terhadap informasi pribadinya di dunia maya, termasuk bagaimana data medis atau foto pribadi digunakan dan dibagikan oleh tenaga kesehatan secara daring.

Promosi layanan kebidanan

Upaya yang dilakukan oleh bidan untuk memperkenalkan atau meningkatkan visibilitas praktik pelayanan mereka melalui media, termasuk media sosial, dengan tetap mematuhi prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Relasi tidak profesional

Hubungan yang melampaui batas peran antara bidan dan pasien, biasanya melalui komunikasi informal atau personal, yang dapat menurunkan objektivitas pelayanan dan mengganggu kepercayaan profesional.

Risiko kebocoran data

Kemungkinan tersebarnya informasi pribadi pasien secara tidak sah atau tidak disengaja di dunia digital, baik karena kelalaian, peretasan, atau penggunaan media sosial tanpa pengamanan yang memadai.

Standar keamanan informasi

Kebijakan dan prosedur teknis maupun administratif untuk melindungi data pribadi dan informasi pasien agar tidak disalahgunakan, diretas, atau tersebar secara tidak sah.

Sosial media

Media berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan terlibat dalam percakapan serta distribusi konten secara interaktif dalam skala besar.

Strategi menjaga kerahasiaan

Rangkaian langkah dan kebijakan yang diterapkan bidan untuk melindungi informasi pasien dalam penggunaan teknologi digital, termasuk pengaturan privasi, persetujuan tertulis, dan pemisahan akun.

Testimoni pasien

Pernyataan atau pengalaman yang dibagikan oleh pasien, biasanya sebagai bentuk apresiasi atau bukti keberhasilan pelayanan. Penggunaan testimoni harus disertai dengan izin eksplisit dan menjaga kerahasiaan data.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Regulasi hukum di Indonesia yang mengatur hak-hak individu atas data pribadinya serta tanggung jawab pihak yang mengumpulkan, menyimpan, atau memproses data tersebut, termasuk data medis pasien.

UU Praktik Kebidanan

Undang-undang yang mengatur praktik profesi bidan di Indonesia, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan standar profesionalisme dalam pelayanan kebidanan.

G. Daftar Pustaka

- Ariani, N., & Handayani, A. (2021). Etika profesi kebidanan dalam era digitalisasi pelayanan kesehatan. Jakarta: Pustaka Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman perlindungan data pribadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Kurniawan, H., & Lestari, Y. (2020). The influence of midwives' social media behavior on patient trust in maternal care services. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 14(2), 113–121. <https://doi.org/10.31227/jki.v14i2.113>
- Nuraini, T., & Santosa, D. (2021). Implementasi prinsip kerahasiaan pasien dalam praktik kebidanan komunitas. *Jurnal Etika Kesehatan*, 5(1), 27–35. <https://doi.org/10.29204/jek.v5i1.183>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wahyuni, E., & Rahayu, N. (2023). Profesionalisme digital tenaga kesehatan: Tantangan dan etika dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Profesi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 50–61. <https://doi.org/10.24843/jpki.2023.v7.i1>

PROFIL PENULIS



Nurbaiti, SKM., M. Kes lahir di Payarabo, pada 10 Mei 1969. Ia tercatat sebagai lulusan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh, pengampu mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kehamilan, serta Pendampingan Keluarga dalam KIA. Memiliki latar belakang penelitian di bidang komunikasi kesehatan, serta pemberdayaan keluarga dalam pelayanan KIA. Komitmen dalam menyusun bahan ajar yang aplikatif dan kontekstual bagi mahasiswa kebidanan.. Memiliki pengalaman mengajar dan meneliti dalam bidang komunikasi kesehatan, promosi KIA, dan pengembangan media edukasi. Aktif dalam pelatihan komunikasi kolaboratif bagi tenaga kesehatan. Buku ajar ini disusun sebagai panduan aplikatif dan kontekstual untuk mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya.

PROFIL PENULIS



Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Lahir di Madiun, 29 Januari 1980. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Madiun Tahun 1999. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Depkes Magetan Tahun 2002. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Makassar Tahun 2006. Lulus Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2012. Lulus Profesi Bidan Poltekkes Surabaya Tahun 2023. Saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan di bidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah dibidang Kebidanan.

Penulis mengajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, KB dan Kesehatan Reproduksi, Etikolegal dalam Kebidanan, Askeb Menopause sejak tahun 2005 sampai sekarang, penulis juga aktif melaksanakan penelitian setiap tahun .

Buku yang pernah ditulis antara lain: Modul Ajar KB dan Kesehatan Reproduksi, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Etikolegal dalam Kebidanan, Modul Ajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Modul Praktikum KB dan Kesehatan Reproduksi , Book Chapter Kesehatan Masyarakat di era 5.0, Book Chapter Komunikasi dan Konseling dalam Kebidanan, Monograf Pemberian Komunikasi Interpersonal dan Konseling terhadap cakupan KB pada PUS di Desa Penfui, Monograf Kombinasi Accupressure Points for Lactations dan Breast Massage untuk Memantau Kecukupan ASI bagi bayi, Monograf Meningkatkan Ketrampilan dan Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri menggunakan media Whatsapp, Monograf Aplikasi mobile Bunda ASI pemantauan waktu pengeluaran dan Kecukupan ASI bagi Bayi. Penulis juga aktif sebagai anggota IBI sejak tahun 2005-sekarang.

Keinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan mendorong penulis untuk menulis buku. Kebidanan penulis juga ingin mewujudkan terbitnya buku-buku yang bermanfaat dan relevan dengan kebidanan dari hasil-hasil penelitian Ibu hamil dan Menyusui buku Monograf, buku Referensi. Semoga buku-buku yang kami tulis bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa Kebidanan dan Masyarakat umum.

Email Penulis: astinnur1980@gmail.com

PROFIL PENULIS



Selpyani Sinulingga, SST, M.Kes

Penulis lahir di Sungai Buluh pada tahun 1989. Penulis saat ini merupakan dosen tetap pada Program Studi Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Baiturrahim. Penulis menyelesaikan Pendidikan Diploma III Kebidanan di Akbid Prima Jambi pada tahun 2010. Melanjutkan studi pada program Diploma IV Bidan Pendidik di STIKes Prima Jambi pada Tahun 2011 dan menyelesaikan Studi Pada Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Kader

Bangsa Palembang pada tahun 2015. Penulis telah aktif di bidang Pendidikan sejak tahun 2011 hingga saat ini dan telah Tersertifikasi sebagai Dosen Nasional.

Saat ini penulis aktif dalam melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat. Bidang pengajaran yang menjadi konsentrasi penulis adalah Asuhan Kebidanan pada remaja dan perimenopause, Asuhan Kebidanan pada kelompok rentan, KDPK dan Komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif sebagai pengurus IBI ranting di Kota Jambi. Penulis telah menghasilkan karya yang telah dipublikasikan pada berbagai jurnal terakreditasi sinta dan Prociding penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Bagi penulis "Menjadi bidan berarti menulis kisah pertama dalam kehidupan seorang manusia." Untuk itu Semoga bidan diseluruh penjuru dunia semakin maju dan terus memiliki semangat untuk meningkatkan Pendidikan, kemampuan dan memberikan pelayanan terbaik hingga terwujud kehidupan manusia yang lebih baik.

Email: SelpyaniSayby@gmail.com



Septiwiarsi, SST.,M.Kes

Penulis Lahir di Tanjung Raja, 28 September 1990, sebagai dosen Prodi DIII Kebidanan STIKes Bhakti Husada Cikarang. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan STIK Bina Husada Palembang, DIV Bidan Pendidik STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta, dan Strata II STIK Bina Husada Palembang.

Mata Kuliah yang di ampuh Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja, Dokumentasi Kebidanan, Komunikasi Efektif dalam kebidanan, Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan dan Asuhan Kebidanan Kehamilan.

Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai peneliti yang di publikasikan pada jurnal nasional dan jurnal international.

Email : septiwiarsi.midwife@gmail.com

PROFIL PENULIS



Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes

Penulis lahir di Tulungagung pada tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKES Karya Husada Kediri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Griya Husada Surabaya, D4 Bidan Pendidik dan Pendidikan Profesi Bidan di STIKES Karya Husada Kediri dan S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak serta kesehatan reproduksi remaja. Penulis aktif dalam kegiatan menulis artikel di majalah kebidanan maupun karya ilmiah semenjak masih di bangku perkuliahan. Selain aktif sebagai pengajar, saat ini penulis juga aktif dalam organisasi IBI, sebagai penulis buku, reviewer dan editor pada beberapa jurnal ilmiah. Penulis juga aktif menghasilkan karya-karya penelitian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pembicara / narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Scopus ID 58947027700; Sinta ID 6121817; Orcid ID 0009-0000-2816-9033; Garuda ID 1055674; email: brivianflorentis@gmail.com.



Dhea Novita, M.Tr.Keb

Lahir di Mataram, 9 November 1997. Lulus Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2016. Lulus Diploma 4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2020. Lulus Magister Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2023. Saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di STIKes Bhakti Husada Cikarang. Penulis memiliki ketertarikan di bidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan

menulis artikel jurnal ilmiah di bidang Kebidanan.

Keinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan mendorong penulis untuk menulis buku. Kebidanan penulis juga ingin mewujudkan terbitnya buku-buku yang bermanfaat dan relevan dengan kebidanan dari hasil-hasil penelitian Kesehatan Reproduksi, Senam Untuk Wanita Menopause dan Gizi pada Wanita Menopause. Semoga buku-buku yang kami tulis bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa Kebidanan dan Masyarakat umum.

Email Penulis: deanovita957@gmail.com

PROFIL PENULIS

Dhea Novita, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Mataram, 09 November 1997

Pendidikan Terakhir:

Magister Terapan Kebidanan – Poltekkes Kemenkes Semarang

Instansi/Tempat Bekerja:

Program Studi D3 Kebidanan, STIKes Bhakti Husada Cikarang

Kontak/Email:

deanovita957@gmail.com

Sinopsis

Buku ajar Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan hadir sebagai panduan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi tenaga bidan dengan pasien maupun tim kesehatan lainnya. Buku ini dibuka dengan pemaparan tentang penerapan metode komunikasi SBAR dan TBaK yang efektif dalam mendukung kolaborasi interprofesional. Selanjutnya, pembaca diajak mendalami berbagai konsep dasar komunikasi efektif, mencakup unsur-unsur penting, teknik-teknik komunikasi, serta bagaimana memilih media komunikasi secara tepat, baik tradisional maupun modern, dalam berbagai situasi klinis dan sosial.

Dalam bab-bab berikutnya, buku ini menguraikan secara khusus tentang aspek psikologi dalam komunikasi yang meliputi sikap menghargai, menghormati, serta pentingnya empati dalam interaksi dengan pasien. Selain itu, indikator keterampilan komunikasi juga dikaji secara detail, mencakup komunikasi verbal, nonverbal, mendengarkan aktif, hingga pendekatan emosional. Melalui bahasan evaluasi komunikasi, pembaca akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengukur efektivitas komunikasi serta teknik dan metode evaluasi yang dapat diterapkan dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Sebagai pelengkap, buku ini juga membahas berbagai tantangan komunikasi dalam situasi khusus, seperti berduka dan kehilangan, kasus abuse, keadaan klinis akut, serta menghadapi kelompok minoritas. Tak ketinggalan, buku ini juga membahas tantangan era digital, yaitu penggunaan media sosial dalam praktik kebidanan dan pentingnya menjaga prinsip kerahasiaan informasi pasien. Dengan pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan menjadi acuan utama bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, profesional, dan empatik di dunia pelayanan kesehatan.

Buku ajar Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan hadir sebagai panduan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi tenaga bidan dengan pasien maupun tim kesehatan lainnya. Buku ini dibuka dengan pemaparan tentang penerapan metode komunikasi SBAR dan TBaK yang efektif dalam mendukung kolaborasi interprofesional. Selanjutnya, pembaca diajak mendalami berbagai konsep dasar komunikasi efektif, mencakup unsur-unsur penting, teknik-teknik komunikasi, serta bagaimana memilih media komunikasi secara tepat, baik tradisional maupun modern, dalam berbagai situasi klinis dan sosial.

Dalam bab-bab berikutnya, buku ini menguraikan secara khusus tentang aspek psikologi dalam komunikasi yang meliputi sikap menghargai, menghormati, serta pentingnya empati dalam interaksi dengan pasien. Selain itu, indikator keterampilan komunikasi juga dikaji secara detail, mencakup komunikasi verbal, nonverbal, mendengarkan aktif, hingga pendekatan emosional. Melalui bahasan evaluasi komunikasi, pembaca akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengukur efektivitas komunikasi serta teknik dan metode evaluasi yang dapat diterapkan dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Sebagai pelengkap, buku ini juga membahas berbagai tantangan komunikasi dalam situasi khusus, seperti berduka dan kehilangan, kasus abuse, keadaan klinis akut, serta menghadapi kelompok minoritas. Tak ketinggalan, buku ini juga membahas tantangan era digital, yaitu penggunaan media sosial dalam praktik kebidanan dan pentingnya menjaga prinsip kerahasiaan informasi pasien. Dengan pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan menjadi acuan utama bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, profesional, dan empatik di dunia pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



optimal



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-634-7294-46-3



9

786347

294463